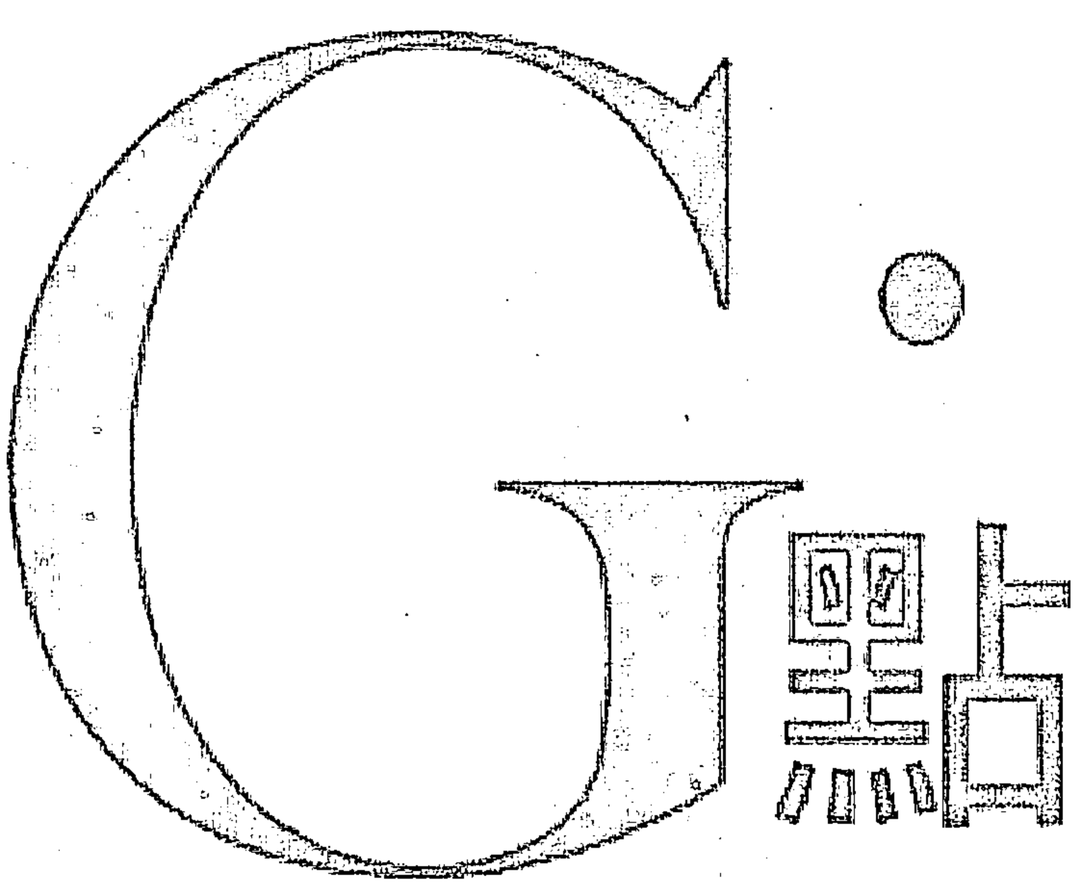
原水文化

# The G Spot:

## And Other Discoverics about Human Sexuality



# 重新探索女性性高潮 30年經典版

## 美國3大性學權威


B.愛絲・卡恩・拉達斯 Alice Kahn Ladas

比佛利・惠普 Beverly Whipple　約翰・戴伯特・培瑞 John D. Perry ——合著

E國國會山人類性學高級研究院性醫學博士

E維醫學大學醫學系婦產學科教授

E巫儀 ——審訂

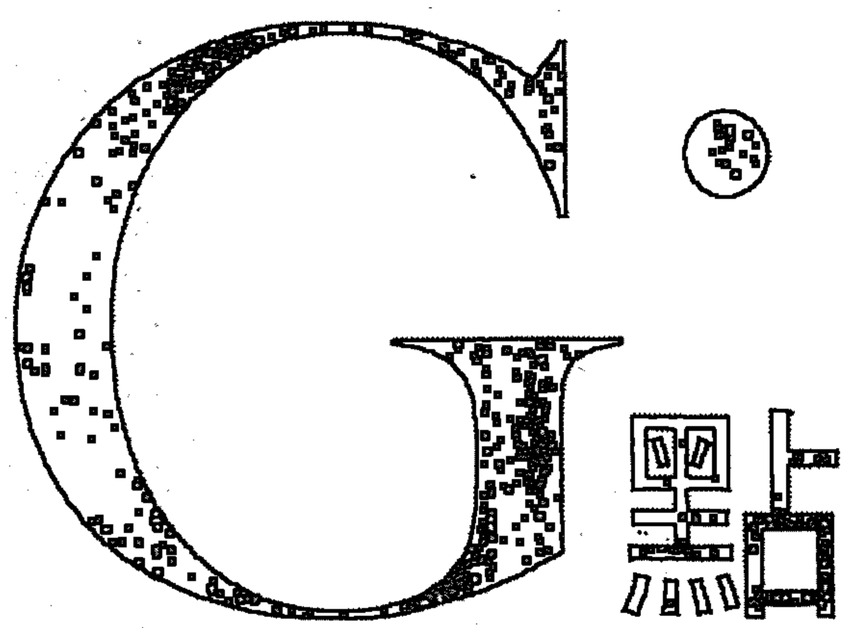
竹傑明 ——譯


**這是第一本以臨床實證證實G點位置的書籍，**
**書中許多實用資訊，幫大家認識這個常被誤解的女性情慾地帶。**

E論這本革命性的著作，可幫助你如何使你和伴侶體會女性的性，
享有相互的性伴侶進入的上昇快的新境界世界。

# The G Spot:

## And Other Discoveries about Human Sexuality



# 重新探索女性性高潮


**美國3大性學權威**

愛麗絲・卡恩・拉達斯 Alice Kahn Ladas
比佛利・惠普 Beverly Whipple
約翰・戴伯特・培瑞 John D. Perr ——合著

鄭丞傑——審訂

許傑明——譯

專家推薦

精神狀態失衡、四分之三的離婚和遺棄，都得怪罪忽視人體解剖構造而引起的生理異常……。我們許多對一般性經驗和正常性生活的認知，是以臆測為基礎，不會比一般大眾的印象和零散的歷史穩固到哪裡去。

——羅勃·狄更生醫師（Robert L. Dickinson）
婦科專家、性研究先驅

在一個資訊爆炸和日新月異的時代，要不了幾年，一本書就會過時。《G點》這本書卻是一個美好的例外。它在四分之一世紀前問世，但卻一直啟發讀者，令讀者感到驚喜。大多數人都聽過G點，卻沒什麼人知道它是什麼？在哪裡？到底存不存在？本書在幾十年前第一次將G點介紹給一般大



眾，時至今日，G點仍是一個被誤解的性敏感區，本書仍是了解G點的不二選擇。對性愛有興趣的人，本書不只能引起你的興趣，還能讓你獲益良多。

——丹尼斯．撒格魯博士（Dennis P. Sugrue）
美國性教育者、諮商師與治療師協會前任主席
合著有《女人性事》（*Sex Matters for Women*）

《G點》結合性功能科學與感官滿足研究，是本經得起時間考驗的不朽著作。本書不只帶領女性與夫妻、情侶體驗G點刺激，解釋女性射精，開啟人們視野；最棒的是，書中有許多觀察入微的閨房祕事，引導讀者如何親身體驗。閱讀本書，學習身為女人最獨特最自然的性愛歡愉。

——盧．佩傑（Lou Paget）
著有《完美性愛高手》（*How to Give Her Absolute Pleasure*）

南。對無數經歷女性射精，懷疑自己有問題的女性來說，更是一種解脫。

《G點》一書不只突破現有的性生理學知識，也是床邊實用的性反應指

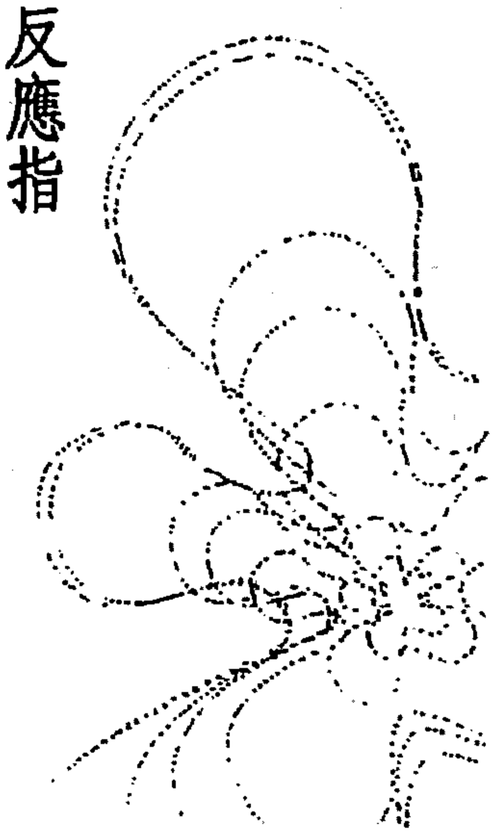
——威廉・史戴頓（William R. Stayton）威德納大學（Widener University）人類性學學程主任

本書將女性自我報告的親身經歷，作為女性健康的研究開端，是所有關心性健康女士的必備讀物。

——菲莉絲・格林柏格（Phyllis Greenberger）女性健康研究學會總裁暨執行長

書中提供實用、經過實證的資訊，歷久彌新。女性應該和性伴侶探索、建立屬於自己的美滿性愛。

——馮恩・布勞（Vern L. Bullough）《臥房科學》（*Science of Bedroom*）作者



一

《G點》一書，可說是我每天夫妻諮商工作的總整理，沒有它我不知如何工作。本書中的資訊和觀念，不只是成為性愛專家的基礎，嘗試G點刺激更能激發性伴侶間的性愛能量。向拉達斯、惠普與培瑞三位作者致上最高謝意。

——拉娜．霍斯汀（Lana Holstein）

《銷魂長週末》（*Your Long Erotic Weekend*）作者

# 目錄 Contents


審訂序 重新認識女性性高潮 010

推薦序 將女人從性束縛中解放 016

前言 融合既有認知與新發現 022

第一章 陰道高潮與陰蒂高潮的新融合 027

引起性學研究者注意的觀點並非新理論，跟其他領域的科學發現一樣，發表後大家視而不見，包括：G點、女性射精、骨盆肌肉和持續的高潮反應。

融合了陰道高潮還是陰蒂高潮，在這裡集大成。

第二章 G點 063

我們可以在沿著尿道的陰道前壁上找到一個性敏感部位，……這裡被像陰莖海綿體的勃起組織包圍……。

這個性敏感部位在高潮頂峰時，會充血腫脹到最大。最敏感的部位應該在尿道末端，與膀胱交接的膀胱頸處。

第三章 女性射精 099

第一次射精時，我根本不敢相信，因為我從來不曾發生過尿失禁，也總是在性行為前上廁所。

不過，不論如何，我的伴侶和我都沒有因此而受影響，畢竟性愛的歡愉戰勝了負面的想法。

第四章 骨盆肌肉健康的重要性 135

這塊肌肉的專門術語叫做恥骨骶骨肌，也有人稱之為「性愛肌」。

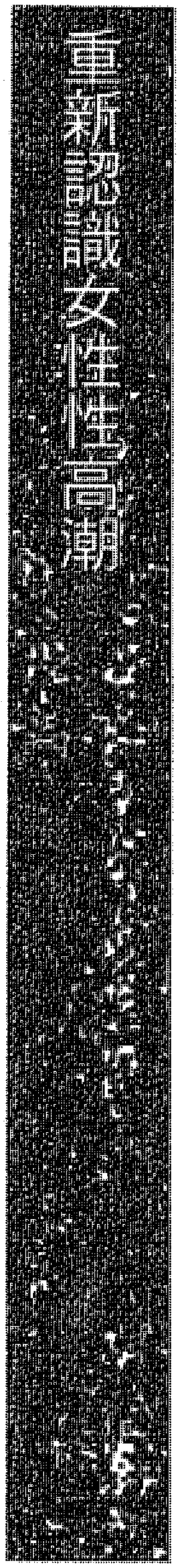
恥骨骶骨肌越健康，可有效刺激G點，就越能享受激情愉悅的性關係。

第五章 持續的高潮反應 187
性愛是由陰道開始，牽動全身，但最後合而為一個高潮。
一些女性在連續刺激G點時，可以有「多次射精高潮」。

第六章 完美不見得會更好 219
我們呈現的事實，是性高潮經驗的各種面向，例如我們希望會射精的女性知道這是一種自然反應，應該盡情享受。
書中的知識不應該形成非得照做不可的壓力。不射精的女性，也應接受事實，不要拚命想射精，也不用擔心自己不射精，就會讓自己或性伴侶喪失性愛中某些重要的樂趣。

附錄 《女性和生物能量分析》的摘要、表格與結論 253
這份研究報告的對象為一九七七年生物能量分析學會針對全體女性會員共一百九十八位，寄出問卷後回收一百三十四份有效問卷。
問卷題目涵蓋領域包括性觀念、經驗與習慣。問卷以異性戀觀點出發。

致謝 269




〈審訂序〉

◎鄭丞傑

很多人可能聽過「G點」一詞，但多數人都是不知其詳，可是又充滿了好奇心。由於研究性學，我早在一九八三年開始擔任婦產科醫師，開始知道凱格爾運動（Kegel exercise）之後，就在醫學文獻中，查到了發現G點的德國婦產科醫師葛瑞芬柏格（Gräfenberg）在一九五〇年發表的原著論文，也聽說一九八二年左右，有三位心理學者共同出版了一本叫做《G點》的書，詳細闡述了葛瑞芬柏格當年不受醫學界重視的發現，這才引起了全球的注意。

一九九〇年代，我熱心投入性教育，在二〇〇一至二〇〇五年之間，經常出國參加國際的學術研討會，



也因而認識了世界性健康學會（World Association for Sexual Health）的副會長，惠普博士（Dr. Beverly Whipple）。二〇〇四年她應邀來台參加第二屆亞洲性教育研討會，並發表論文時，她送我一九八二年和另兩位學者共同出版的英文書《G點》，這下子我才發現原來她就是二十多年前發表了震驚全球的新觀點「G點」的三位作者之一，而且原來早在一九九〇年左右台灣即已出現了中譯本，只可惜當時並未引起大家注意，連我也不知道有此一書。

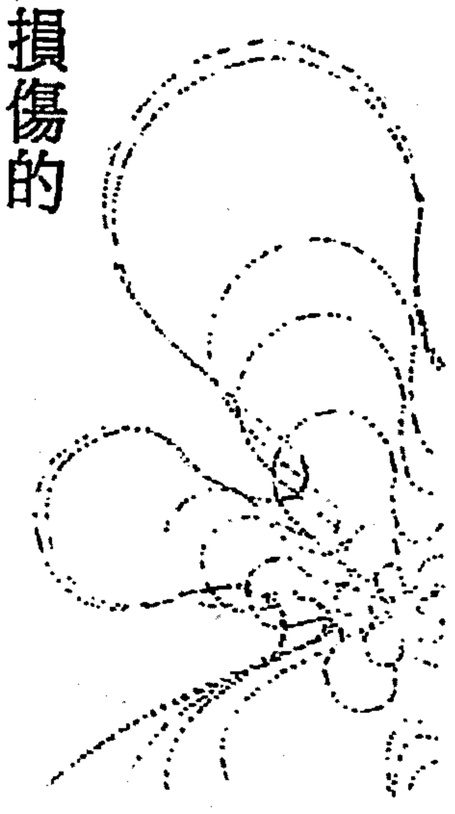
當時，惠普博士告訴我，她正在改寫《G點》，我去台北福華飯店探望她時，也的確看到她帶著手稿，在旅途中修改，當時她說估計二〇〇五年會出版，我就先告訴她，別忘了上市時寄給我一本書，我會設法促成中譯本的上市，因此我找了城邦出版集團的林小鈴總編輯，她聽了我對這本書的推崇之後，立即答應找人翻譯，然後再給我審訂過，因此這本中譯版的面市，我其實有如同自己的書出版般的濃郁感情。

惠普博士是美國紐澤西州羅格斯大學（Rutgers University）著名的神經生物學家，她發表了許多有關性功能的神經學研究，即使已經六十多歲，她在

二十一世紀初期，都還發表了一些實驗證明的論文，證明即使是脊髓損傷的患者，經過足夠的性刺激，也可以產生性高潮，因此她的研究團隊認為人類的骨盆腔性感覺神經傳導除了經由脊髓之外，還有其他的路徑，這真是劃時代的發現！

而惠普博士和另兩位學者愛麗絲・卡恩・拉達斯（Alice Kahn Ladas）及約翰・戴伯特・培瑞（John Delbert Perry）在一九八二年出版，二〇〇五年改版的《G點》則不但是改變由金賽（Kinsey）和馬特斯（Masters）與強生（Johnson）以來對女性性解剖與性高潮的一些固有想法，同時也是一本難得的通俗科普著作。

這本《G點》主要在探討「G點的存在」、「女性射精」、「凱格爾運動」和「女性性高潮的新觀點」，看似老生常談，但事實上由於婦產科醫學界至今對性醫學的認知仍相當有限，多數婦產科醫師也不太了解這些問題的正確知識，因而常易給婦女朋友錯誤的指導乃至不必要的手術，這在先進國家如美國，也不例外，從這本書中不少的案例也可以了解，因此這本書不但適



合所有的成年男女閱讀，事實上專業的醫師和性諮商、性教育人員同樣需要好好研讀，才能對求診的婦女做正確的處置。

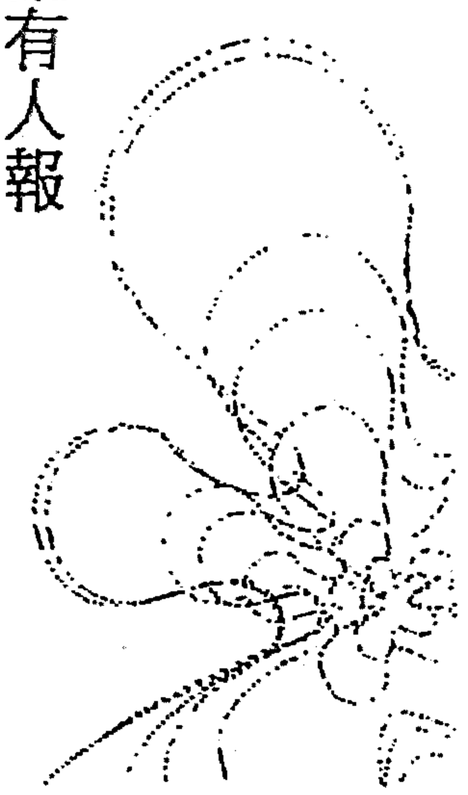
我在美國舊金山攻讀性醫學博士時，看過有關「女性射精」的研究錄影帶，有趣的是有些人只射出幾西西，有些人竟然射出數百西西，我始終懷疑後者是尿失禁，但是經過成分的分析，卻都和尿液大不相同。而如果我們思考一下「G點」是攝護腺的遺跡，則即使男性射精，也不過二到六西西，女性即使有未完全萎縮的攝護腺「G點」，也不大可能一次射出六西西以上的分泌物，因此，即使臨床上也不少婦女告訴我，她們在性高潮時會從尿道射出一些液體，我還是懷疑數十乃至數百西西的射出液，恐怕仍是尿失禁才合理。這部分的研究，西方一直有人在進行，希望未來能有更清楚的釐清。

至於G點本身，其實二〇〇〇年在巴黎召開的「世界性學大會」（後來在二〇〇五年起改為「世界性健康大會」）中，已有一位病理學家發表論文表示，他在解剖屍體時，找到了和男性攝護腺構造相同的「G點」。也有人懷疑如果女性身上真的有攝護腺遺跡，則應該會有女人罹患攝護腺癌，正如

同男人也有人罹患乳癌一樣，因此我曾就此請教惠普博士，她說的確有人報告過女性「G點」的「攝護腺癌」，不過恐怕男性乳房萎縮沒有女性攝護腺萎縮那麼厲害（每個男人都還有乳頭呢！），所以癌症的發生率也不一樣吧？這也是一個值得再研究的課題。

關於凱格爾運動，這是本書中唯一多數婦產科醫師比較熟悉的，不過大部分婦產科醫師對應力性尿失禁的婦女，建議用這個提肛運動來改善症狀，卻不知道這個運動可以促進性高潮，更促進女性射精的機率！另外，我在臨床上處理不少各地醫師轉介來的陰道痙攣症患者，也教她們認識這個運動，然後教她們反其道而行，亦即放鬆恥骨骶骨肌，才有機會治好陰道痙攣症。

有關女性高潮，從佛洛伊德以為「陰蒂高潮是幼稚的，陰道高潮才是成熟的」，到金賽和馬斯特與強生都主張「陰蒂」才是高潮的主要來源，如今多數醫師皆已深信陰蒂是超級性感帶，陰道不那麼重要。但事實上「G點」這本書的三位作者告訴大家，陰道前壁的G點，也是超級性感帶，而且某些婦女可能陰蒂不太敏感，G點卻十分敏感，如果她本人和性伴侶未能察覺出

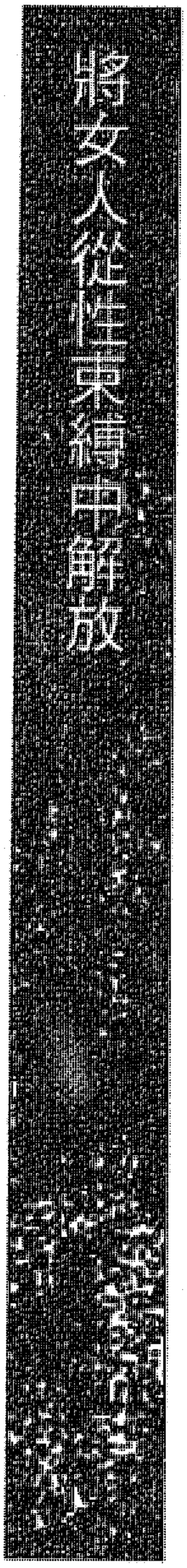


本書新觀細閱

來，則她可能被歸入「性冷感」，乃至產生破碎的婚姻。因此大家從這中，仔細領略各種不同的女性性高潮，相信有助於幸福的婚姻。

這是一本難得的性學好書，它提供了有關女性性解剖和性生理的點，值得所有的專業人士，以及所有希望追求美滿性生活的成年男女仔讀並身體力行。

〈推薦序〉




一

這本書在一九八二年初版時，揭開了一場性學革命。它帶領女性性慾研究進入新時代，徹底改變性治療的常規，更對數以千計女性的生活產生影響。回顧前一世紀中葉，我們不難了解本書為何帶來如此重大的衝擊。從演化的角度來看，性行為只有一個目的：繁衍下一代。在許多不同的文化、不同的國家中，傳宗接代的重要性大於一切。即使當像金賽博士（Alfred Kinsey）這樣的學者，開始精確觀察紀錄人類行性為時，女人的性反應還是被視為與男性的模式相同。

性學研究者威廉・馬斯特（William Masters）與維吉尼亞・強生（Virginia Johnson）發展出性反應循環（sexual response cycle），再加上心理學家海倫・



辛格・開普蘭（Helen Singer Kaplan）詳細詮釋後，性反應可以分成以下幾個階段：性慾、興奮、高潮、消退。女性的性反應也是如此，不一樣的人就會被歸為異常。

二十世紀初期，佛洛伊德曾提出成熟女性的性快感集中在陰道。他認為陰蒂就是長不大的陰莖，來自刺激陰蒂的高潮是幼稚而不成熟的。數十年來，大家奉為圭臬，但包括金賽、馬斯特、強生等學者卻提出反駁。他們認為，陰蒂是許多女性性快感的主要來源，且陰蒂高潮和陰道高潮在生理學上來說，根本就是同一件事。

本書在一九八二年問市後，事情不一樣了。是什麼樣的研究方法造成這種革命性的轉變？其實很簡單，作者訪問女性，請她們描述性愛時的感受，嘗試從女性的觀點出發，找出女人的性滿足，而不是告訴女人她們應該有什麼樣的感覺。他們不再依照男性經驗建立的模式，假設女性符合這些模式；而是依照女性的經驗，建立屬於女人的用語。

作者的發現開創性學研究的新頁。他們發現女性的反應相當多元，因人而異，不再堅持於建立單一模式。對某些女性而言，陰蒂是無上性歡愉的核

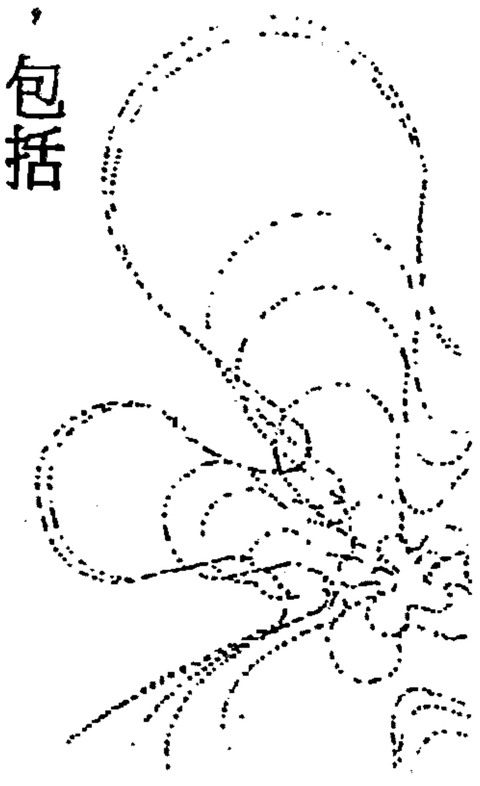
心，但對其他女性而言，陰道才能帶來快感。女性可以體驗多次高潮，包括陰蒂、陰道，或結合兩者。

培瑞與惠普，以及日後惠普和可米沙魯克透過精密的研究，確認女性性經驗的多樣性，過去從沒有人可以做到。簡而言之，他們發現女人的性反應，因人而異，沒有統一的模式，事實上，女性可以決定不從生殖器上獲得性快感，對她們來說，這樣也很好。

## 一

一，是女性描述的經驗，讓性學研究者再次發現陰道前壁也是女性性感點之瑞芬柏格（Ernst Gräfenberg）在一九五〇年發表的研究報告中，首次描述陰道前壁這個部位，卻未引起重視。培瑞和惠普稱這個部位為「葛瑞芬柏格點」，簡稱「G點」。刺激G點引發性高潮的快感，與早期學者聲稱的陰蒂高潮理論衝突，因此再次發現和接納G點的理論，可說是開啟女性性快感研究的新頁。

作者的第二個貢獻是確認女性射精現象。亞里斯多德和羅馬學者蓋倫（Galen）在西元二世紀都曾描述過女性射精的現象。或許女性射精不是為



了傳宗接代，這些古代醫師的報告，漸漸被科學和醫學著作淹沒而消失。本書作者培瑞和惠普發現一些女性在高潮時，尿道會噴出液體，類似亞里斯多德著作的描述。這些液體看來像是稀釋過的牛奶，帶有甜味。化學分析顯示，雖是尿道中排出的液體，成分卻與男性攝護腺相近，反而不像尿液。

我第一次讀這本書時，還是個正在讀研究所的婦科住院醫師，除了十分欽佩外，更為了醫學教育中，竟然缺少女性生理和性學這個重要的觀點，而感到惶恐。當年認為女性射精是性行為時的尿失禁，不斷有女性接受手術校正，我還記得讀到許多讓我覺得悲哀的個案研究。

本書的出版後，許多學者陸續證實一些女人的確會在性交和高潮時，分泌與尿液不同的液體，並支持女性攝護腺存在的說法。許多女性不再需要手術去除射精這種愉悅的正常現象，更是本書的一大成就。

我十分景仰作者在書中一五一十詳述研究結果。他們的目標不是只將性經驗的滿足提升到另一層次；也強調在性經驗上不能一味要求完美。

也就是說，某些女性會有多次高潮和射精，不代表每人都會有；讀者更

不應該因為沒有射精和多次高潮而感到失望。換個角度來看，本書敘述的是女人從性束縛中解放的故事。

此外，本書也主張「享樂的性」，認為性不全是「目標取向」。每個人都是獨特的個體，以不同的方式在性行為時得到滿足，因此女性應敞開心胸，擁抱和享受所有的歡愉。

自從這本書出版後，幾十年來惠普博士繼續深入探尋女人的性。許多惠普與可米沙魯克的研究都指出，在陰道前壁施壓，受試女性的疼痛閾值（pain threshold，指個體所能辨認的最小疼痛體驗。也就是個體能感知到疼痛的最小刺激強度），比控制組提高百分之四十七。若刺激陰道前壁時受試者產生快感，此時疼痛閾值增加百分之一〇七，這種疼痛緩解的效果，跟自然分娩時的感覺差不多。

其他研究則發現過去認為不可能的神經傳導路徑，其實也行得通，帶給脊椎損傷的女性患者一線希望。惠普博士主張，刺激陰道前壁、子宮頸和其他高敏感部位可以獲得高潮。但惠普、歐格登（Ogden）、可米沙魯克最具啟發性的新研究應該是女性能不能單靠想像，沒有任何生理刺激就獲得高

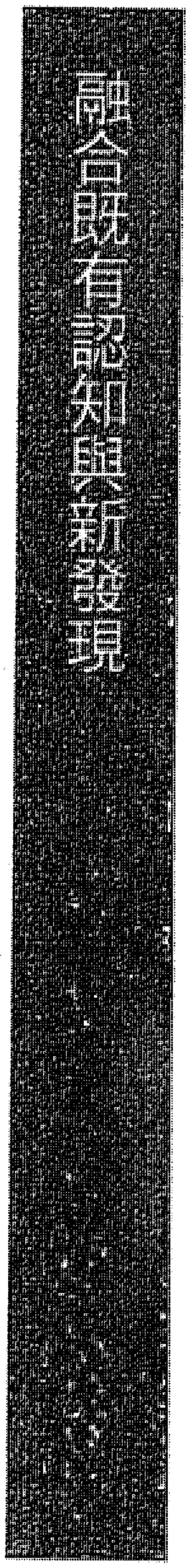


潮。這可能會迫使性學研究者重新思考，一向以男性中心定義的女性高潮。

本書極為珍貴，不只讓我得到許多性知識，也表達我對二十多年行醫生涯中數千位婦女的崇高敬意。你也可從這本書獲得許多啟發，你將發現許多積極、實證的資訊，讓你擁有健康、歡愉的性生活。

請切記，性是一場無上的歡愉盛宴，親吻、按摩、愛撫、觸摸、口交和幻想都可帶來快感和滿足。想要開發性愛潛能，必須和性伴侶溝通，探索性的滿足。請享受、讚美你個人獨一無二的性經驗，因為它們都是生命中健康、正常的一部分。

本文作者為美國紐約哥倫比亞大學長老會醫學中心女性性健康中心主任，著有《G點魔法書》（*What Your Mother Never Told You about Sex*）






本書介紹許多重要的新發現，這對我們了解人類的「性」有舉足輕重的影響。我們相信，書中的資訊可以幫助數以百萬計的男女，避免不必要的痛苦和挫折，在生活上獲得喜悅和滿足。

書中有許多資訊早被發現，卻因為與文化衝突或不為科學界接受，找不到彼此的關連性和意義，而被長期忽視和排拒。達爾文曾說：「事實是沒有價值的，除非事實可以解釋或駁斥某些觀點。」這裡所呈現的事實，在考量人類性行為的理解。

這不是一本關於愛的書，不討論人與人間的關係，更不解決雖會影響生活，但早晚會消失的情緒問題。首先，這本書不是萬靈丹，可以解決所有人類可能遭遇的性問題。但另一方面，書中提到的事實甚至指出，女人和男人

在性方面的相似度，超乎大家之前的想像。這或許可以幫大家更了解人類性行為，掃除人與人間的障礙。

一百年前，佛洛伊德以「黑暗大陸」形容女人的性慾，這本書的發現，可說是揭開佛洛伊德「黑暗大陸」神祕面紗的重要一步，其實女性的性慾不是佛洛伊德形容的如此黑暗而難以理解，未來也需要更多的研究證實。無論這些發現與信仰、習慣及態度彼此是一致或衝突，你的反應和行為都會受到影響。

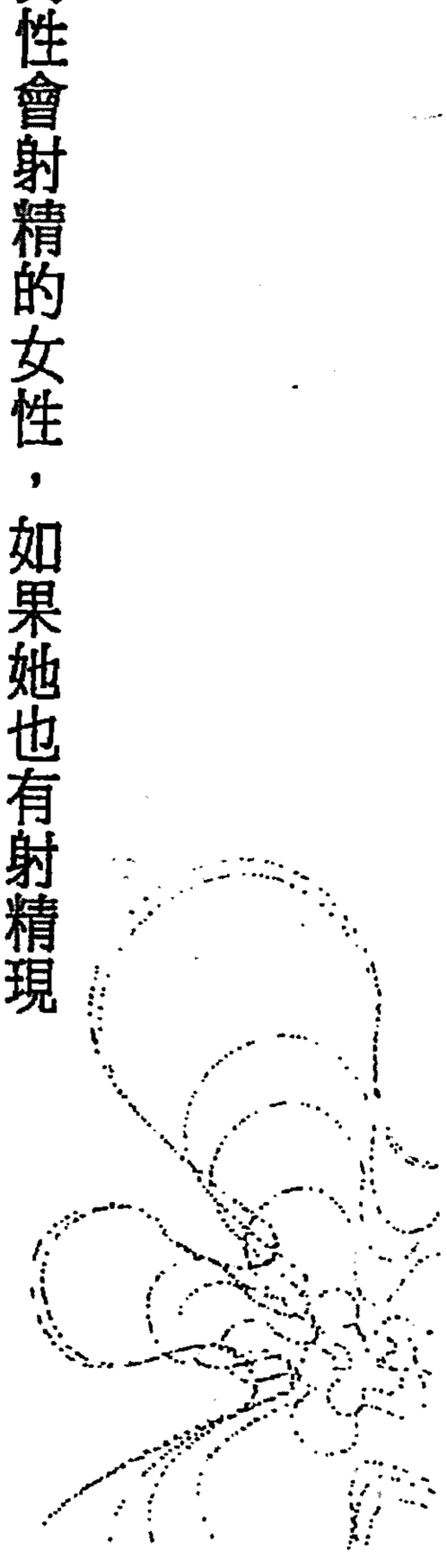
我不期待所有人都可以無條件接受我們的說法，更不奢望大家都會照著去做。我們只希望大家可以根據經驗思考、驗證，運用在適合的地方。甚至反對也沒有關係，也希望能經過科學嚴謹的驗證。這本書的主要訴求對象並非學術圈，而是對性學感興趣的讀者。如想更進一步探索科學性證據、或技術性資訊的讀者，也可參閱附錄。

理論上，這些資訊可以單獨思考；但實務上，不能與個人及社會脈絡分開。本書也希望能支持許多為了遵守加諸在身上對性的成見，而否定自己身體感覺的讀者。

舉例來說，有位從小被教導只有男性會射精的女性，如果她也有射精現象，她會自認自己不是異常就是病了，甚至是身體有缺陷。閱讀本書可以充分支持她的經驗並非異常，如果有人跟她一起讀這本書更好。研究顯示，只要有人支持，就可以幫助個體對抗團體壓力。

其他人的意見對我們會產生影響，尤其當他們反對時，會使我們焦慮。焦慮會讓身體產生令人不快的生理反應，雖然表現的方式有個別差異，但焦慮會影響自律神經系統的功能，以及與自律神經緊密相連的性行為。過去三十年，女性性學研究的各家學說有不少矛盾和衝突，這些矛盾衝突的說法造成混淆，當這個混淆又與我們生活中最私密的性有關時，更容易讓人焦慮不安。

寫這本書的主要目的之一就是希望降低既有認知與新發現間的衝突，盡可能相互融合，讓大家都能認識了解這新資訊。我們不希望這些新訊息，使人對性行為上的表現，有新的或更多的要求，而形成「性學奧運」。萬一因此引發焦慮不安，絕非我們所樂見。我們的發現證實性經驗的多變，更駁斥這幾年來引起苦惱與爭辯的正統學說。唯有不斷嘗試，才能找出理想的性行



為模式，想要繼續下去，無論你選擇那一條路，我們都希望你能運用本書中提供的資訊，增加樂趣，重拾自我肯定的感覺。

# 第一章

# 陰道高潮與陰蒂高潮的新融合

然而引起性學研究者注意的觀點並非新理論，跟其他領域的科學發現一樣，發表後大家視而不見，包括：G點、女性射精、骨盆肌肉和持續的高潮反應。整合佛洛伊德與其他性學研究者的發現，成為容易又一致的理論。矛盾衝突在這裡獲得解決。融合了陰道高潮還是陰蒂高潮，在這裡集大成。

性學新知，震驚、改變了世界，影響的層面，遠超乎我們的理解。他們的學說，形塑我們的態度，影響我們的行為，改變我們的生活。然而，他們的發現、理論互相矛盾，留給世人進退兩難的困境。佛洛伊德告訴我們，成熟女人是陰道反應的動物，應該放棄幼稚的陰蒂關注。但金賽和他的研究人員，馬斯特與強生，卻斬釘截鐵的保證，女人的高潮包括陰蒂高潮，更是喚起女性性慾的關鍵。

一九二十世紀，「性」在西方歷史上，第一次被當成一門正統學問研究。但這個新的研究領域上，重要學者提出的見解彼此對立的情形下，這是如何辦到的？各家學說南轅北轍，又如何落實科學實證研究？

其實擔心這些對大眾每日生活影響不大的問題，似乎有點不食人間煙火，先讓我們了解一下瓊安的困擾，這可說是一九四〇和五〇年代年輕女性的典型範例。

瓊安在二次世界大戰的混亂時期，迎接二十一歲的來臨。她跟一些男



人約會過，但最吸引她的是一個海軍上尉。這位上尉自願參加在大西洋沿岸的獵殺潛艇任務。一個週末，上尉休假上岸時，瓊安獻出初夜。

互通激情的情書一段時間後，在上尉再次休假上岸時，兩人在海軍牧師的福證下，在安納波里斯完婚。瓊安育有兩子，一個是在先生海上服役時出生，另一個則在戰後出生。一家人與另一對類似情形下結婚的夫妻，在華盛頓分租一間公寓。

但瓊安的婚姻生活糟透了，當丈夫是海軍上尉時，體面又稱頭；但退役後卻是一個投機的賭徒。這樣的生活完全出乎瓊安預料，她找心理分析師幫忙，就這樣持續六年，瓊安不只離婚，還深信自己的床上功夫有問題。因為除了獻出初夜的那個週末外，在這段婚姻裡，瓊安在與丈夫做愛時，從來沒有經歷過高潮，還曾因此被丈夫奚落。

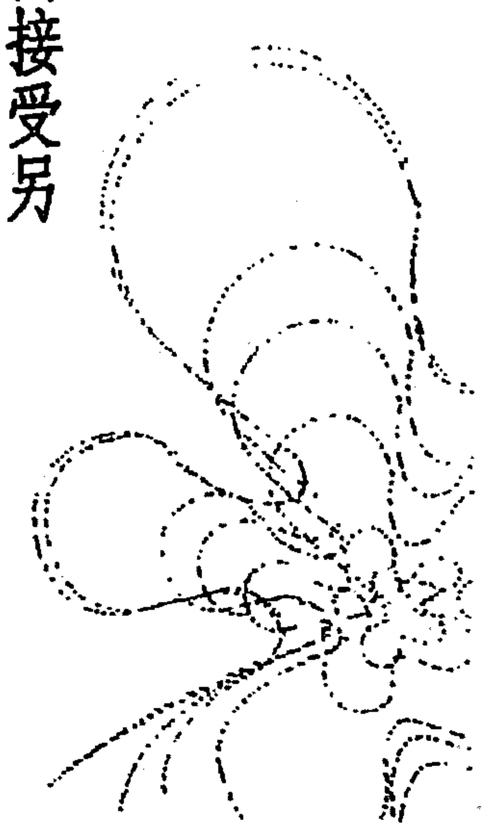
分析師告訴她，這是一種自我抑制的標記，也可能以其他方式表現，結果把事情弄得更糟。瓊安知道手淫可以帶來高潮，但因為分析師和丈夫不斷強化她內心的恐懼，瓊安覺得要求丈夫配合她「不成熟」的要求來取悅她是一種錯誤的行為。

一位三十年後，直到瓊安因為失去愛人，陷入輕微的憂鬱症中，而接受另到愉悅的性愛。為了說服自己克服不成熟和不適當，瓊安花了大半輩子否定她的性慾。

很多像瓊安這樣的女人，都曾遇過佛洛伊德派的心理分析師，但也有數以千計的人，在潛移默化中受到佛洛伊德信徒的影響而不自知。佛洛伊德的學說像水一樣滲入各種文化層面中，他的概念，更成了日常生活用語。

「或許她潛意識（unconsciously）鎖上門」，「他很自我（ego）」，「他只愛他媽，有戀母情結（oedipus）」，「小心，你露出真面目（id）了。」我們一天到晚聽到不同的人說出這些話。

到鳳凰城的診所求助的瑪蓮妮正好與瓊安成對比。六〇年代瑪蓮妮開始有性生活，當時披頭四以「天空中佩戴鑽石的露茜」（Lucy in the Sky with Diamonds）這首歌，歌頌迷幻藥的美好。年輕人喊著「要性愛不要戰爭」的口號，馬斯特與強生正在實驗室裡，藉著直接觀察性行為，撰寫他們革命性的著作。



維多利亞時代的人認為，幾乎每件與「性」有關的事，在社會學和心理學中仍被分類在「犯罪偏差」中，還名列前茅。可是當我們談到六〇年代，你不需擔心這些，該把這些舊思想徹底拋到腦後。

瑪蓮妮生長在加州紅杉林裡的一個社區，她以就地取材的方式，嘗試過裸露身體及體驗素食生活，集體雜交派對也是她眾多的實驗之一。她愛上了男友，兩人同居六個月後才結婚。她跟諮商員說：「這不公平，我覺得我不正常。照理說，我應該很享受他撫摸或是親吻我陰部的感覺，但我卻不喜歡。我不喜歡口交，我甚至不喜歡他的陰莖碰到我的陰蒂，我喜歡的做愛方式是從後面插入，激烈而頻繁的抽動，這樣是不是錯得很離譜？而且我覺得我以錯誤的方式太快達到高潮，不正常。」

瑪蓮妮因為她不喜歡陰蒂刺激而覺得自己不正常，瓊安卻正好相反。兩位女性的恐懼，就算不是兩派人氣理論相互衝突造成，也是因它們一直盤據而無法消失。過去三十年，我們之中有許多人活在這種矛盾中，都被弄糊塗

了。為了幫助大家了解這種兩極化的差異從何而來，讓我們更深入的檢視佛洛伊德學派與其他性學研究者互相牴觸的起因，又是誰在旁搧風點火，造成這些歧異。

一百年前，社會上還不能接受公開討論性和性的樂趣。嘗試研究性學的科學家，都會被同儕投以懷疑的眼光，而且他們也擔心自己的聲譽因此受到傷害，其實我們現在也面臨類似的問題。維多利亞主義（Victorianism）雖然曾被一位作家描寫成為「性衰弱疾病」，但在當時卻是當紅顯學。維多利亞時期，的確曾出現一些相當著名的春宮畫，描繪性愛享樂的情景，但艾克頓爵士（Lord Acton）的一席話，最能忠實呈現當時的價值觀。他說：「社會樂於將女人把性的感覺丟在一邊，或視為汙穢的中傷。」從主流觀點來看，缺乏性慾反而是真女人的重要條件。下面一八四〇年代賢妻良母手冊中這一段話，清楚說明女人在維多利亞時代的功能：

> 女人被賦予的特殊任務多為在床邊耐心服侍病人、照顧牙牙學語，不會走路的嬰兒、跟年輕人溝通知識的要義、帶著微笑安慰以淚洗面的朋友。



至於女人性伴侶角色則輕描淡寫的一筆帶過。

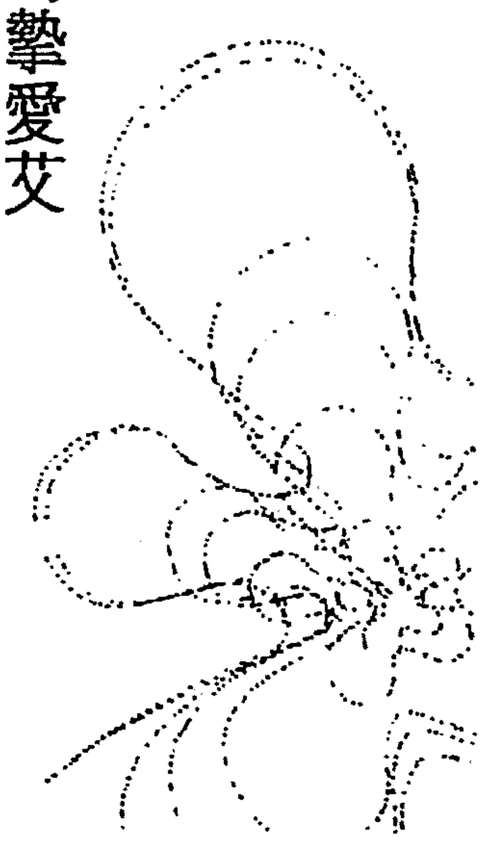
維多利亞女王彰顯鼓吹這樣的想法，且積極的阻擋女人進入專業領域，特別是醫學。維多利亞時代期望女人成為賢妻良母。吉爾伯特與蘇利文（Gilbert and Sullivan）的輕歌劇劇本中有許多角色，就是描寫沒有男人依靠的老女人，沒有社會地位，又失去經濟來源的可悲處境。佛洛伊德的同事，德國神經心理學家理查范克拉夫特艾賓（Richard von Krafft-Ebing），在性病理學方面著墨甚深，認為性慾本身是一種令人避之惟恐不及的疾病，他是這樣描寫女性的：

一個精神正常、教養良好的女人，對性的渴望很低。如果不是這樣的話，這世界會變成一個妓院，不可能有婚姻和家庭。所以，躲著女人的男人，和倒追男人的女人都是不正常的。

這樣的時空背景，對探索男人的性本能是一種鼓勵，把女人置之不理，而這也正是佛洛伊德的主要貢獻之一。

伯特（Albert）後的十六年。佛洛伊德四歲時，全家搬到維也納，他也在這個偉大的文化之都接受教育。為了養活妻兒，他放棄了實驗室的工作，自己開業，成為一位精神病理學家。他在八十歲時曾經這樣描述：

佛洛伊德一八五六年在捷克出生，正好是維多利亞女王嫁給她的摯愛艾



在潛意識和精神心靈、直覺衝動等方面，我有一些重要的新發現。這些發現可以發展成「精神分析」的新學派，這是心理學的一部分，也是治療精神官能症的新方法，我花了很多心血才有這點幸運的收獲。許多人不相信，厭惡我的理論，強烈抗拒我的發現。

佛洛伊德的研究震驚了西方世界，許多將他排除在外的學術社團，開始接納他，視他為改革者。他挑戰人是理性的主流概念，主張「原慾」（libido）主導許多人類行為。他拿人的心靈與冰山相較，大部分在海面下看不見。他說，心靈大部分是潛意識且無理性，表現出來的只有前意識（preconscious）與意識（conscious）。佛洛伊德堅持，潛意識大部分都與性有關，對生活的影

響比理性的部分更為重要，我們只是騙自己事實恰好相反而已。

他教導諸商師治療病人的新方法，例如，多聽病人的聯想、夢境，做為了解和幫助病人的一種方法。他喚起大家注意幼年時，與小時候與周圍人事物互動的重要性。他率先提出童年性慾的說法，賦予「三歲看大，五歲看老」新的意義，因而獲得學界敬重。

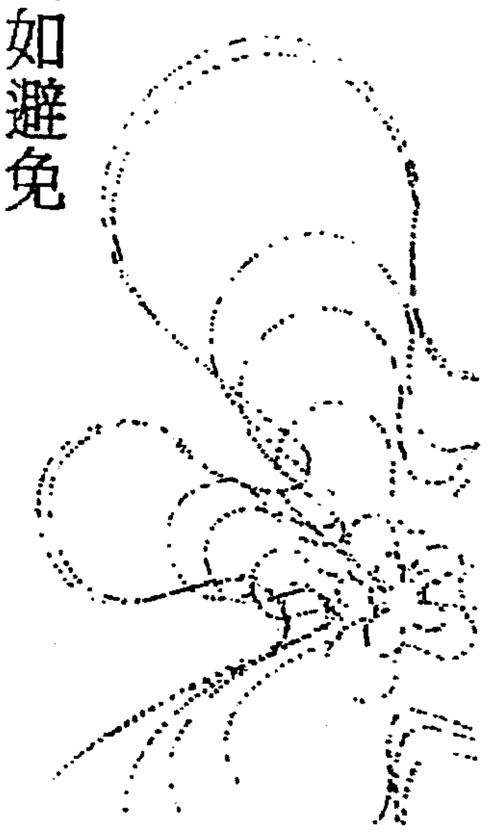
除了許多影響深遠的學術貢獻外，他也教我們許多關於人性和性慾的事。雖然不是每個人都認同佛洛伊德和他的信徒提出的理論，例如他主要的理論之一，「戀母情結」（Oedipus complex，又稱「伊底帕斯情結」）。簡而言之，戀母情結是指孩童視母親為第一個性對象，無論男孩或女孩，長大後，都以母親為戀愛對象的原型。

當小男孩進入「性器期」初次體驗陰莖的快感時，就渴望成為母親的性對象，取代父親。因為父親比較強壯，男孩知道註定失敗。此外，他也需要父親養育。同時，母親試著阻止小男孩手淫，如果她失敗，她會威脅男孩說，如果繼續這個壞習慣，會有「壞事」發生。假設男孩不經意看到女人沒有陰莖，就會聯想閹割就是手淫的懲罰，形成「閹割焦慮」。

閹割的自我肯定恐懼（a fear of self-assertion）；相反的也可能採取攻擊策略以保護自己，而反抗權威。也可能因為害怕父親而過度依賴母親，嫌棄女性，甚至兩種情緒都會產生。日後也可能導致同性戀或選擇不婚。這些情緒都沉睡在男孩的潛意識中，會反應在日後的生活事件中，當男孩進入青春期、長大成人，也會出現干擾他的性向。

至於女孩，佛洛伊德認為是完全不同的演進過程。女孩沒有陰莖，沒有「陽具妒羨」（penis envy）。她「閹割焦慮」，反而嫉妒男孩有陰莖，產生「陽具妒羨」（penis envy）。她會試著模仿男孩，持續下去就變成同性戀。或者她會試著彌補自己不足，發展出佛洛伊德所謂的「正常女性特質」——被動、順從與依賴。另一個問題是，女孩會氣母親給她一個殘缺不全的身體，佛洛伊德稱這種態度為「戀父情結」（Electra complex）。女孩會想取代母親的地位，與父親在一起。當然人會盡全力壓抑這些感覺，不讓它們回到意識裡。

佛洛伊德學派的人認為，有許多人抗拒這些怪異而令人反感的感覺，因此要分辨出到底是反抗潛意識深處壓抑的情緒，還是因為不是事實而抗拒，



是件相當複雜而具挑戰性的任務。

在女性是次等、人類的原型應為男性的假設基礎上，佛洛伊德繼續發展女性性學的相關理論，創造一種所謂的文化觀點，多年以後仍深刻影響像瓊安一樣的女性。

他說，陰蒂就像突出的「男性」器官，是退化的、次等的陰莖。比陰道更容易接近，女孩探索自己身體時，陰蒂就容易最先被發現。佛洛伊德的理論認為，女孩要長大成女人，必須放棄對陰蒂孩子氣的興趣，轉化成專注在陰道帶來的快感上。因為陰道是接受陰莖的器官，女人天生就是用來接受包容男人的。這就成為知名的「陰蒂—陰道轉移理論」（clitoral-vaginal transfer theory）。

許多佛洛伊德學說，至今依然令人信服。事實上，他被認為是最具有創造力的心理學大師之一。我們站在偉人的肩上看未來，要批評，很容易；但這不是我們的目的。不過，撇開佛洛伊德偉大的貢獻，他的確也犯了不少錯。這些錯誤與他的研究方法受限及他的自我意識有關，而且一些在社會心理學上與人類學上的發現，也影響佛洛伊德學派相當深遠。

許多佛洛伊德早已意識到自己對女性性學的了解

有限，希望未來有一天能由女性分析家多著墨。他說：「如果你想更了解女性，你必須從質問自己的經驗下手，或向詩人求助，或等科學帶給你更多深入及一致性的資訊。」

就像我們一樣，佛洛伊德也被自己的潛意識影響，可能跟他自己個人特殊背景和家族史有關，也或許跟他是在父親絕對權威的環境中成長有關。當時，談論男人性行為的空間，要比討論女性歡愉的空間要大得多吧！

佛洛伊德科學研究的方法要為他革命性的理論與錯誤負責。他是根據自己個人與臨床看診的經驗寫出精神分析學的原理；換言之，是他對自己想法、感覺的自省，也是他個人對病患病情的觀察與解釋。許多新佛洛伊德學派學者仍堅信，若沒有類似他的觀察，沒有立場批評他的觀點。

靠著深入研究少數的診所病人，佛洛伊德發展出許多理論。這群人有能力付錢接受佛洛伊德許多新的療法，無法代表當時大多數住在維也納的人，更設不上能代表全人類了。相反的，人類學家瑪格麗特．米德（Margaret Mead）在數十個不同社會中，研究一般人的性行為，她告訴我們不同文化的人，做事的方法也不同，這是相當珍貴的一課。她也提醒我們：認為「我們」



的方式是唯一「正確」的想法相當狹隘。

佛洛伊德和他的門徒不批判當時的社會，他們接受維多利亞時代男至上的觀念。此外，一開始他們的行動吸引傑出且具生產力的女性。佛洛德的信徒中，不乏影響後世的學者，但只有早期的少數人，膽敢挑戰父權想；剩下的人則只是想辦法把她們個人的性經驗，與其他女性病人的經驗進佛洛伊德打造的模子裡而已。

唯一的例外是凱倫．荷妮醫師（Karen Horney），她最早從一九二四年開始挑戰佛洛伊德的許多假說。雖然佛洛伊德承認他對女性性學的理解可有限，但他還是毫不留情的批評不同的觀點。一九二一開始他容忍荷妮醫師與他大逕庭的看法，但到一九三八年，他宣稱「一個女性分析師無法充分確信自己陽具的渴望，對病人而言可說是失職。」

為什麼佛洛伊德說出這樣的話？一九二〇年中期，荷妮開始研究女性理學，在一些觀點上與佛洛伊德展開辯論。與佛洛伊德不同的是，荷妮意到當時的文化是：女人被強迫依照男人的喜好改變自己，而且這些改變還認為是女性真我的投射。她說，母性是女人在生理上的優勢，令男人嫉妒

。被識心　對相能就　套思伊性

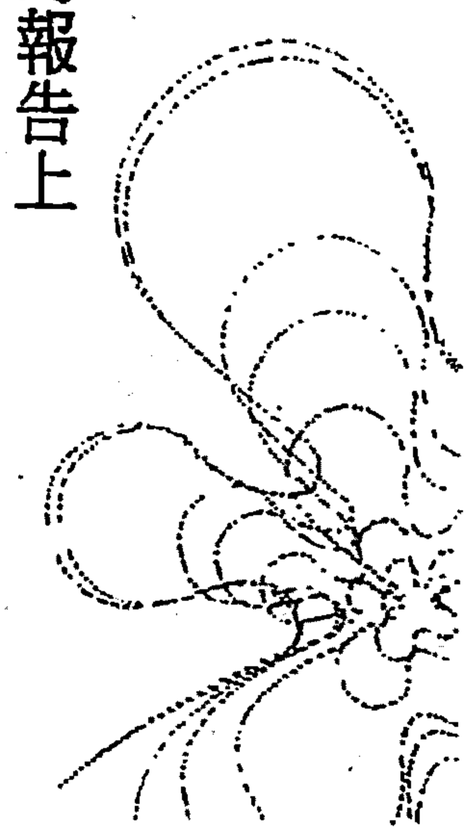
她也認為陰道和陰蒂是同等重要的女性生殖器官。她在一九二六年的報告上下了結論：

……我主要的目的……是想指出性觀察者犯錯的原因，同時往前邁進……超越父權或女權的出發點。

一

當荷妮以非猶太人的身分逃離希特勒統治的德國，到美國尋求庇護時，她喜歡從文化脈絡中觀察事情的習慣，受到文化人類學家露絲．本多（Ruth Benedict）和瑪格麗特．米德，以及心理學家哈利．史達克．蘇利文（Harry Stack Sullivan）很深的影響。荷妮開始認為精神官能症是社會和生理因素交互作用的結果。荷妮理論重視文化的影響，而米德領先時代潮流的著作，也支持她摒棄生理結構即命運的想法。

荷妮熟識強調角色學習的許多美國的心理學家，幫助她解釋觀察到的文化差異。米德認為，高潮是學習而來的反應，任何一個文化都會影響女人達到高潮的能力。例如，新幾內亞的孟都古摩族（Mundugumor）相信女人有



高潮，但奧拉帕西族（Arapesh）的人卻不相信。孟都古摩族的女性多半會有高潮；奧拉帕西科的女人沒有高潮。高潮的能力牽涉許多文化學習反應。女人需要知道性反應的生理方位，而且必須接受適當的刺激，才能展現高潮。這種與生俱來的能力。只有在相信女性高潮的社會中，才會教女人許多有效的技巧，讓她們能夠學習如何達到性高潮。本書中介紹性刺激反應的相關「新」資訊，正好與這個觀點不謀而合。

直到一九五〇年代，生理學家金賽博士（Dr. Alfred Charles Kinsey）展開美國文化中男女性習慣的量化研究，學者也開始意識到性行為的多樣性。金賽博士研究結果之一就是正式挑戰佛洛伊德的「陰蒂—陰道轉移理論」。換言之，金賽的研究發現數百萬女性曾經體驗過陰蒂帶來的快感，卻很少曝光。

缺乏量化應用的科學無法進步，因此為了客觀，即使像性學這種難以啟齒的科學，也需要研究計算大量樣本。金賽不只引進量化研究，他在其他的科學研究上曾用過統計學，因此在人類性學的研究，他再次有效精確的運用統計。佛洛伊德不是真的了解如何有效使用統計數據，或如何針對研究對象設計實驗，因此不少學者利用實驗和統計驗證，發現許多佛洛伊德研究的謬誤。

官能症（actual neurosis）的原因之一，但他從來沒有研究過沒用保險套卻也有相同困擾的人。就如性歷史學家愛德華．布瑞契（Edward Brecher）觀察，「偶爾統計也會出錯，不用統計的人卻更常犯錯。」

金賽非常注重結構性訪談，將訪談提升為一門非常精細的學問。他教一位受訪者日後回憶時寫道：「事後比對筆記，我們必須承認，金賽博士的太和我……離開時都對高超的訪談技巧，留下深刻的印象。答案中刪除的部分，大多是因為我們記不太清楚了。」這是個龐大的任務，金賽他自己負擔大部分的責任，他從一萬七千件個案中，收集超過七千件個案，直到臨終前才完成研究。

我們從這些訪談中，獲得許多人類性行為的知識，完整性遠遠超過之前任何研究。一九五五年金賽過世前在紐約醫學院演講時，會場擠滿了名醫，就是為了聽金賽談多樣的男女性行為。金賽的研究徹底擊垮維多利亞時代的



假象，事實上許多人享受自慰、同性戀、肛交、甚至是不倫等不同形式性行為帶來的愉悅，其中許多是社會大眾根本不知道的。如此一來，衛道人士試著攻擊金賽性學研究報告的確實性與代表性，質疑數據是否可靠的激辯也接踵而至。

但物換星移，大眾逐漸接納金賽的研究。他的研究雖然不是十全十美，但依然是現有最可靠的數據，呈現真實不誇張的一面。這些研究資料帶我們開展一個過去只能關起門來悄悄談論的人類性行為領域。

像佛洛伊德和所有偉大的研究先鋒一樣，金賽也犯了一些錯。其一是因為他想要儘可能做到科學客觀，反而造成現在性學研究進退維谷的處境。金賽性學中心設計一個特別的研究計畫，企圖找出女性生殖器對性刺激最敏感的部位。三位男性與兩位女性婦科醫師測試八百多位女性十六個刺激點，包括陰蒂、大小陰唇、陰道壁和子宮頸。但他們擔心不夠科學客觀，因此不直接接觸受試者，改用類似棉棒的工具測試。不幸的是，我們現在知道陰道的敏感帶，要深度壓力才有反應，輕柔碰觸是沒用的，因此金賽的研究人員下了錯誤的結論：陰蒂敏感，陰道不敏感。

的一步，決定在實驗室裡直接觀察性行為，獲得第一手的研究資料。

金賽空前的研究成果，鼓勵了馬斯特與強生。他們兩人終於踏出了勇敢

科學研究不只要求必須測量和量化所有的研究觀察，更要求親眼所見。

例如，亞里斯多德相信重量為某物十倍的東西，落下的速度也是十倍。幾個世紀以後，伽俐略拿著兩個重量差十倍的物體，到比薩斜塔測試亞里斯多德的理論，結果兩個重量不一樣的物體，卻同時落到地面。

直到馬斯特與強生提出對自慰和性交的第一手觀察報告時，我們才真正清楚了解人體受到性刺激時的反應。為了幫助大家了解，他們將性反應分成四個階段：興奮期（excitement）、高原期（plateau）、高潮期（orgasm）和消退期（resolution）。

興奮期時，女性第一個生理反應是陰道濕潤，男性則是陰莖勃起。濕潤和勃起，其實都是因為血流增加，周圍組織充血後的結果。其他的反應還有乳頭腫脹或堅挺，男女都會有類似的情形。

高原期，實際上是興奮期穩定進展的一個階段，外三分之一的陰道組織腫脹，陰道開口縮小，夾牢陰莖；男性方面，睪丸增大，被拉往骨盆底。陰



蒂內縮，且被拉離陰道口，變得很難找。男女雙方都會肌肉緊繃。

馬斯特與強生所謂的高潮期，是指女性的高潮平台，也就是陰道外三分之一及周圍的肌肉，產生一系列的律動收縮。一開始肌肉收縮的間隔約為〇點八秒，但接下來收縮的強度減弱，間隔也會增長。根據馬斯特和強生的研究，激烈的高潮則只有三到五次。客觀的說，高潮從第一次肌肉痙攣開始，尿道也會跟著規律收縮。男性也有類似反應，同時會有一個複雜的過程引發射精，馬斯特與強生的研究只對男性高潮有詳盡的描述。高潮時，男女身體其他部分都會產生變化，包括脈搏加快、血壓上升、呼吸急促，全身肌肉也可能收縮再放鬆。有時身體大部分的皮膚會充血、泛紅。

最後一個階段消退期，器官逐漸恢復到未受刺激的狀態。如果只有一次高潮，消退期時間最短；若有多次高潮，消退期時間會持續較久。若沒有高潮，直接發生在刺激與高原期後，也會持續較久的時間。

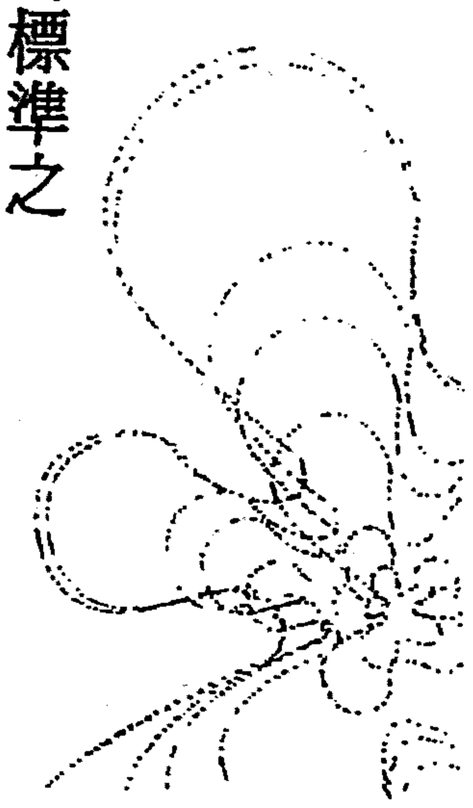
馬斯特與強生的研究方法還是有問題。他們的錯誤來自才問世不久的金賽性學報告，他們採取金賽性學報告的結論，假設陰蒂是女性性反應的主

軸，自慰時可藉刺激陰蒂到達高潮，自慰高潮成為篩選研究對象的標準之一。但我們現在知道他們其實忽略了女性的個別差異。

馬斯特和強生，在陰蒂高潮與陰道高潮的長期辯論中主張，所有的女性高潮一定與陰蒂有關，並沒有生理學上的差異。他們相信所有女性的高潮都只是主觀認定上的差異而已。與陰道接觸陰道口有關，任何察覺不同的都可能在自慰或是性交時發生。

前面提到，佛洛伊德認為高潮有兩種：陰蒂刺激帶來的高潮象徵男性化且不成熟；深入陰道的高潮才是成熟且女性化的。一些佛洛伊德觀點的擁護者十分極端，把只對陰蒂刺激有反應的女性貼上標籤，認為她們性冷感，且有精神官能症。一位產科名醫就曾經告訴許多男人只能以陰莖插入陰道的方式行房，且那話兒千萬不能「卡」在老婆的陰蒂上。馬斯特和強生的發現則引發學界為陰蒂平反的狂潮，又形成另一個極端。不同的女性運動派系，看到這些文章，不禁納悶，除非要傳宗接代，否則異性戀女性何必還要執著於性交呢？

任何一個女人或男人，只要經歷過一種高潮時，當然會根據經驗，產生



極端的主觀認定，這是很合邏輯的，但萬一有女性不斷從這兩種方式達到高潮呢？又該如何解釋？

套句佛洛伊德的名言，只有在考慮個人的經驗、背景的情況下，臨床觀察才有意義，這也或許對解釋最近生物能量分析師（bioenergetic analyst）的調查有幫助。生物能量分析由亞歷山大．洛文（Alexander Lowen）醫師首創，是從佛洛伊德的弟子，威爾海姆．賴希（Wilhelm Reich）的臨床研究中發展出來的新佛洛伊德學派（neo-Freudian）之一，是一種身體導向的治療方式。生物能量分析與大多數精神治療不同，除了聽患者的敘述外，也直接觀察呼吸和肌肉緊繃狀態。患者進行這類治療時，可以躺、坐或站。躺著有助於配合治療和幻想；站著是成熟、堅定及壓力的姿勢。雖然性生理學家交互使用高點（climax）和高潮（orgasm）兩字；但生物能量分析學者用高點形容生殖器肌肉的收縮，高潮則形容遍布全身的肌肉收縮。

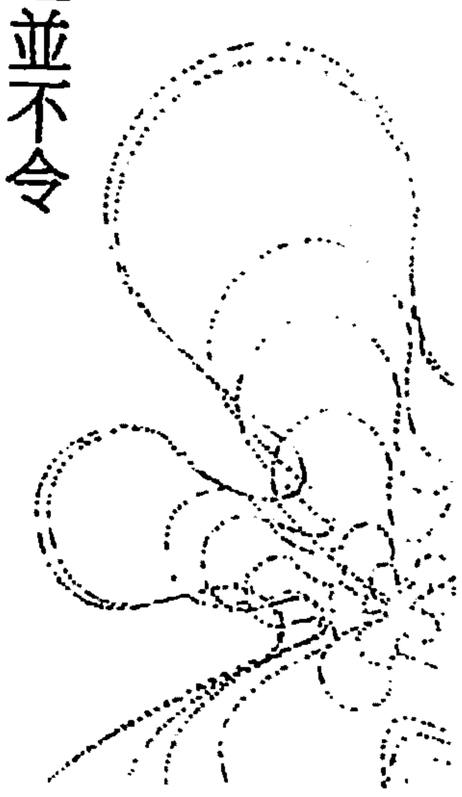
過去數年，許多在男性同僚監督下為患者治療的女性分析師，在一九七五年一場生物能量分析學會舉行的會議中，第一次與其他女性分析師碰面，這時她們才發現，自己從沒釐清身為女人的感覺。雖然會議中女性分

析師仍然無法表達內心的感覺，雖然提出不少問題，結論卻不多。這並不令人意外，因為即使在一九七〇年代末期，專業團體的成員大部分都是男人，組織如何運作，該做些什麼事，有許多不成文的規定。

如果女性不能公開表達觀點，她們可以用文字表達。因此愛麗斯和哈洛·拉達斯（Alice & Harold Ladas）在一九七七年時，決定寄出匿名問卷。希望藉問卷發現生物能量分析理論和女性實際的看法、經驗與習慣有何不同，這與一九二〇年代荷妮所做的研究類似。所有的生物能量分析學派的研究報告和講座，都是男人主導的；但根據臨床觀察與推演，現在應是到了加入客觀驗證和女性意見的時候。

一百九十八位受訪女性中，約有七成回覆。這些匿名保護的問卷，給女性生物能量分析師以專業和個人的經驗，發現研究重點的機會，她們也能自由討論理論的異同。最大的理論爭議就是陰蒂的重要性，但可能因為長久以來，陰蒂象徵不成熟，因此大家不承認對陰蒂有興趣，會中當然隻字未提。

佛洛伊德認為，只有親身經驗分析方法，且觀察他人的分析，才能評價他的理論適切與否。女性生物能量分析師，可說是歷史上第一個達到佛洛伊



德標準的團體。研究中，超過八成的治療師提到，自己在某些方面因為治療師提到，自己在某些方面因為治療師提到，自己在某些方面因為

經驗則並未支持馬斯特和強生主張的所有高潮都與陰蒂有關的說法。這證明有時研究者只是選擇性接受先入為主的理論，當成簡單的答案，卻忽略了全貌。

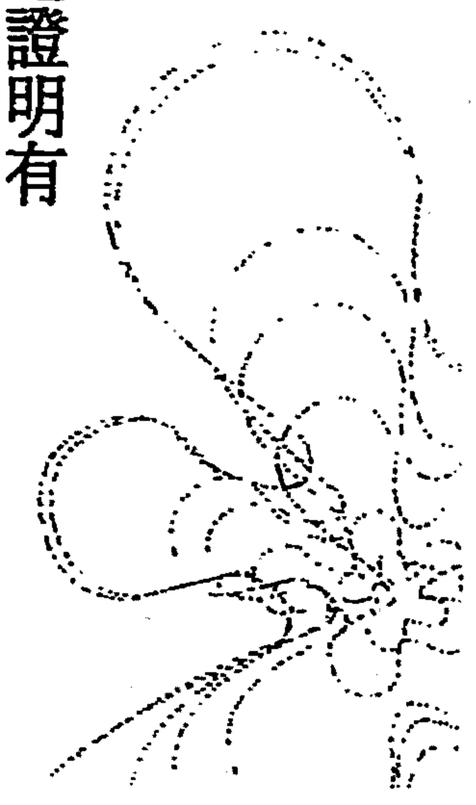
一三年後，也就是一九八〇年，愛麗斯在性學研究學會全國會議上發表調查結果。雖然報告的題目是〈從佛洛伊德到海蒂，都沒有全對〉（Freud through Hite All Partly Right），她還是指出這些學說錯的地方。在這個會議上，她也第一次接觸約翰．培瑞與比佛利．惠普。此時，百家爭鳴的各種基本學說融合，帶領性學研究進入新境界。

配合會議論壇的要求，在不到五分鐘的演講中，培瑞和惠普報告的重點如下：

。陰道內有一個點，對深度壓迫非常敏感。位置大概在陰道開口往內約兩寸的陰道壁前端。他們以第一個描述這個部位的恩斯特．葛瑞芬柏格醫師之名命名，稱為「葛瑞芬柏格點」，又稱「G點」。

。每個受檢婦女都發現G點的存在。

。在適當的刺激下，G點會腫脹，導致許多婦女進入高潮。



高潮時，許多婦女會從尿道射出一種與男性精液化學成分相似的液體，但裡面並沒有精子。

刺激G點可引發女性多次高潮。

許多無法在傳統傳教士體位刺激G點的女性，換個姿勢會比較簡單。

一些女性會因用子宮帽避孕，無法刺激G點。

大部分的女性認為自己在高潮時射出的液體是尿液而感到不好意思。

通常性伴侶會投以輕視的眼光，是造成女性學會壓抑高潮的原因之一。

婦女的恥骨骶骨肌強度，與性交時能不能達到高潮有直接關係。

女性可以學習加強恥骨骶骨肌的強度，萬一肌肉太過緊繃，也可學著放鬆。

男性如果增加恥骨骶骨肌的強度，也可以達到多次高潮，將高潮與射精分開。

男女的性高潮都有許多種型態。女性有陰蒂引發的陰唇高潮、性交引發的子宮高朝，還有兩種結合的高潮。男性的高潮一種由陰莖，另一種則是攝護腺引發。

爾・在場聽報告發表的聽眾，不乏專業人士，包括金賽的研究團隊成員華戴
瑪麗・帕姆洛伊博士（Wardell Pomeroy）、美國性資訊與性教育委員會的主席
・考爾德倫醫師（Mary Calderone）等多位人類性學領域的研究先驅。

滿針鋒相對的緊張氣氛，相較之下，這次的發表平和而順利，可說是性學研究
中歷史性的一刻。一九五七年，性學研究學會贊助理情治療（Rational Emotive
Therapy）創始人艾伯特・艾利斯（Albert Ellis）和亞歷山大・洛文的辯論。當
洛文斷言陰蒂高潮是女性高潮障礙之一時，艾利斯以「陰道高潮的迷思」反
駁。這種兩極化的觀點到了一九八〇年的會議時已經消失無蹤。一九五八年馬
斯特與強生早年的研究拍成性學寫實影片，當時提心吊膽檢視這部影片的恐
懼也消失了。這是第一部性學影片，也是最令人印象深刻的，內容描寫所有的
高潮都與陰蒂有關，且所有受試者都有相同的生理反應，相當具說服力。檢視
影片時，必須一直注意有沒有外人以看色情片的心態溜進來偷看；但到一九八
〇年時，卻沒有一個人擔心培瑞與惠普放的影片會被人當成色情片。

費城湯瑪斯傑佛遜大學醫學院（Thomas Jefferson University Hospital）



婦科醫師馬丁·衛斯柏格（Martin Weisberg）第一次得知培瑞和惠普的發現後說：「放屁，我醒著的一半時間都在檢查、切開、縫合、切除或重建女人的生殖器官，哪來的女性攝護腺，更沒有什麼女性射精。」

但幾個小時之後，看了他們的影片，並檢視一名參與試驗者後，他的態度有了一百八十度的轉變：

陰唇和陰道正常，沒有不正常的硬塊或硬點，尿道也正常，一切都正常。她讓性伴侶用兩根指頭進陰道，跟尿道差不多長度的地方敲擊。令人感到意外的是，這個部位開始充血腫脹，最後變成一個大約兩公分橢圓大小的硬塊，與陰道其他區域完全不同。不一會兒，受試者出現「伐氏操作」（Valsalva maneuver），類似閉氣排便時的現象，幾秒鐘後，幾西的乳白色液體從尿道噴出，可以明顯看出不是尿液。如果報告中所寫的化學分析正確，組成應類似攝護腺分泌物……。

我實在有點搞混了，我請教過幾位解剖學家，他們都覺得我瘋了；但我的病人可不這麼認為。一些患者說她們有射出分泌物的情形；有些則知

道尿道附近有這麼一個性敏感區域。每個人回家試驗後，都發現了G點。

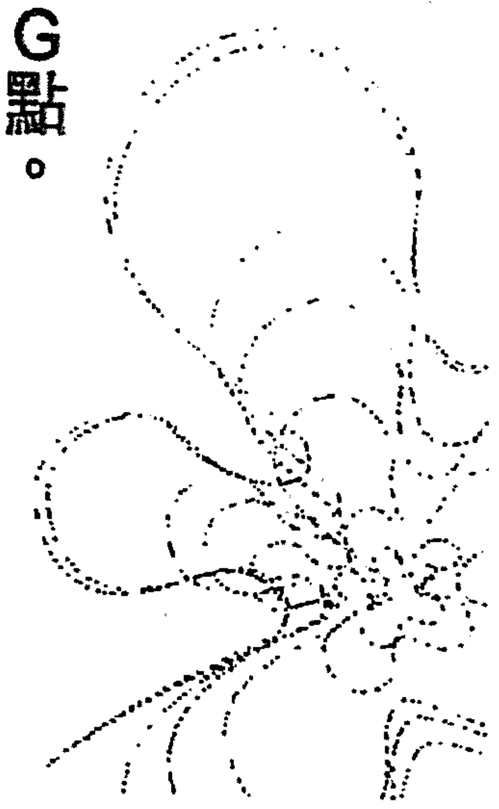
我還是不知如何解釋這種現象，但可證明G點和女性射精確實存在。

多年以後我想醫學院的教授都會開玩笑說，怎麼醫學界以前都沒發現，

直到一九八〇年才接受女人真的會射精這件事。

但在一九八二年，即使大多數家庭醫師、婦產科醫師都已接受女性射精的觀念多年，醫學界還是有一大群人不知道這件事。

愛麗絲．拉達斯在一九八一年設計了第二份問卷，針對生物能量分析師及常在會議中出現的專業人員，她想找出到底相關專業人士對這個概念的了解程度。很快的這個調查變成同儕依個人喜好投票，而忽略了科學事實。針對臨床工作者的調查，出現以下結果：四人認為有女性射精，四位持相反意見，三位回答不知道。至於陰道中特別敏感部位的位置，五人說有，四人回答陰道本來就不敏感，二人回答不知道。五位回答有的人中，二人認為這個部位在陰道口，一人認為在子宮頸，一人認為在陰道後方，只有一人答出是在陰道壁前端。受訪者多在個人或夫妻情侶的性諮商領域工作，卻出現南轅



北轍的答案。針對婚姻和家庭諮商者的調查，受訪者多為女性，也出現意見分歧的情形。

有許多我的朋友和病人喜好探索新知，其中不少人已熟知這個現象。一個四十五歲，頗具規模的非營利醫療組織的女性主管告訴我們：

我知道女性射精這件事已經有一段時間，我有類似經驗。雖然知道這是自然現象，射出的液體也不是尿液，但還是覺得丟臉。相較於另外一種高潮，射精的高潮令人感覺全身完全釋放，雖然是深層的高潮，卻很容易誘發。

一位二十一歲的女性提到她第一個也是唯一的愛人說：一

的確有一個特別的點在裡面，大概是在前端，中間偏右邊一點。當他的陰莖碰觸到那裡時，我感到快感，而且當我在上位時，比較容易碰到。

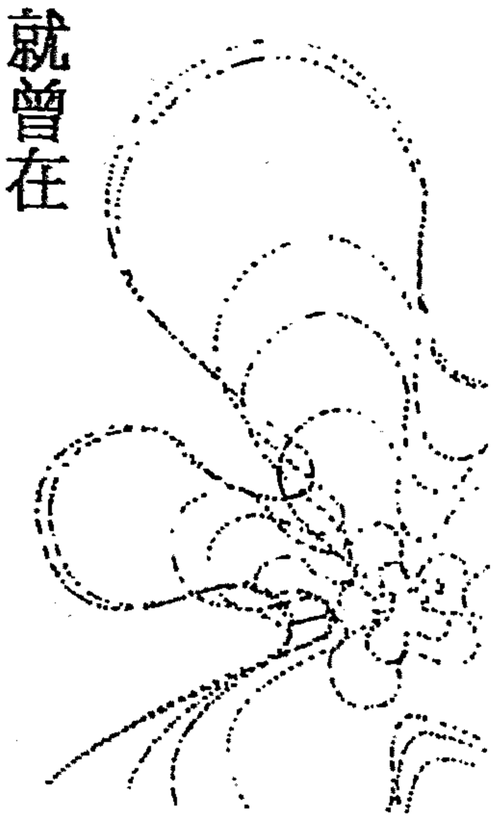
有一個限制級書刊的出版商跟我們談起他的一個男同性戀員工，就曾在書裡提到女性射精。「在我的辦公室裡，他們認為這是個笑話，也只有同性戀男人會寫出這樣的東西，這本書也沒機會問世。」

長老會教派牧師的太太這麼說：

是一個男人用指頭幫我發現那個特殊部位，我以為那是個移位的陰蒂……就是陰蒂長到陰道裡了。這個地方比陰蒂能帶給我更多的快感，但我曾聽說陰蒂是唯一性敏感的部位，而感到困惑。

一個十六歲就有性行為的女性說：

我年輕的時候很害怕，根本不知道發生什麼事。達到高潮時，就好像撒尿一樣，我們兩人都濕透了，但我知道那不是尿。只有在性交時才會發生，自慰時就從來沒出現過。很快我知道要避孕，謝天謝地，用了子宮帽，就再也沒發生過了。



三十五歲的舞者說：

對我來說，達到性高潮並不容易。我有個新男友，我很在意他。肛交能讓他得到更多快感，我想取悅他，就順著他。我以為我瘋了才這樣做，而且第一次真的很痛，但之後障礙破除了，我不再抗拒他。就好像他碰到了我的膀胱，讓我想上廁所。我開始呻吟，沉入激情中，覺得身體裡面開始崩裂。

第一次感受的激烈程度，把我嚇壞了，我馬上跑到廁所哭。讓我覺得他拿了我體內非常私密的東西，他控制了我的身心。我覺得快要死了，又覺得迷惑。那一次我不覺得被愛，只有激烈的感覺，但之後就有剛柔並濟的感受。

一位從良的妓女，現服務於非營利教育組織：

我當然知道女性射精，你想知道的話，也可以問任何一個女同性戀

一

者。高潮可分陰蒂與陰道高潮，兩者迥異。陰道高潮與陰道內一個特別的甜蜜點有關。

許多男性也有發現女性這個特殊部位的經驗，只是他們不清楚那到底是什麼：

每位女性都有不同的反應，男人很難真正了解女人身體內發生什麼事。女人反應激烈時，男人還是身處五里霧中，想著還要進到多深才夠。有些女人會要求男人深入到子宮頸，才能帶來高潮。難道你不認為，這些抽插、重擊，都只是為了要刺激那一點。

問到女性射精時，這位男士則說：

我曾經聽過。有一次我跟一個女孩一起，她達到生平第一次高潮，而且射精。她以為她尿出來而又窘又怕。老實說，那時我也不知道是怎麼回



事，但幸好那時我們很熟，而且之後繼續見面。如果我們不是好朋友，我很可能馬上就因為搞不清楚狀況而開溜了。

另外一位男士說：

那種液體聞起來不像尿，也不像精液，而且是個很美好的經驗，我喜歡想著我太太，而且我也有一定的知識水準，但我們怎麼會忽視這件事這麼久？

醫學及精神分析專業人士，為何會忽略這個大家都很熟悉，卻很少討論的現象？為什麼解剖學家找不到G點？這些都是很難回答的問題。

臨床工作人員其實並不認同一天到晚問：「這裡會痛嗎？那裡會痛嗎？」應該反過來問：「這樣舒服嗎？那樣會更好嗎？」除非特別尋找，解剖遺體組織很難發現G點。

亞里斯多德發現女性在高潮時會噴出液體，從他開始，許多歷史文獻都

記載女性射精。一九五〇年，葛瑞芬柏格提到：「一些女性在高潮時會從尿道噴出大量的清澈液體。」他相信這些液體是由尿道內腺體分泌。一九七八年，賽維利和班奈特（J. Lowndes Sevely and J.W. Bennett）認為，女性攝護腺是女性射精的來源，「這是腺體和導管組成的系統，分布在女性尿道周圍，跟男性攝護腺一樣，是由胚胎組織發展而成。」

跟其他人不同，培瑞和惠普並沒有忽略這些報告，反而開始他們自己的研究，以證實前人的說法。他們的發現對人類的價值，端看如何利用。就像艾德溫・貝爾澤（Edwin Belzer）在性學研究期刊中寫到：

> 證實女性射精存在的客觀證據，也可能有反效果。這些證據可以釋放過去屈服於權威之下，不得不否認或抗拒射精存在的女性。相反的，這會使人跌入女性若沒射精高潮就「不完美」的陷阱中。但大家無論試著要射精，或是企圖造成射精失敗時，就會被認為是性缺陷的指標。

在性學研究學會的會議上，培瑞和惠普的報告令人驚喜。拉達斯關於G



點和女性不同型態高潮的研究則更令人興奮。這些發現可以解釋女性生物能量分析師在性交達到高潮的同時，卻又覺得陰蒂也非常重要的現象。也說明她們對多次性高潮的主觀觀察。

培瑞和惠普也對拉達斯的研究極感興趣。會議結束不久後，惠普寫給拉達斯的信中提到，「我們的研究途徑相同，將帶領我們達成相同的結論，特別是在女性持續高潮上……。」合作就此開始。

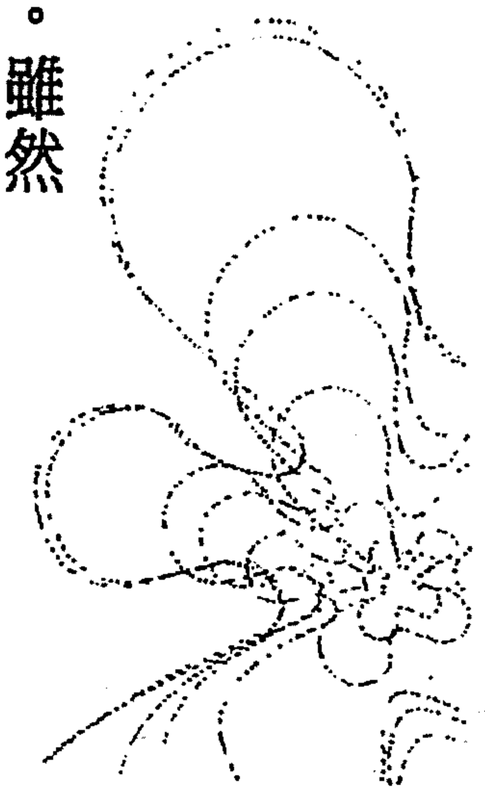
接下來的內容，會仔細地介紹培瑞和惠普引起性學研究者注意的四個基本觀點。這些觀點不是新理論，跟其他領域的科學發現一樣，出版後大家視而不見，包括：G點、女性射精、骨盆肌肉和持續的高潮反應。整合佛洛伊德與其他性學研究者的發現，成為容易又一致的理論。矛盾衝突在這裡解決，融合了陰道高潮還是陰蒂高潮，在這裡集大成。

# 第二章 G點

我們可以在沿著尿道的陰道前壁上找到一個性敏感部位，……這裡被像陰莖海綿體的勃起組織包圍……。這個性敏感部位在高潮頂峰時，會充血腫脹到最大。一最敏感的部位應該在尿道末端，與膀胱交接的膀胱頸處。

第一章中簡單提到本書中的四個發現，G點的重要性排名第一。雖然它不像女性射精那麼戲劇化，醫學上也不若肌肉健康重要，但G點的出現，清楚說明可誘發女人性興奮的生殖器部位不只一個，帶領我們擺脫過去幾十年，馬斯特和強生只有陰蒂能帶來高潮的主張。對女性而言，至少有兩個性興奮中心——G點和陰蒂；男人也有兩個性興奮中心——陰莖和攝護腺。

陰蒂頭位於陰道口，突出於身體外面，很容易找到，每位女性都可以享受陰蒂帶來的快感。但G點正好相反，在陰道前壁，女性很難靠自己的力量找到，雖然不一定得假他人之手，但在性伴侶的配合下，會比較容易找到確實的位置。男人也一樣，容易找到陰莖，自己從中找樂子；但攝護腺在直腸前壁，沒有伴侶的協助的話很難發現。



以下是他們的經驗談：

霍伊茲夫婦結婚近二十年，兩個兒子都已經是十多歲的青少年，還有一個八歲的女兒。他們是青梅竹馬，婚後就一直謹守一夫一妻的婚姻關係。霍伊茲夫婦的婚姻沒什麼大問題，接受婚姻諮商只是因為有一種「生

活中少了什麼東西」的感覺。

性生活還算美滿，但總是沒辦法達到心中期待的滿足感。第一次諮商時，治療師馬上知道他們夫妻間沒有什麼檯面下的相處問題，只是在性行為上自我設限。第二次療程，治療師鼓勵他們試著在做愛時發出聲音，藉著深呼吸，讓全身上下更為投入。治療師也告訴他們G點的訊息，和刺激攝護腺可能帶來的快感。

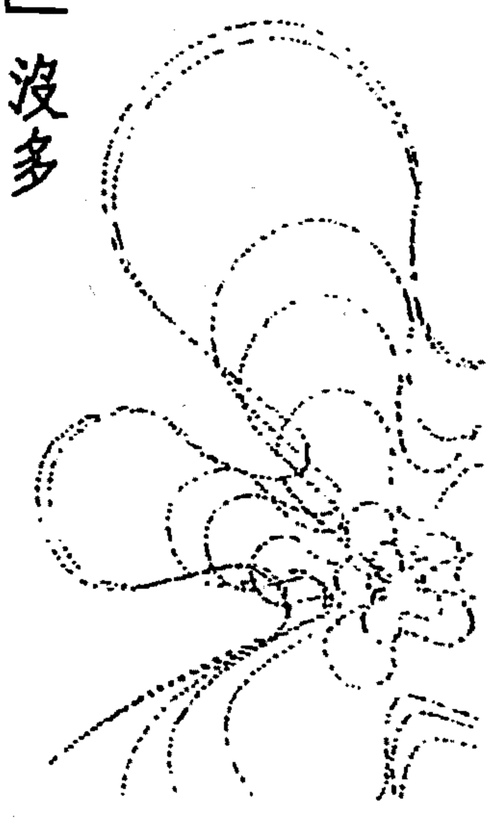
進行第三次療程時，霍伊茲先生說：

我下班回家時，看出金妮已經計畫好了。餐桌上只布置了兩人份的餐具，還點了蠟燭。女兒蕾貝卡到同學家過夜，兩個男孩露營去了。我把金妮帶到房間，褪去衣物，開始按摩她全身，小心避開我過去幾年一直以為是房事重點的陰蒂，反而把手指探入她的陰道，從年輕時做車床族的那段時間以來，我就再也沒做過這樣的事了。她轉身過來，雙腳高舉過頭，靠在床緣，我立刻找到陰道內一個橢圓的點，很像你說的G點，並用手指用

力按壓。金妮開始低聲呻吟，催我繼續下去。她低語：「別停！」沒多久，她就因為快感而倒抽一口氣，陰道也開始抽動，力量大到快要把我的手指推出去，真是太過癮了。

金妮接著說。

我真的有點承受不住，在床上休息好一會兒，擁抱親吻吉姆說：「謝謝你。」不久之後我回過神來，開始把玩他勃起的陰莖，過去我們的習慣是，我一邊親他，一邊把陰莖塞到我的陰道裡，但這次我沒這麼做。我用舌頭探索敏感部位，在睪丸和肛門間來回親吻。這讓他倒抽一口氣，我知道我發現取悅他的新方法。在吉姆的鼓勵下，我利用我的分泌物當潤滑劑，輕輕的把手指伸入他的肛門。吉姆興奮的叫聲讓我繼續新的探索。我一邊親吻他，一邊用手指輕彈吉姆的攝護腺。我嘗試改變姿勢，在他高潮前坐在他身上，但已經來不及了。



霍伊茲夫婦嘗過刺激新發現的性敏感部位產生的快感後，只再做了一次諮商，療程就結束了。他們只是需要資訊和一點專業的支持，就能找到他們錯失的興奮和改變。

G點到底在哪裡？葛瑞芬柏格點，也就是G點，在恥骨後方的陰道前壁上。通常的位置大約是在恥骨後方和子宮頸前方中間，沿著尿道的方向往裡面走，大約就在尿道與膀胱接合的膀胱頸附近。大小和確切位置因人而異。

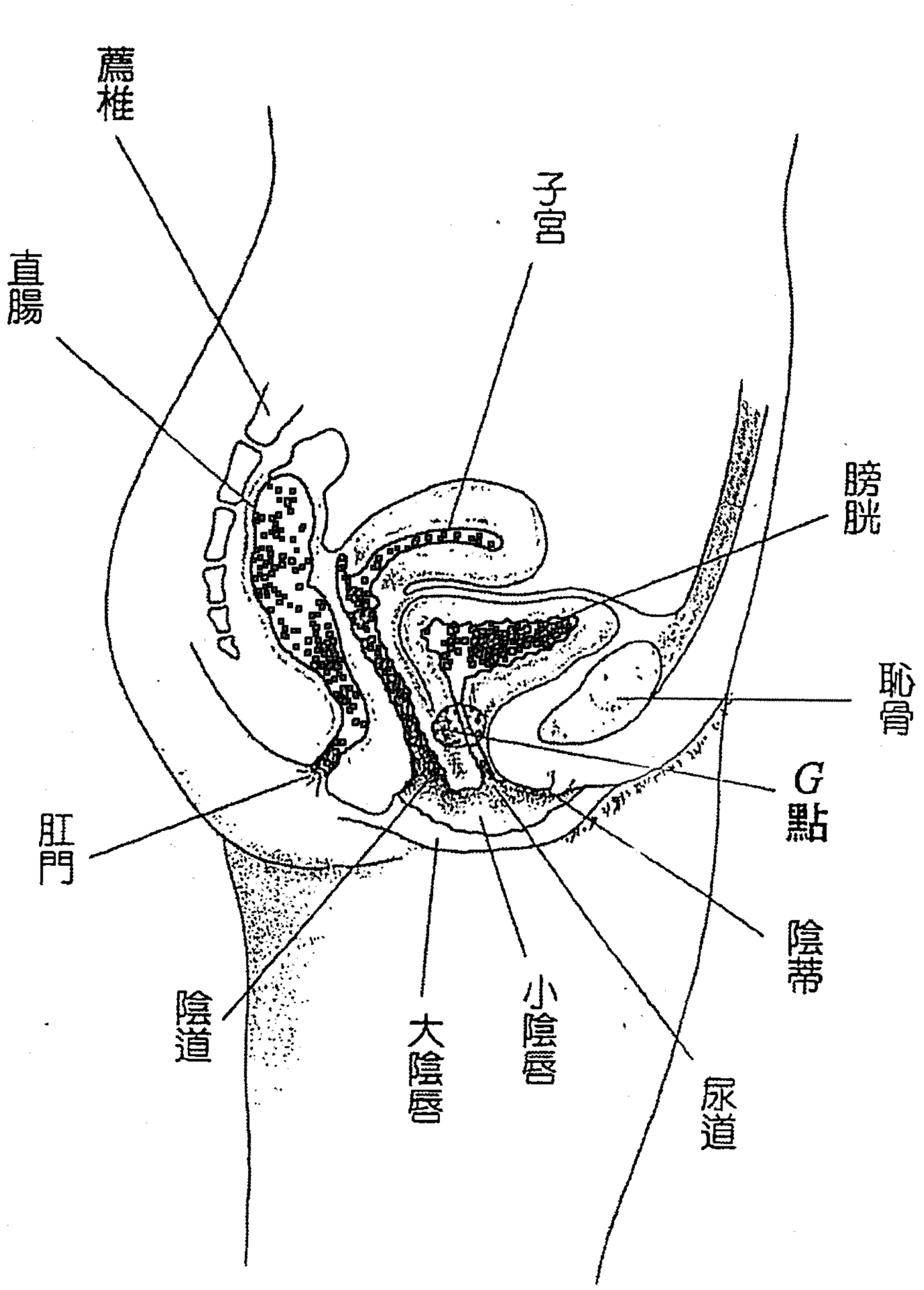
請想像陰道裡有一面鐘，十二時的位置向上指著肚臍，大多數的女性可以在十一點到一點的中間找到G點。跟陰蒂從周圍組織突出不同，G點在深處的陰道壁上，還要很用力的按壓，才能讓它感受到刺激。

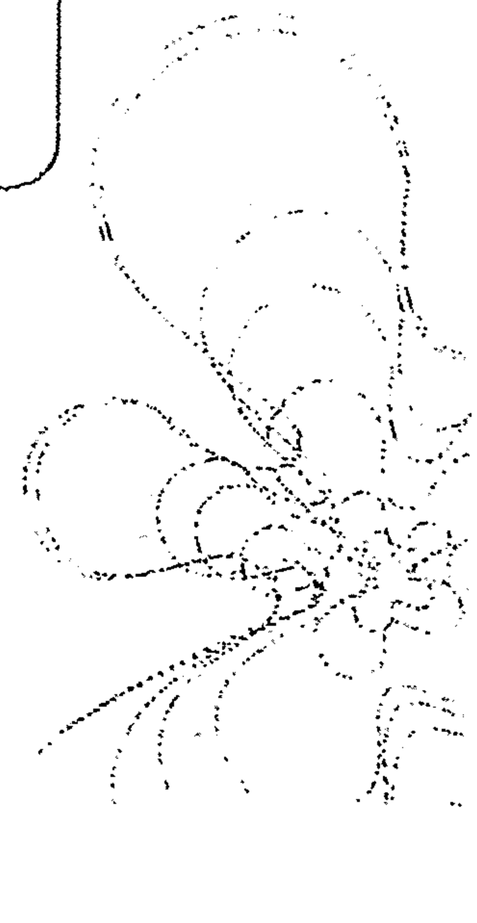
早在一九四四年，德國婦產科醫師恩斯特．葛瑞芬柏格與有美國第一位性學家之稱的婦產科名醫羅勃．狄更生（Robert L. Dickinson）合作。他們說：「有一個能喚起情慾的區域，就在尿道下的陰道前壁表面。」

我們最早是在葛瑞芬柏格一九五〇年發表的文章中，讀到陰道前壁有一個性敏感區域的資訊，他在文章裡提到：

圖一

## G點（女性內生殖器官）



……我們可以在沿著尿道的陰道前壁上找到一個性敏感部位，……這裡被像陰莖海綿體的勃起組織包圍……。受到性刺激時，女性的尿道會變大，比較容易找到。這個性敏感部位在高潮頂峰時，會充血腫脹到最大。最敏感的部位應該在尿道末端，與膀胱交接的膀胱頸處。

葛瑞芬柏格認為，「做愛時，女人總是能感覺到手指或陰莖沒碰到尿道側陰道壁，這時她就會調整姿勢，重新取得接觸。」可見這個陰道前壁的敏感部位，在性交時非常重要。

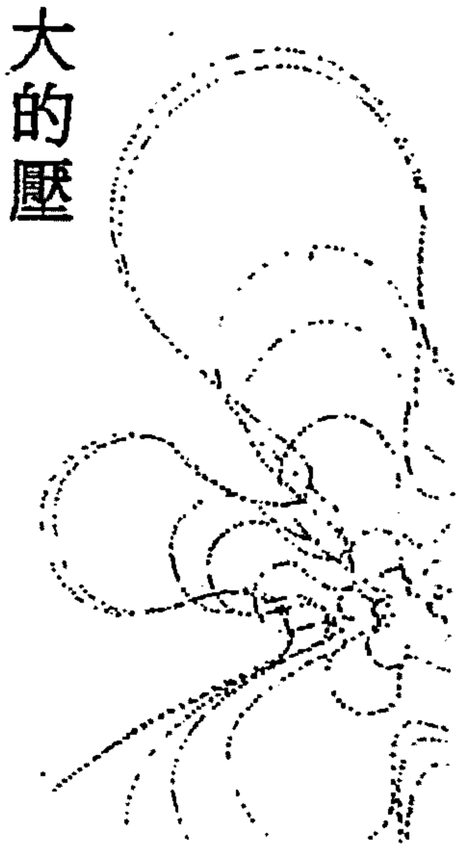
葛瑞芬柏格研究並非不重要。但回想一九四〇年代末期的時空背景，科學界正在辯論女性性興奮中心到底在哪裡。佛洛伊德激進的觀念在美國掀起流行風潮，專業人員也開始在陰蒂高潮對抗陰道高潮的論戰中選邊站，研究人員企圖藉著生理解剖的角度檢視誘發性興奮的所在，好平息這場紛爭。

陰蒂好找，在性行為中的重要性較容易確認。金賽發現，百分之九十八的受試者中，都對觸摸陰蒂十分敏感。相對的，有很多原因讓陰

道的生理感覺比較不易確定。雖然百分之九十的受試者陰道對較大的壓力有反應，但只有大約百分之十二的受試者對輕觸陰道有反應。金賽於是做了以下結論：

……大多數女性的陰道壁像個無底洞，對溫和的碰觸和輕柔的壓力都沒什麼反應……大多數有反應的受試者，感受到性刺激的部位在一個狹窄的範圍內，位置多在陰道口不遠處的陰道前壁上。

但金賽並沒有把這些資料列入考慮，他選擇假設引起性興奮的中心只有一個，再加上他認為人類胚胎時期，陰蒂與男人的陰莖是源自相同的胚胎組織，因此金賽認定陰蒂為女性唯一的性敏感區域。葛瑞芬柏格並未駁斥金賽的陰蒂論，他只堅持，陰道應該同等重要。正因葛瑞芬柏格清楚描述陰道壁的敏感區域與性快感間的關係，培瑞和惠普將這個區域命名為葛瑞芬柏格點，簡稱G點。



我們的文化認為女人只是男人性行為接受者，應扮演被動的角色，不能

有也不應有性慾或性自主能力，因此女人的性反應，是相當新的研究領域。

多年來，性交的唯一目的就是傳宗接代，女人的角色是生養孩子，而不是享受性愛，到今天，仍有不少地方仍堅持這種觀念。

一位三十五歲，結婚十四年的女士，評論女人性反應相關研究時說：

真讓人不敢相信，直到現在才有人要研究女人的性事。從歷史的軌跡來看，不禁讓人懷疑是不是有性別歧視在裡面作祟。要不是研究人員都是男人的話，現在不知道有多少女人性事的相關研究已經問世了。到了一九八二年女人才開始討論性這件事，真的很可悲。

女人長期被視為社會的次等公民，再加上醫學專業人士多為男性，才會導致女人性的問題一直無法引起學界注意。一九五三年，葛瑞芬柏格評論女人性方面的研究長期被忽略，才會到現在連高潮的定義、女人性敏感區域等問題都沒弄清楚。」他進一步認為：

女人性敏感區域在陰道前壁，證明人類的性器官構造，與四足動物類似。西方世界中，最常採用的性交姿勢為，女人平躺，男上女下。當男人的陰莖進入陰道時，除非陰莖勃起的角度與身體幾乎成垂直，或是女人將腿抬高放在男人的肩膀上，否則不容易碰到靠尿道側的陰道前壁。我同意雷蒙。克拉克醫師（LeMon Clark）所言，造物者是依四足動物的形態創造男人，所以正確的性交姿勢應該是男人從背後進入才對。

伊蓮．摩根（Elaine Morgan）一九七二年所著《女人的起源》（*The Descent of Woman*）一書中也提到了G點，但她不是用這個名稱，她寫道：

> 短暫、強力、快速且具韻律感的摩擦可引發高潮……。理想的摩擦力應從後方而來，直接碰觸到陰道壁內側……。有一點要注意，許多靈長類和四足動物性交時不只要從後面進入，還要有下壓的力道，才能在陰道前壁上施力。



哺乳類動物交配時，都是由後方進入，這件事大家應該都知道才對。

摩根的理論提醒我們，女性因演化和歷史文化影響而成為弱勢的說法雖待商榷，但這種說法，可能是許多女性指出，性伴侶生理構造特殊時，即使姿勢正確，也難以碰到G點的原因之一。

雖然摩根從不同的觀點來看G點，但她藉由研究動物行為學、演化人類學，竟與臨床醫師獲致非常相似的結論。她提到後方進入的強力摩擦是所有母的哺乳類動物獲得性滿足的理想姿勢，包括女人在內。

許多受訪者與來信的讀者，無論男女，都證實葛瑞芬柏格和摩根的觀點。一位四十八歲、來自墨西哥的歌手說：

我從不覺得陰蒂有什麼重要。我不喜歡有人碰它，我自己也不喜歡摸它。當我修習一門女性研究的課程時，所有的女性都強調陰蒂的重要，我很生氣。對我來說，陰蒂是性感覺貧乏的部位，我經歷過最棒的高潮，是男人的陰莖從後方進入體內，我會指引他移動到正確的位置，讓他恰好刺激到我體內最敏感的部位。

一

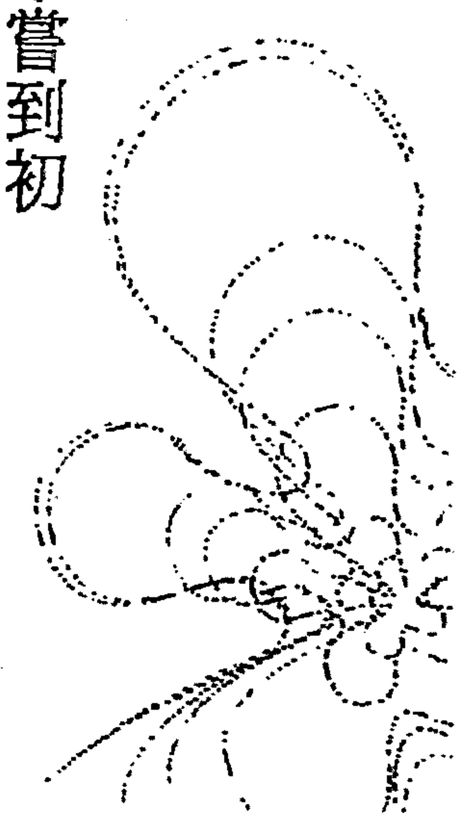
五十六歲的安潔拉是個建築師，從小家教甚嚴，她直到上大學才嘗到初吻的滋味：

若採用傳統男上女下的傳教士式，陰莖得要夠大才能碰到對的地方，我需要男人的陰莖深入體內，後方進入的姿勢，才能讓我得到滿足。

我們有一位三十多歲的朋友，是位熱衷女性主義的教授。我們告訴她這件事時，她氣瘋了，認為背後進入的姿勢「根本就是把女人當成下等人。」無論這個姿勢是「下等」還是「享受」，都只是個人主觀的認定。性愛姿勢只是一種喜好，沒有所謂下等或上等的區別。重要的是，我們必須了解不同的女人，有不同的需求，應該有多樣性的選擇，而選擇性行為和性愛姿勢時，女人更應該主動參與。

五十六歲的壽險業務員回想他三十歲時，跟一位女子上床時的情形說：

……與她做愛真是人生一大樂事。她做愛的方式很特別，不只愛撫我



的全身，當我勃起時，她會背對著我，把陰莖從後方塞入陰道中。她會小心擺好姿勢，要我強力抽插。她說，她想要用力刺激在正確的點上。

刺激G點不只與性交的姿勢有關，生理構造與性伴侶的配合也非常重要。葛瑞芬柏格提到許多關於性伴侶角色的重要性，「陰莖的形狀也非常重要，必須一併考慮，坊間所說的『完美情人』，可能就是根據這個生理構造特質而來。」

四十二歲的艾珀兒離過一次婚，已經再婚，證實上述的觀點：

跟丹在一起，我有了過去從來沒有的經驗。即使面對面躺在一起，他的陰莖還是可以直接碰到陰道裡的那一點，讓我體會到從來沒有的快感，能達到高潮。我覺得應該是他的陰莖勃起時，與肚子垂直，這是以前跟其他的夫妻和情侶指出，性交時女性在上位，是刺激G點的最佳姿勢。

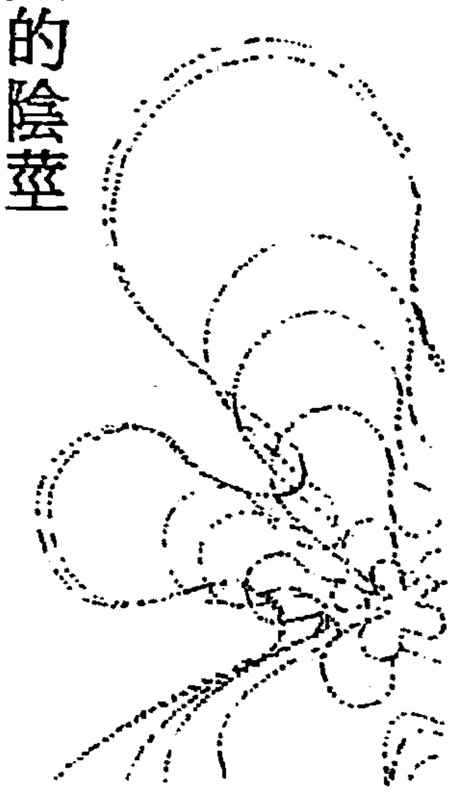
又有些報告指出，採女上男下的姿勢時，比較小的陰莖有時反而比大的陰莖更能有效刺激G點。

三十歲的醫師太太寫道：

我一直都有高潮，但當陰莖完全進入我的陰道時，反而感覺沒有得到足夠的刺激。事實上，陰莖完全進入時，我的興奮和快感急速消退。最能讓我感到興奮的是陰莖只進入陰道的一半或三分之一時。現在我知道為什麼了，因為進到一半或三分之一時，正好刺激到我的「神奇G點」。

一位結婚三十三年的女士說：

但它真的存在。我曾聽說太多性學專家，誤導許多可憐的女性，讓她們認為只有陰蒂刺激才會產生高潮。刺激陰蒂是很舒服沒錯，但是比不上真正



的高潮。真正的高潮發生在陰道深處，如果你能同時有兩種高潮，那可真是令人欲仙欲死呢！

然而，有些女性發現，採取傳統男性上位的姿勢，也就是所謂的「傳教士式」，也可以刺激到G點。一位結婚二十年的女士說：

特殊的部位取悅伴侶。這個點是不是陰蒂，他回答說：

在陰莖比較容易碰到G點，但是我發現從後方進入，或者是我在上位時，陰莖勃起，射精之前，只要插入得夠深，用傳教士式也可以做得到。

一位來自伊朗的穆斯林說，回教文化中會教男人如何藉由刺激女人某個

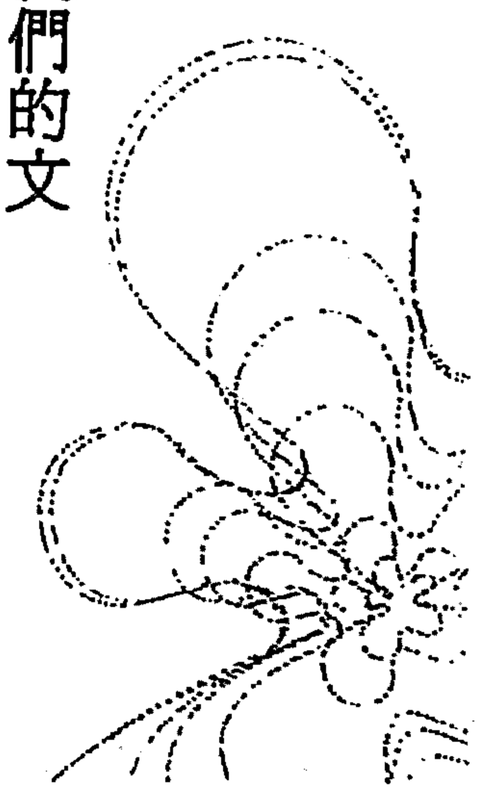
不是，這個地方在女人體內，且當女性在上位時，更容易產生快感。

他太太也同意，當他在上位時，太太反而覺得不夠滿足。

性學和性愛技巧的知識，多半得靠直覺，也受文化影響。比起我們的文化，世上有許多文化對性的壓抑較少，讚美女性高潮的存在，也教導人們達到高潮的方法。這些文化期待女性高潮的出現。第一次世界大戰時，人類學家馬林諾斯基（Bronislaw Malinowski）與南太平洋的托布倫島人（Trobriand Islanders）一起生活，托布倫島人玩一種類似玩花繩的細繩遊戲，跟性有密切關係。兩個繩圈代表兩個性興奮的中心，玩法是用手指先移動一個繩圈，然後再移動另一個，讓繩圈快速震動。馬林諾斯基解釋兩個繩圈象徵兩個陰蒂，他說：「從解剖學上來看並不正確，人只有一個陰蒂，且應在陰部下方，這個繩圈的位置也錯了。」他不相信女人有兩個性興奮中心。但之後的研究發現，兩個繩圈代表的應是陰蒂和G點，而不是兩個陰蒂。

有一位女士從巴拿馬來信說：

我們早就知道「G點」了，在這裡稱為La Bella Loca（美得發狂），我大概在十五歲時就知道了，現在我都已經六十五歲了，還是性致勃勃，只能說我們是性愛國家的子民吧！



導管，G點上分布著非常複雜的血管網絡、尿道旁腺（paraurethral glands）和神經末梢和膀胱頸周圍組織。我們從受檢女性身上，或是從其他人檢查的報告中發現，經過刺激後，G點會充血腫大，軟組織變硬，與其他部位出現明顯的區隔。若此時給予性刺激，充血腫脹會相當快速。到目前為止，我們不清楚G點的細胞結構，不少醫學院的研究人員正企圖找出構成G點的組織特質。

這個爭議性的問題是，G點與男性攝護腺真的源自相同的胚胎組織嗎？一個爭議可以追溯到羅馬時代，醫師蓋倫在西元二世紀時，提出了這個問題，並下了肯定的結論。但威廉．馬斯特在一九八一年四月評論培瑞和惠普的研究時，堅持我們拿攝護腺來比喻G點，並不適當。

我們傾向相信G點是攝護腺的同源物退化之後殘餘的物質。兩者另一明顯的不同是，比起G點，攝護腺較為人所知，位置、大小、形狀也較為一致。不過，G點和攝護腺的相似性，也讓我們了解到，男人和女人在生理構造上，遠比我們原先想像的更為相似。

一九八〇年十月，紐約時報刊登一篇文章，內容是一位父親如何成功分

泌乳汁，哺餵女兒長達八個月的故事。他服用女性荷爾蒙，照著世界上即使沒懷孕生子，也能讓婦女分泌乳汁餵哺嬰兒的方式，一步步達成目標。首先要讓嬰兒持續吸吮，同時用滴管把牛奶滴到嬰兒嘴裡，直到父親的乳頭穩定分泌乳汁為止。我們並不清楚，是否大多數的男人都可以做得到；但我們能確定，只要有足夠的動機和持續力，未懷孕生子的婦女，一樣可以哺乳。雖然只有少數男性可以哺乳，但我們相信，女性G點在某方面，或許具有和男性攝護腺一樣的功用。

為了找出是否所有女人身上都有G點，培瑞和惠普請醫師或護士檢查超過四百位自願參加研究的女性，結果在每一位婦女身上都找到G點。雖然我們還不能確認每位婦女身上都可以找到G點，但愈來愈多的醫師提出發現G點的報告。

如果每個女人身上都能找到G點，為什麼一直不受重視？許多人都假設醫師清楚人體的每一個細節，但其實醫學院的教育，都會教醫師盡量避開可能引起病人性興奮的療程。一般的婦科檢查中，就算會觸診到G點附近，力



量也不足以引起性興奮，且確實位置通常都被陰道撐開器擋住。在這種情形下，不難了解為什麼G點一直被忽視。沒有刺激時，G點很小，很難找到，尤其它在你看不見的地方。就像陰莖在醫療檢查時也不會一直充血腫脹。G點也是一樣。因此醫師根據門診檢查的資訊，做出陰莖是下垂的，平均長度大概只有五公分的結論。

女性主義聯盟的女性健康中心（Feminist Women's Health Centers）編寫的《女性身體的新觀點》（*A New View of a Woman's Body*）一書中，G點被稱為「尿道海綿」（urethral sponge）。作者無法從醫科書中發現G點的名稱，只好自己取了名字。他們解釋，性興奮和性交時，G點組織會充血腫脹包圍保護尿道，是陰莖和尿道間的緩衝器。

如何找到自己的G點？平躺時因為地心引力，把內部器官拉離陰道口，除非你有很長的手指或是很短的陰道，否則很難靠自己找到G點，坐姿或半蹲就容易得多。刺激G點時，會先有想尿尿的感覺，因此坐在馬桶上找G點，也是個不錯的方式。開始之前先上廁所，就不用擔心你的動作刺激膀胱尿得滿手都是。

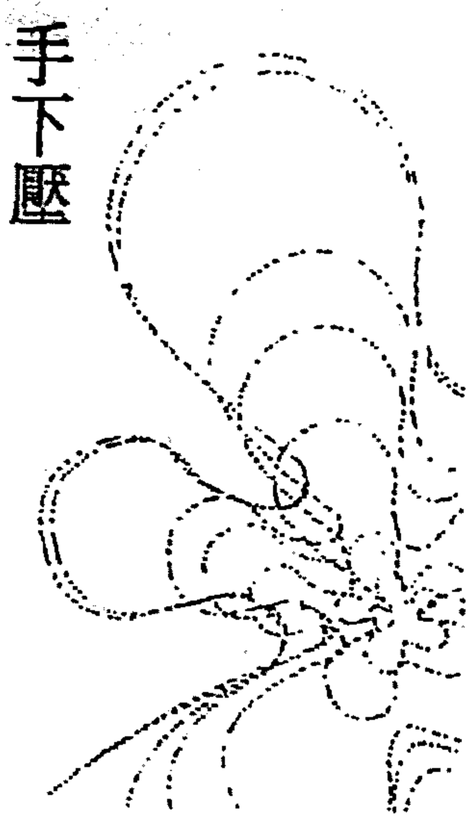
手指用力，以往上按壓的方式探索陰道前壁，有些人會覺得另一手下壓恥骨上方的小腹部位，對定位G點很有幫助。當你經由陰道壁刺激G點時，它會開始充血腫脹，大小像是指節間的隆起。體內可能會有一種特別的感覺，放鬆手指的力量時，感覺也會跟著消退。

醫師則會要患者正躺，利用雙手法找尋G點。用這種手法時，患者的回饋可以協助沒有經驗的臨床醫療人員更容易找到G點。以色列的茲威·霍克醫師（Zwi Hoch），也教病人用雙手法的技巧，幫自己或性伴侶尋找G點。

手指觸摸G點的感覺是像顆豆子，刺激時可以脹大到跟五元硬幣一樣大，甚至像半個五十元銅板那麼大。有些女性的G點特別大，就像有女人胸部豐滿，有男人陰莖比較粗一樣，都是正常狀況下的個別差異。胸部、陰莖或是G點的大小，都不會影響性刺激後的反應。

女人對G點的刺激反應當然也有不同，就像有些人對乳頭的刺激反應，會比其他人激烈。醫師檢查時還發現，停經後的女性G點會比較小，但刺激後的反應與未停經的婦女並無差異。

如果你繼續用力按壓，會有輕度到中度的快感，也會注意到子宮會抽動



和收縮。就跟自慰陰蒂一樣，你可以試著刺激G點。你可能需要比刺激陰蒂時更用力，也會感受到更深層的快感。

刺激G點時，只要膀胱脹尿的感覺消失，你可以移到床上等舒服的地方繼續。如果你還是怕弄髒床單，墊條毛巾就可以了。打開膝蓋，跪著或蹲坐在自己的腳上繼續刺激G點，這時你應該會感覺高潮來了，留意是否與陰蒂刺激帶來的高潮不同。一些女性會在這時候射出清澈的液體，如果你也會，你會在液體流出前，有種想尿尿的感覺。射出來的液體會比尿液要白且清澈，不過聞起來也沒有尿的味道。第三章會詳細討論女性射精。

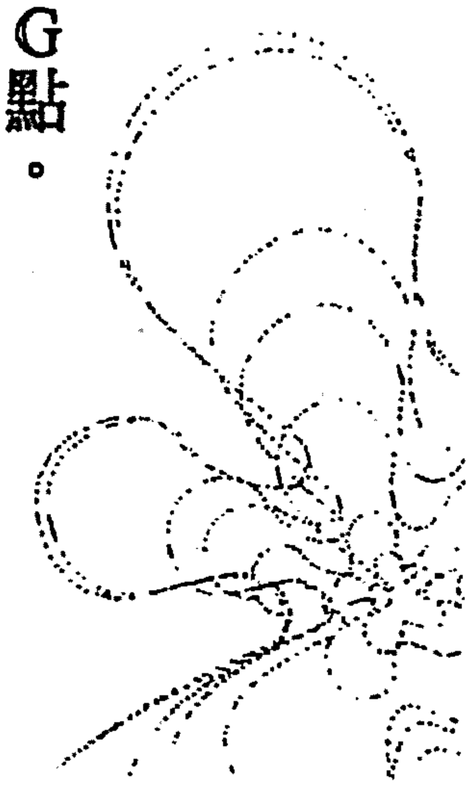
若你的性伴侶與你相處自在融洽，不妨與他一起探索G點，你會發現比自己來要簡單多了。趴下，腳張開，臀部稍微往上提。請你伴侶手掌朝下，伸兩隻手指到陰道中，探索陰道前壁，這時陰道前壁應該比較靠近床，食指和中指用力往下彎，比出「來這裡」的動作。配合G點的刺激移動骨盆，告訴伴侶你感覺很棒。這個姿勢也很適合用陰莖刺激G點。如果你平躺，伴侶則是手掌朝上，伸入一隻或兩隻手指到陰道中，這時只要往上朝陰道壁按壓，就能找到G點，位置大約在恥骨後方到陰道盡頭的子宮頸中間。另一隻

手放在小腹上大約陰毛上面一點點，輕輕往下壓，有時可以幫助刺激G點。

另外一個許多情侶和夫妻喜歡的姿勢是，男方平躺，女方坐在男方身上，勃起的陰莖正好插入陰道。這個姿勢可以藉著女方移動身體，讓陰莖刺激G點，帶來多次高潮。第一次嘗試時，若覺得沒感覺，或只有輕微的快感，不用覺得奇怪，因為這種方式需要練習，有時得多做幾次，才能熟悉這種新技巧。如果你一開始就不覺得愉快，或覺得不舒服，馬上停止，下次再試試看，一旦嘗到甜頭，你一定會想繼續下去。

前面曾經提到，G點靠近膀胱和尿道，因此雖然刺激G點不一定會產生射精，但卻往往會讓人想要跑廁所。這種情形導致許多嚴重的後遺症，許多女性覺得丟臉、不好意思，或甚至因為害怕自己會真的尿出來，寧願壓抑G點的快感，甚至選擇禁慾。壓抑G點的快感，也代表拒絕達到高潮。

二十七歲的女裁縫師芭芭拉，最近來婚姻諮商。芭芭拉在性交的緊要關頭時，就一定要起來上廁所，這讓丈夫非常火大。事實上她在任何性行為前，她一定會先去廁所。她的恐懼來自幼年時的尿床經驗。當她知道這



只是一種想解尿的感覺，不代表一定得去上廁所時，她終於可以接受這種感覺，忍住想尿尿的衝動，體驗完整的性愛和釋放的快感。

雖然許多女性喜歡溫柔刺激陰蒂的感覺，但刺激G點得多用點力，才能帶來快感。一旦女性發現G點的位置和刺激的感覺，可以藉由壓迫小腹，達到刺激G點的目的。二十四歲的導盲犬訓練師維吉妮亞說：

一開始我完全不知道G點是什麼東西。我所有的快感都從刺激陰蒂而來。但經過鍛鍊我的陰道肌肉後，我和丈夫做愛時，開始嘗到高潮的感覺，特別是當他從後面進入我的身體時。丈夫常出差，於是我學會如何經由壓迫小腹刺激G點。我常一手壓迫G點，一手刺激陰蒂，雖然不能取代和丈夫做愛時的愉悅，卻是很好的自慰方法。

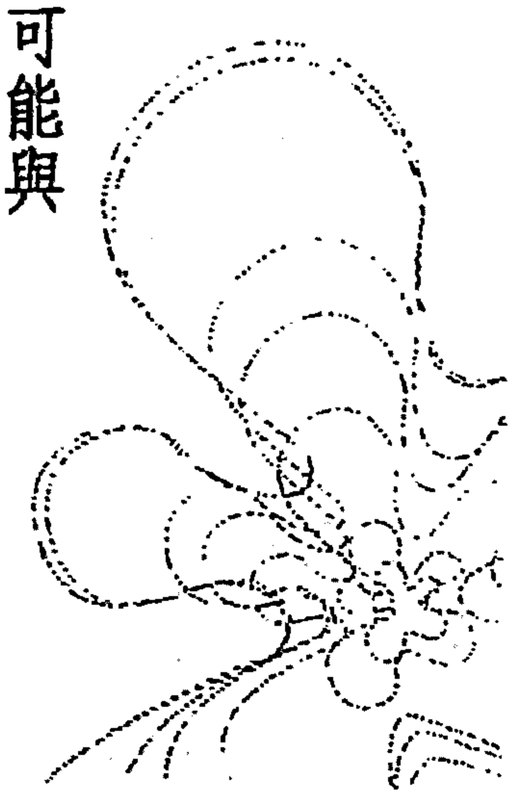
有些婦女在分娩時，因為G點過於敏感竟然有高潮的感覺，可能是因為胎兒經過產道時，刺激到G點所致。一位女士的來信中提到：

我最近生第二胎。你提到刺激G點時，會產生外推的效果，這可能與分娩最後階段時不自主的推動力有關嗎？很明顯的，當胎兒到達恥骨時，會對G點產生不小的壓力。

六十一歲，結婚三十七年的女士說：

我有三個孩子，生活幸福、快樂、有活力。但是有件事一直讓我十分困擾。我生第二胎時，在醫院待產，醫師要我先上廁所，我坐在馬桶上，腦子裡完全沒想到性愛的事，卻體驗到此生最棒的高潮。醫師要不是不想談，就是不相信，我心裡一直有罪惡感。當我告訴女性友人時，她們認為我瘋了。當時可能是胎兒的位置壓迫到G點嗎？

雖然有文獻提到這種現象，但還是一個可以繼續深入研究的課題。G點高度敏感有時的確可能會造成困擾，下面這位女士的經驗就是個例子：



我的G點很突出，又很敏感，做愛時總是高潮迭起。但到婦科檢查時，只要陰道撐開器碰到G點，就好像打開開關一樣，高潮馬上就來了，我得很專心才能把持得住。

另外一位有類似經驗的男士寫道：

我幾年前意外發現G點，我不知道它是什麼，但我知道只要適當刺激，性伴侶就會被快感融化。過去幾年，我有幾位不同的性伴侶，因此也注意到，雖然都是刺激G點，但每個人的反應都不一樣，有人反應平平，有人則是會有像「火山爆發」似的高潮。

了解G點的存在和位置，對外科醫師來說十分重要。切錯地方，可能剝奪女性未來的性福。從訪談和來信發現，手術對性愛會帶來正面還是負面的影響，取決於手術的類型，及被手術影響的神經和組織。一些女性表示，切除子宮後，反而增加快感；但也有一些女性則覺得性愛的愉悅不如以前。

刺激G點一直可以讓我達到高潮，我覺得很棒，我和我先生兩人都非常享受這種感覺。九年前大概三十歲的時候，我動了子宮摘除術，但仍有卵巢，手術後，做愛時高潮的感覺變得更好。

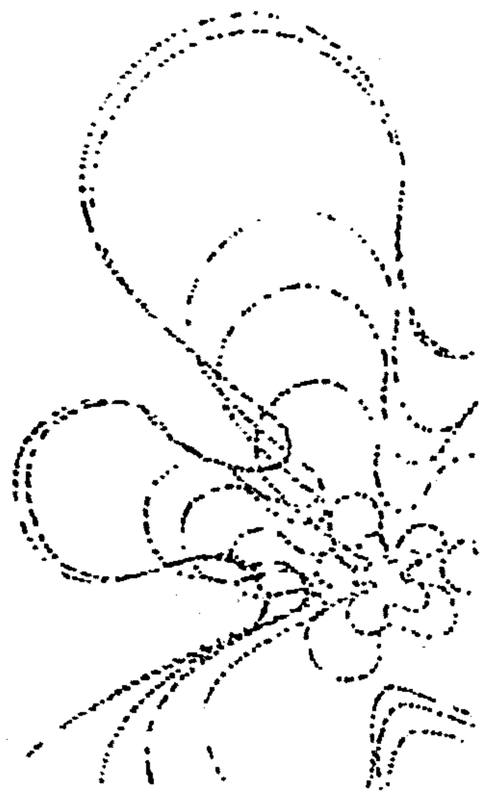
一

但手術卻帶給另外一位女性完全相反的結果：

我有一陣子相當擔心，不斷問幫我動子宮摘除術的醫師，為什麼手術後就再也沒有感受到體內的高潮。他嗤之以鼻說，沒這回事。他也幫我修補膀胱。手術與我不能再達到高潮有關嗎？有手術可以矯正嗎？

我們不再認為陰蒂是女人唯一的性興奮中心，因此破壞G點附近的組織都可能破壞G點或感覺神經，也就是縮減或消除另一個性快感的來源。

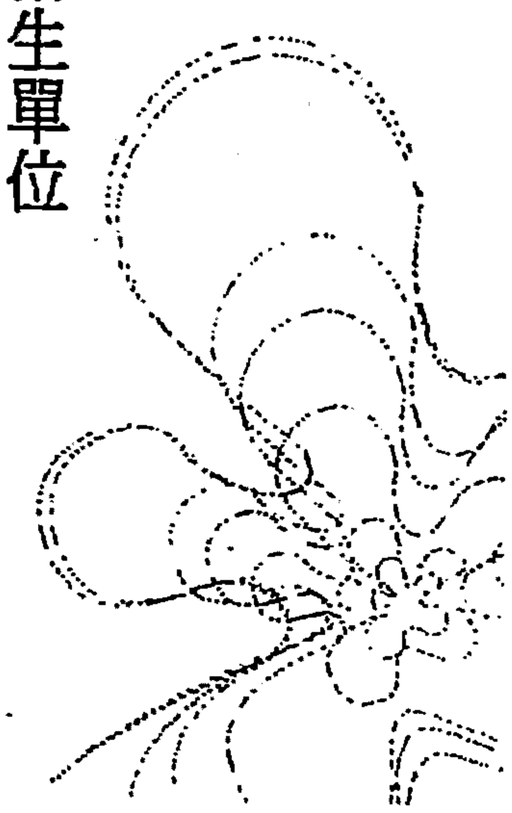
一位女士問：



去年六月，婦科醫師告訴我，我要切除部分子宮以來，一個很重要的問題一直困擾著我。我今年四十二歲，二十二年的婚姻生活中，性生活一直十分美滿。我能感受到深層的高潮，就像要把子宮往下推的感覺，如果我沒了子宮，我要如何才能感受高潮呢？我實在不想跟我的婦科醫師討論這個問題，他是個男醫師。雖然我對他很有信心，但我對高潮的感覺和反應，只有我自己最清楚；我擔心跟一個男人談這些，根本起不了什麼作用。

葛瑞芬柏格曾寫到，進行子宮摘除術時「如果切除了陰道前壁的性敏感點的話」，女性可能在切除子宮後，無法再經歷高潮。然而，許多女性說，子宮切除以後，仍然可以感到下推力量帶來「深層高潮」。這可能是因為連結子宮和G點的神經還連著，因此陰道上半部的肌肉反應不受影響，特別是在摘除子宮時保留骨盆神經。（審訂註：一般子宮切除手術並不切除陰道前壁，在因為尿失禁或膀胱脫垂做陰道前壁修補術時，才會切除一部分多餘的陰道組織。）

另一個醫療上的問題則是子宮帽對G點的影響。子宮帽是美國衛生單位推薦的避孕方式，可能妨礙G點的刺激。有些個案則表示，使用子宮帽後，雖不是完全無法接觸到G點，但卻增加刺激G點的難度。一位年輕女性對於過於激烈的性愛反應覺得不好意思及罪惡感。



性交時的反應如此強而激烈，真把我嚇壞了，這跟所學的完全不一樣，讓我們措手不及。只要一開始做愛，高潮一波接著一波而來。幸好後來我開始用子宮帽，謝謝老天，終於不再有這種情形了。

一位女士來信說：

我是一個二十九歲的已婚婦女，享受性愛帶來的感官愉悅，已經有十年的時間，拿世界來換，我都不給。但我曾使用子宮帽一段時間，我馬上感覺到用子宮帽很難再享受高潮的激情了。

但對其他女性而言，使用子宮帽不會妨礙刺激G點。一位四十一歲，婚二十三年的女士說：

我用子宮帽已經五年了，但似乎不會阻礙高潮，有時甚至還讓我有激情的感覺。做愛的姿勢很重要，不只可以從後方進入，兩腿張開高舉頭時，也可帶來高潮。

每位女性的G點位置，關係著她是否能用子宮帽，因此在決定使用何種避孕方法前，必須慎重考慮。

G點位在恥骨正後方的女性，就算使用子宮帽，也不會妨礙高潮的產生。如果子宮帽的確影響做愛時的感覺，可以改用一九八八年美國食品藥物管理局核准上市的子宮頸帽（cervical cap）。子宮頸帽置入的位置靠近子宮頸，不會妨礙G點的性刺激，葛瑞芬柏格和狄更生早在一九四四就意識到子宮帽可能引起的問題，他們寫道：

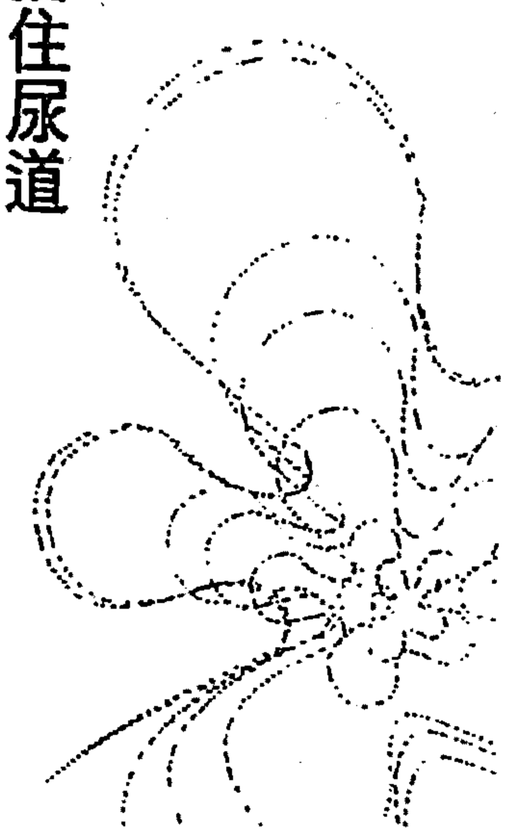
子宮 物產 種 過更 結

有時病人會抱怨因為使用子宮帽而無法達到高潮，因為子宮帽擋住尿道下陰道前壁表面的性敏感區。而子宮頸帽不會像子宮帽一樣蓋住陰道前壁，只要換用子宮頸帽就不會有問題了。

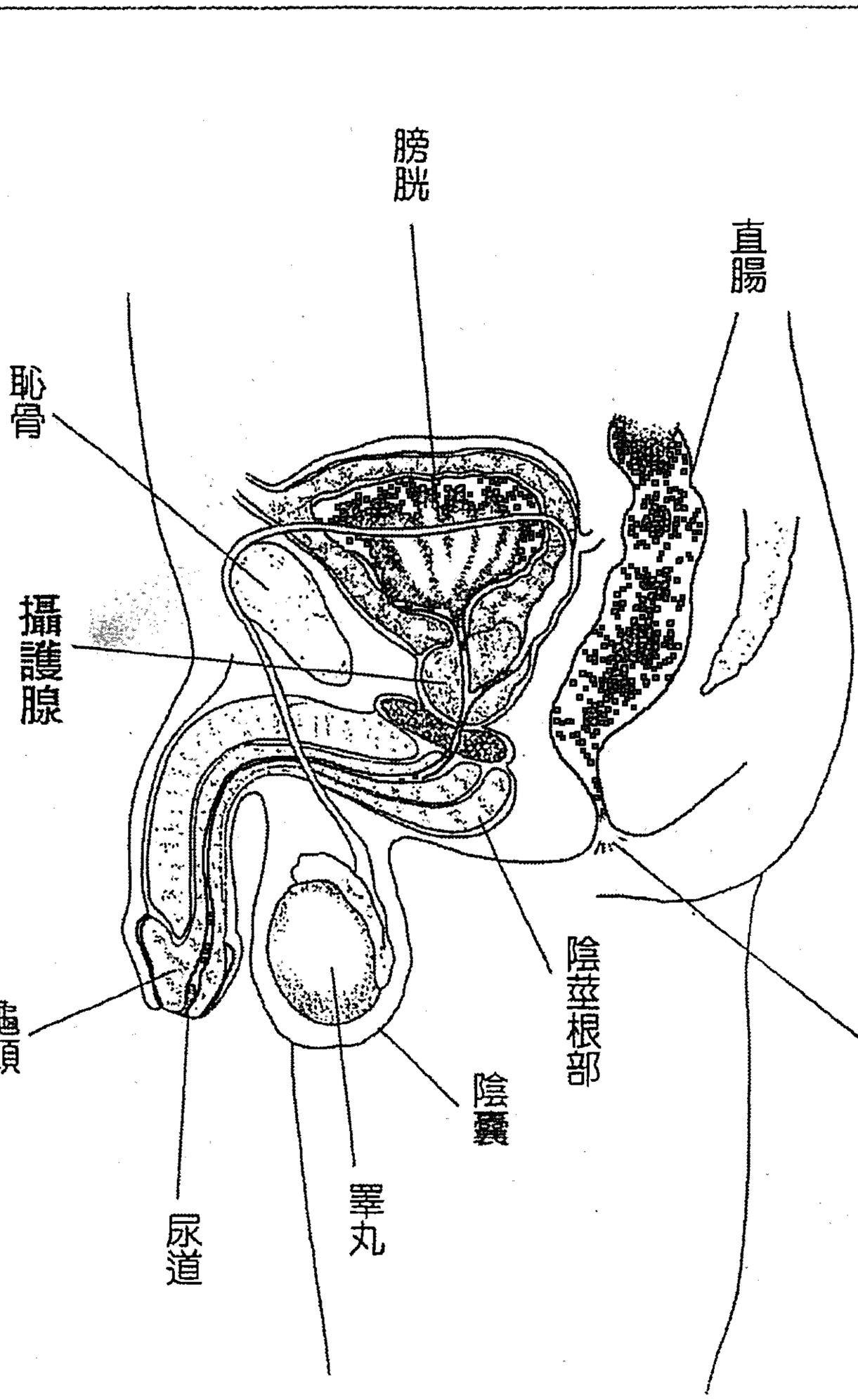
即使知道子宮帽可能會破壞性交時對G點的刺激，還是選擇用子宮帽避孕的女性，不妨先請伴侶嘗試用手指刺激G點，再決定是否真的要把子宮帽放進去。（審訂註：在台灣，幾乎沒有人使用子宮帽做為避孕方式。）

男人也像女人一樣，有一個類似G點的敏感地帶，位於尿道與膀胱連結的膀胱頸附近。這個敏感地帶有個大家比較熟悉的名稱——攝護腺。就跟G點一樣，用手指或陰莖刺激攝護腺可以帶來快感，但男人很難自己觸摸到攝護腺。

有人將大姆指塞進肛門，壓迫直腸前壁，並朝肛門口向下按摩。刺激攝護腺的最佳姿勢為，平躺在床上，抬起膝蓋，腳踩在床上；有些人喜歡把腿拉近胸前。攝護腺大概在直腸內幾寸的地方，透過直腸前壁，你可以摸得到攝護腺，感覺是個軟軟的圓狀物。醫療衛生機構提醒，伸進直腸的任何物



圖二一　男性生殖器



體，在接觸到身體其他部分前，必須先用清水和肥皂洗淨。

醫療檢查時，更不好受。但是當按摩攝護腺是性愛的一部分時，許多男人指剛開始按摩攝護腺時，就像刺激G點一樣，感覺不是很舒服，特別在出，感覺很好。碰觸到正確的部位時，會出現一種很爽快的感覺，無論在情緒或生理上，都與刺激龜頭時的感覺不一樣。就跟女人覺得刺激陰蒂和刺激陰道是兩種不一樣的感覺。

刺激攝護腺並配合射精時，不是噴出液體，反而比較像流出，雖然精液量與正常時差不多。有些男士認為，刺激攝護腺產生的高潮，是一種下壓的感覺，類似女人G點高潮的經驗。你還記得本章一開始提到的霍伊茲夫婦吧，非常愉快的試驗攝護腺刺激等各種性愛活動。

我們對G點快感的新資訊，有助於了解男性攝護腺快感。第一個發現G點的並不是葛瑞芬柏格，而是十七世紀的荷蘭解剖學家雷格納．迪葛拉夫（Regnier de Graaf），他是最先以現代觀點描述男性和女性生殖器的學者。不像幾位當代的解剖學家，他不只觀察女性的生殖器結構，也關心女性的情欲。迪葛拉夫詳細描述尿道裡有一層膜，「稱這個物質為女性攝護腺或是腺



體（corpus glandulosum），應該相當合適……。」他進一步指出，「女性『攝護腺』的功能是分泌愛液，增加女人性慾……。值得注意的是，女性攝護腺分泌液體時的快感，與男性攝護腺分泌時差不多。」

我們讀賽維利和班奈特一九七八年在《性學研究期刊》發表的文章時，才發現迪葛拉夫的研究是他們有關女性射精傑出的評論和文獻分析，為本書中許多主題點燃研究的火花。

無論如何，G點的知識則不限於迪葛拉夫和葛瑞芬柏格的著作，其他還有許多醫師和解剖學家都曾提到G點，但重點卻不在性愛上，而是它可能引發性傳染病或手術併發症。至於G點在健康上的功能則談的不多，甚至沒有著墨。

一八八〇年，亞歷山大．史凱奈醫師（Alexander Skene）在文章中討論，當女性尿道周圍腺體和導管感染淋病時，把液體抽乾的問題，還配合療程畫了非常詳細的圖。因此到了近代，女性尿道腺體被稱為史氏腺（Skene's glands），現在則稱為女性攝護腺。史凱奈之後，又有其他許多學者撰寫相關文章。這些學者認為，女性尿道腺體與男性攝護腺源自相同的胚胎組織，

腺體的組織與五個月或六個月大男性胚胎的攝護腺相似。

一九四一年，喬治·卡威爾（George Caldwell）醫師的研究報告指出，腺體在不同個體身上的發展並不相同。

腺體的結構和分泌物，只能與男性攝護腺相比……它們是胚胎的殘留物，在女性身上沒有什麼重要的功能，但是很明顯的，在正常女性身上，會對功能性的刺激有反應，經常從腺體出現分泌物。

近半個世紀來，沒有其他人認為史凱奈的發現值得進一步探究。一九四三年，婦產科醫師約翰·霍夫曼（John W. Huffman）開始研究史氏腺，他的結論認為，史凱奈在很多方面都低估了這些尿道周圍的腺體和導管。同一年，美國醫學會期刊中發表女性「攝護腺」肥大，必須以手術治療的個案研究。

一九五三年，泌尿科醫師山繆·伯考（Samuel Berkow）認為，G點是個勃起組織，應被視為「海綿體」，也就是類似男性陰莖的勃起組織。但是伯考從來沒有研究什麼樣的情形下G點會勃起。他的興趣在於排尿，他覺得



「勃起組織」的功能在於收縮尿道控制排尿。不幸的是，其他的泌尿科醫師並沒有發現G點具有括約肌的功能，很快忘記「勃起組織」除了在泌尿科的領域之外，還有沒有別的作用。

我們應該移除這團被稱為「女性攝護腺」的組織嗎？沒有人質疑它的生理構造與胚胎組織的相似性，問題只在於它分泌的是不是精液而已。男性攝護腺的功能為製造精液，精子則是睪丸製造的。如果G點是與男性攝護腺同源的胚胎組織，在某些情況下，有些女人的G點會產生一些液體，應該也不令人意外。接下來我們要進入培瑞與惠普另一個引起性學研究者注意的重要研究——女性射精。

# 第三章

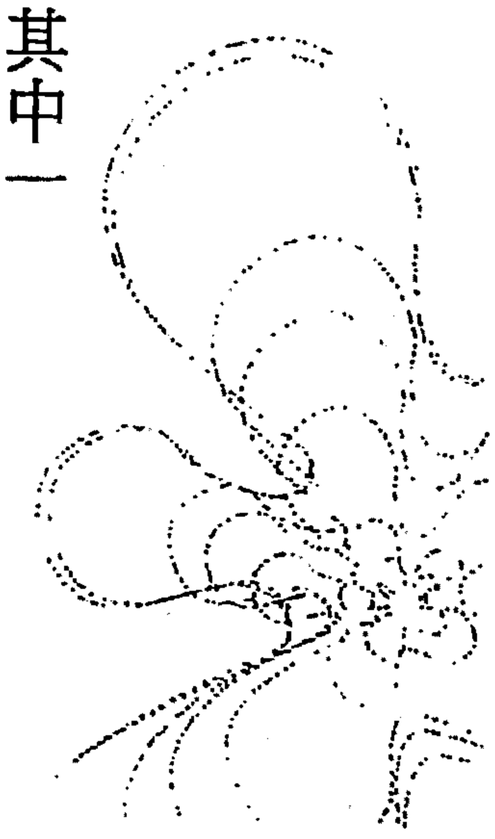
## 女性射精

第一次射精時，我根本不敢相信，因為我從來沒有尿失禁，也總是在性行為前上廁所。不過，不論如何，我的伴侶和我都沒有受此影響，畢竟性愛的歡愉戰勝了負面的想法。

項明確的差異提及女性哺乳、男性射精。不論是何種論述，《新聞週刊》都錯了。先前章節曾提及，在某些特定條件下，男性同樣可以哺乳，而許多女性也曾談及她們射精的經驗。事實上，女性射精的相關探討可以回溯至史前時代。

先前提過，亞里斯多德或許是第一個撰文探討女性射精的學者，而蓋倫在西元前二世紀對此亦有研究。迪葛拉夫在〈女性生殖器官的新論述〉一文中，對女性攝護腺有些細微的描述：「性行為時，攝護腺分泌旺盛，甚至還會溢出外陰部，被視為女性的精液」，他還進一步形容，液體流出時是呈現爆發的狀態。

相較於G點，雖然女性射精的研究更具爭議性，但這畢竟是少數女性才有的體驗。培瑞與惠普曾為女性檢驗出G點。幾年前詢問男女受訪者，他們的伴侶或自己是否曾有射精的經驗，僅有百分之十舉手承認，不過，這比率逐漸成長，近來已接近至百分之四十。比率增加原因為何？承認女性射精的可能性或許可幫



助女性精準描述她們的性經驗。如果女性或其伴侶瞭解女性射精的存在，或許他們會更樂於承認自己曾有同樣經歷，也或許有更多婦女願意展開首次體驗。另一方面，其他婦女只是提出社會比較願意接受的答案。然而，如果可以匿名作答，承認射精的女性比率是最高的。

儘管如此，並非多數女性擁有射精的經驗，而這也是十分重要的課題。例如以下的案例：

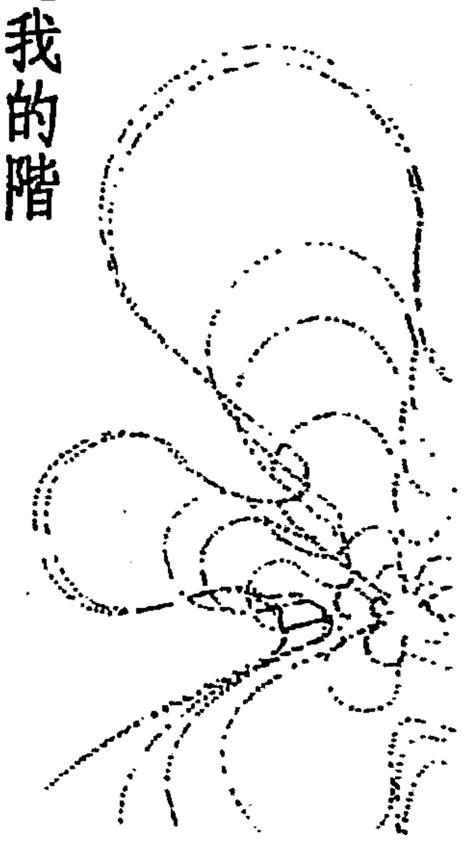
當麗莎醒來時，天都還沒亮，結婚兩年的丈夫約翰躺在一旁，手輕放在她裸露的大腿。約翰的撫摸誘發了她的春夢嗎？麗莎心想，感謝老天，高潮來襲前起床。為了確認，麗莎摸了摸床單，床單是乾的，她嘆了口氣轉過去望著約翰，很少男人能像約翰一樣深深吸引她，也沒有人像約翰一樣，對她如此深情溫柔，充滿「性趣」，然而，這卻成了她的困擾。

麗莎認識一些無法達到性高潮的女性，不過她沒有這類問題。相反地，從婚前的性經驗，麗莎知道自己可以有多次性高潮，也能充分回應，享受歡愉。但那都是過去的事了。當她與約翰發生性行為時，她無法盡情歡愉，

如果順著情慾發展，就會演變成極為尷尬的場景，因為每當進入忘我的階段，伴隨而來的是，她會排尿。為此，她深感丟臉，而性行為時有這類的困擾，誰還會想與她共享親密關係呢？

經歷一連串不甚滿意的感情，麗莎認識了約翰，兩人之間強烈的彼此吸引，也能充分感受到那份親密感，但麗莎還是約束自己，避免和約翰有肢體接觸的親密，因為她太在乎約翰，不想冒著失去他的風險。麗莎沒有告訴約翰關於她是處女的事情，相反地，她以另一種方式解釋自己的與眾不同，也就是讓性關係快速進展，或許他們會因此失去永久真愛的情誼。約翰厭煩了單身生活，不願再流連於不同對象的床上，也不想再談速食愛情，性關係來得快也去快。麗莎吸引他的地方不只是肉體，因此，他決定耐心等待，直到麗莎願意點頭。當時，約翰對結婚沒有興趣，他甚至曾經想過，麗莎是否藉此逼婚。

即使曾有疑慮，但約翰深愛麗莎，兩人最終仍幸福地步入禮堂。婚姻讓麗莎有十足的安全感，因為她可以盡情享受與約翰的性關係，不必擔心對方會因為她的性怪癖而離開她。然而，結婚當晚，麗莎還是退縮了，因



為她太愛約翰，無法想像對方如果不認同她的下場。所以，她決定逃離，不讓自己臣服於約翰絕佳的性愛技巧。從那一天起，她開始假裝高潮，這是她唯一對他說的謊言，也是兩人之間僅有的祕密。

麗莎移動身體，換個比較舒適的位置，轉身背著她的丈夫，手下意識地摸向陰蒂，陰道是濕潤的，盡情自慰讓她越來越興奮，甚至想要大聲呻吟。不過，擔心吵醒丈夫，她只能把頭深深埋入枕頭發洩。

麗莎自問，她這樣多久了呢？到底有幾次她得背著約翰，轉過身自慰達到高潮。麗莎清楚知道，既然已經有幸福婚姻，她就不該自慰。教會曾經告知，而以前上課時也學過，佛洛伊德談及女性如何藉由陰蒂達到高潮。麗莎知道在性行為過程中可以盡情回應，但那只會讓自己丟臉，而這部分她在課堂上未曾學習。另外，她感到困惑的是，陰蒂高潮被視為幼稚，但她又確切知道可由性交和自慰獲得滿足。

深陷歡愉，麗莎轉過頭要確認約翰仍在睡夢中，卻發現他的雙眼睜大。約翰充滿渴望的眼神望著妻子，他開口問：「你知道我躺在這裡等了

多久嗎？」

麗莎：「拜託你，約翰，現在不要討論這件事。」

約翰慌亂地坐起來，眉頭緊皺，表情充滿困惑。「我真搞不懂妳，妳以為我相信妳一點都不興奮。」

約翰起身穿衣服，一邊說：「麗莎，我們不該連討論的空間都沒有，我愛全世界再也找不到比妳更好的老婆，可是，妳卻無法投入與我做愛。」

「你明明知道我每次都有高潮。」

「過去兩年妳確實都這樣說，但我知道不一樣。妳真的以為可以永遠欺騙我嗎？妳難道不知道我可以察覺發生什麼事嗎？」

「如果你知道，那你為什麼從來沒有問過？」

「好啦！這下妳可承認以前都是假裝高潮。」

麗莎把眼神移開，不願再多說，她想，約翰大概會建議她去向婦科醫師求診，但事實上早在兩人相戀前，她就曾經就醫，婦科醫師將她轉介給精神科醫師，在二十堂的課程中，醫師帶領她回溯至童年。例如她常尿床嗎？但這些探索卻沒有替她解惑，相反地，她覺得自己像怪物。



麗莎和約翰的情況並不特殊，許多男性、女性均曾來信詢問女性射精的問題，而他們皆因此而困擾與伴侶的關係，許多女性甚至不敢承認自己會射精。一名三十四歲女性的來信提及：

我每次和老公發生性行為，都會弄濕床鋪，即便最輕微的狀況也會弄濕一角。可是我老公一點忙都幫不上，他只會一直叮嚀我在上床前先上廁所。離婚後，交了新男友，令我感到羞愧的是，他也會為了我射精的事感到不悅。

性學書籍的作者亦提及：

我有一位朋友，她男友完全無法接受她高潮時射精，甚至覺得噁心，也因此決定分手。可憐的女方花了好長時間才從創傷中復原，她認為一定是自己有問題，她的醫師則說是生理問題，許多婦女高潮時都會出現尿失禁。因此，她多年來避免親密關係，也花了很多時間、金錢接受心理諮商。

幸運地是，並非每個人都深受女性射精困擾，事實上，許多來信提及，女性射精讓他們與伴侶之間的關係更為親密。一名女性寫道：

我十五歲時第一次發生性行為，也開始有射精的經驗，性話題在當時仍為禁忌，我只能猜想，所有女性應有同樣經驗。男友以他的中指深入愛撫，足以讓我達到高潮。之所以知道他的手指夠長是因為，之後我陸續和其他四位男性交往，但卻沒人能給我相同刺激。說起來一點都不誇張，每當我們結束車震，我的褲子總是濕透，回家前甚至要到洗衣店烘乾衣服。直到最近，我才知道自己的經驗非常特殊，因為性話題不再是禁忌，一年來我曾問過我的姊妹、朋友，甚至包括我媽，但沒人知道我在講什麼。

最後，我問我的婦科醫師，那些液體究竟從何處流出，他反問是什麼是好。他進一步解釋，陰道內壁會蘊藏一些汁液，但沒有東西與我的描述吻合。

液體，聽完我的敘述後他說，那不是液體，而是尿液，我聽了不知該說什



她無法接受婦科醫師的解釋，最後歸納的結論是，她在性方面擁有某種天賦。

以下是一位更幸運的女性自述：

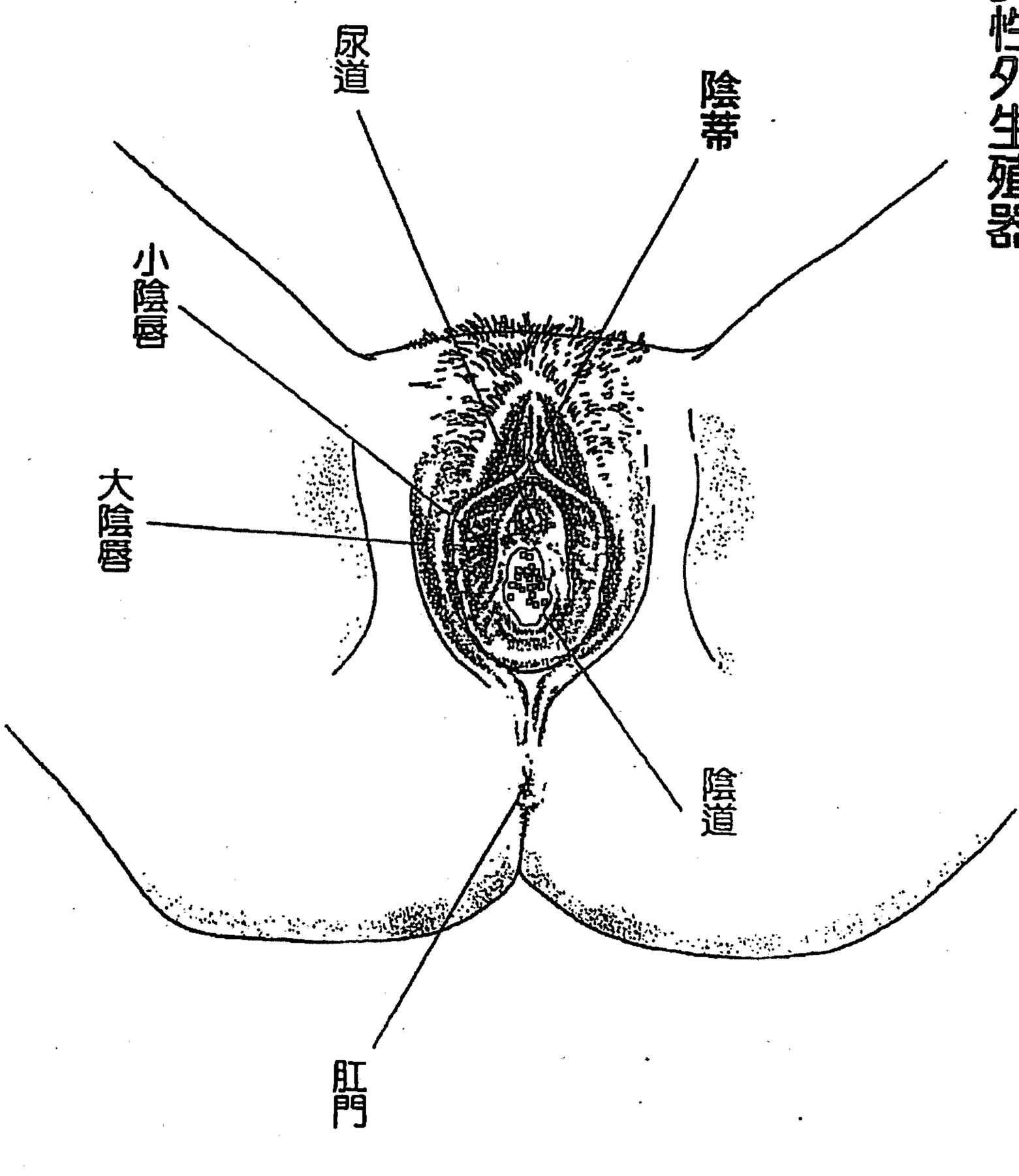
我是婚後才發生性行為，丈夫是第一位也是唯一一位性伴侶。一開始，我總是感受到前後的抽送，過程中也流出一些液體。不過，直到最近生下第二個孩子，開始感受到陰道內的點。每當開始出現興奮的感覺時，點會腫脹、突出，確實碰觸到先生的陰莖，流出的液體甚至超過先生射出的精液，好幾次甚至都弄濕他的下腹。我很滿意現在的性生活。

和男性一樣，女性射精同樣是在高潮時有液體自尿道流出，尤其在刺激G點時特別明顯。

一名結婚二十八年的德州女性說：

一九七四年起，我就有射精的經驗，不過，前戲或陰蒂高潮時不會流

圖三一 女性外生殖器






出液體，只有以陰莖或手指按摩G點時才會流出。我今年四十八歲了，我想人生四十歲才開始吧！

一名男性提及：

當我要為太太口交時，我先把手指插入她的陰道，然後往上推，我可以感受到裡面不斷發腫，直到流出約兩湯匙的液體，我稱之為愛液，而她也在此時達到高潮。

另一名女性也來信提及和先生之間有美好的性生活，不過並非一開始就達到高潮。

我是在一九六九年結婚，當時的風氣對女性而言，仍然無法進行享受性愛。我很高興有個愛我的先生，因此我也不在乎是否有高潮。有一天，事情發生了，我先生一邊以嘴巴親吻，一邊以一根或兩根手指插入我的陰

道。我的天啊，我感受到裡面的動作，感覺相當美好，突然間流出液體，依我看應該是突然刺激而排尿。從那天起，十二年來，我們始終擁有幸福的生活，不論是性生活或其他方面。我相信其中部分原因是因為十二年前的發現。性生活如此愉悅，儘管會搞得一團混亂，但我們不在乎。

此外，少數女性宣稱，陰蒂高潮亦能讓她們射精：

我定期以按摩棒自慰陰蒂，當高潮來臨時，可以感覺到液體流出，我想那大概是尿液，但仔細觀察，我發現這液體很像是陰道高潮時所流出的液體。

流出液體多寡因人而異，也會因不同的場景而有所不同。一名五十六歲的男性告訴我們，女性流出的液體量都不一樣，一般而言如果男性持續予以刺激不中斷，流出的液體約有杯子一半的量，因此而來的高潮對女性而言可說是絕佳的經驗。一名二十三歲的系統分析師提及：

我能清楚感應到子宮壓迫向前，一波波的高潮讓我雙眼噙淚。不過，直到我從床上起身時，才發現床都濕了。

「這都是我的？」

「是啊！」他說

「所有的？」

「嗯……我連褲子都還沒脫呢！」

「哇！」

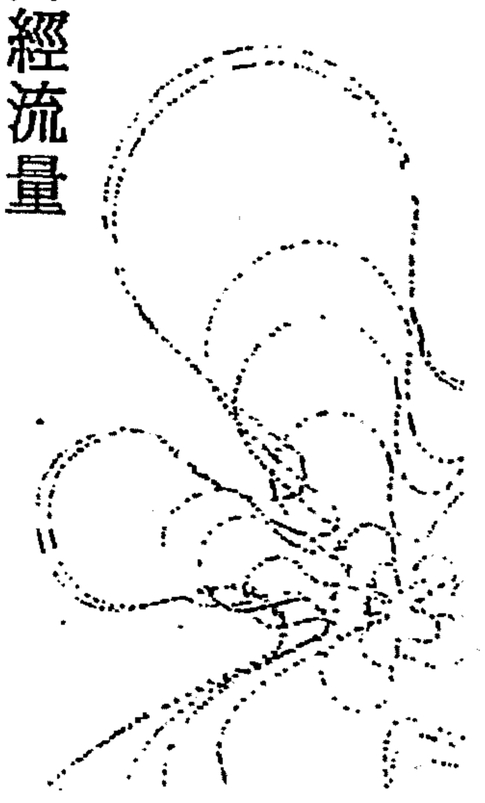
從此以後，我的G點成為「愛的觸鈕」，也因為這項發現，我對性事的熱衷程度倍增，我到達高潮時也表現得和男人一樣。

一名六十歲的老婦形容：

婚後第一年，我就有大量的液體流出，有時候只有幾滴，但其他時候流量可能多達一品脫（約0.47公升）。

進一步思考，來信者對於液體的數量似乎都有誇大，例如像月經流量（大約四湯匙）或精液量（約一湯匙），類似的形容有時與實際情況有落差。即使那名五十六歲的男性觀察正確，女性流出的液體量確實沒有標準值，但他說會流出半杯，也可能是誇張的說法。根據培瑞與惠普及他們同事的觀察，女性射精流出的液體大約只有幾滴至四分之一湯匙的量。

女性高潮射精時排出的液體究竟為何？液體的顏色、氣味、味道都不像尿液，留下的漬跡也與尿漬不符，而對於液體的形容也各有不同，有的說是無色、純淨，也有形容是乳白色。然而，沒有女性形容液體為黃色，但儘管如此，還是有人擔心，射精就是在排尿。一名三十幾歲的女性由醫師得到巧妙的答案是，所謂女性射精其實是尿失禁，她不相信醫師的話，自行設計一套的實驗加以驗證。首先，她服用可讓尿液變成藍色的藥物，感受多次高潮後，她觀察床單上的痕跡。有些完全沒有顏色，有些僅有極淡的藍色。接著，她故意在床單上小便，結果精準地顯現出深藍色，因此，她歸納的結論是，高潮時流出的液體並非來自膀胱。一名生下雙胞胎的二十二歲女性則說，她的液體乾掉後只剩白色粉末狀的東西，沒有留下痕跡。



不論男女都提及，女性射精時流出的液體沒有味道，當然也不是尿液的味道。一名婦女說道：

雖然醫生說這是尿液，但我嘗過也聞過，確定那不是尿液。

其他人也形容，液體的味道並非每次都相同。一名結婚二十年的奧勒岡州的男性擁有兩個孩子，他說：

我早就知道那液體不是尿液，有時候嘗起來是苦味，但通常是甜味，之所以有差別是因為女性的飲食或新陳代謝所導致。

過去早有研究顯示，男性精液的味道會因為飲食內容而有所改變，或許同樣的道理也可應用於女性射精的情形。

一名結婚十九年的女性擁有兩名分別為十歲、十二歲的孩子，她自稱是虔誠的基督教徒，根據她的形容：

液體的味道在一個月間改變了四次，有時是強烈的氣味，有時則是很甜的味道。甜味約持續了三天，而且剛好就在月經來之前，味道真的不錯，比蜂蜜的味道好，濃度較淡。

不只是味道與外觀，液體流出的頻率也有差異。有些女性宣稱每次性行為時都會射精，有些女性僅是偶爾發生，不過，其中部分女性也歸納出射精的週期，可能是與月經的週期有關。

結婚十三年，我幾乎每次性行為都會射精，而且一次性行為中會發生多次射精。

一名五十八歲的祖母級女性提及：

隨著高潮發生，我幾乎每次都能射精。



另一名二十七歲的護士則說：

每兩次性行為，我就會有一次射精。

一名二十六歲的分娩訓練人員育有兩子，有著快樂的婚姻，她形容

性行為時，我發生射精的機率是六分之一，流出的液體無味無色

液體流出時，我可以極度放鬆。

兩性對於女性射精的看法究竟為何？有人覺得噁心，有人為此著迷

人感到困惑，也有人可接受。令人驚訝的是，許多六十歲以上民眾也不

分享這方面的經驗。最經典是這名女性，她形容自己：

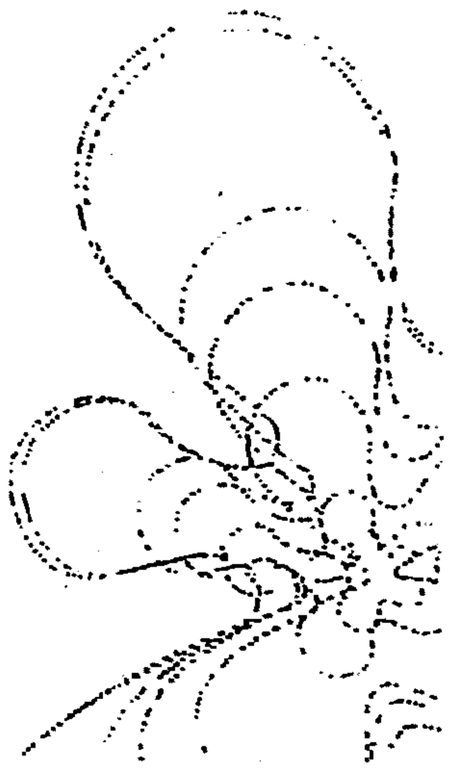
六十八歲的年輕人，九年前嫁給比我年長六歲的丈夫。

自己是一名結婚三十八年的六十二歲女性則寫道：

她補充說：

謝謝你的回答，解決了許多難以啟齒的問題，也讓我不再困惑，證明自己是個正常的女性。

床，好幾年來，我時常感受到射精的經驗，那真的像噴泉一樣，足以弄濕時比較容易射精，先生和我都認為會出現射精是因為性愛的歡愉達到高峰，有著特殊的味道，這和潤滑的經驗都明顯不同。一般而言，我在上位通常我們兩個都會有多次的高潮，我想其他女性也有同樣的經驗。



體育成績都是水準以上，太太形容：

一名三十七歲的太太和她四十三歲的先生，兩人都是高中畢業，學業及

我所讀過的每篇文章都堅稱不可能發生女性射精的情形，但我並沒有因此隱藏自己的經驗，多年來我覺得自己像個怪物或女色情狂，我相信我老公也有同樣的想法。

一名二十六歲的護士目前正在攻讀碩士學位，她的來信提及：

第一次射精時，我根本不敢相信，因為我從來沒有尿失禁，也總是在性行為前上廁所。不過，不論如何，我的伴侶和我都沒有受此影響，畢竟性愛的歡愉戰勝了負面的想法。

一名二十八歲的女性則寫道：一

女性射精也是有缺點，當我在上位時，溫暖的液體會往下流到我老公的生殖器，讓他無法克制。

另一種極端的情形是，一名二十一歲的離婚婦女提及，她的丈夫堅信她是故意尿在他的身上，因此有一天，「他故意尿在我身上後離開，然後提起離婚的訴訟」。

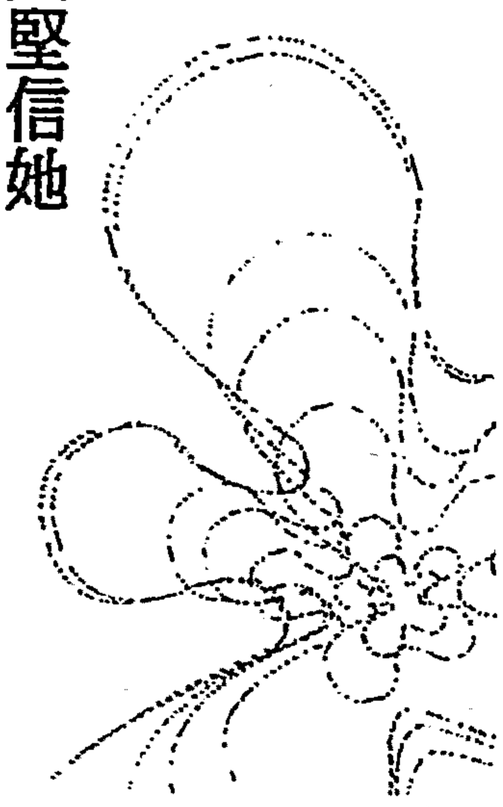
現今醫學研究尚未認可女性射精的存在，女性射精被視為維多利亞時代的情色幻想或是尿失禁問題，但既然如此，為何有許多人已有經驗？許多女性還為此尋求醫藥上的協助，藉此瞭解發生在自己身上的現象。

一名阿拉巴馬的女性最近喪夫，她寫道：

多年來我和其他婦女一樣，求助醫師甚至是女醫師，希望他們可以解釋發生在我身體的現象。有些醫生說是膀胱無力，但其他醫師只是解釋說，有些女性的濕潤程度就是勝過其他女性。

一名四十二歲的女性分享她自己的看法：

當我切除子宮後，開始感受到液體流出，這讓人很不好意思，也隨即



改變了我。幸好我有一個瞭解我的丈夫。當我就醫檢查時，我告訴醫師關於身體的變化，醫師建議，如果再有類似情形，就必須轉介給外科醫師。

一名六十歲的女性沒有接受建議，她心情放鬆地說：

二十年來我花錢看了無數的醫師，其中十人告知必須接受手術，然而，現在我終於知道所謂的問題，也知道我並沒有發瘋。

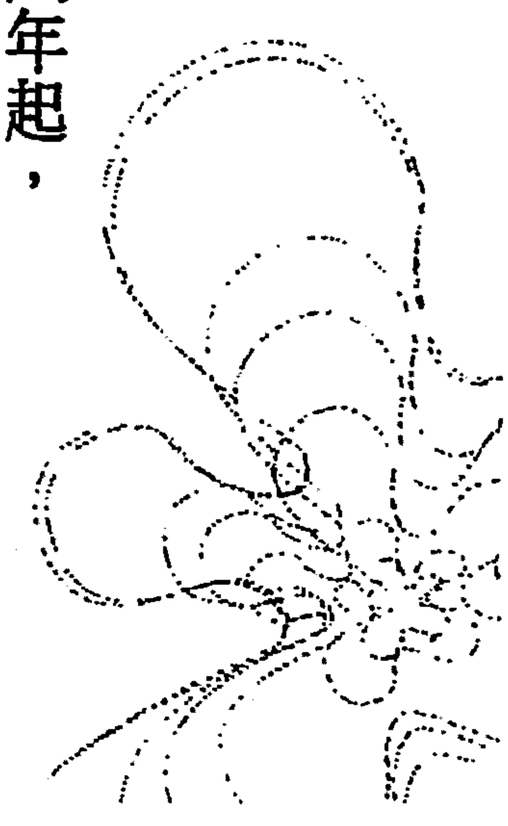
並非所有醫師都呈現漠不關心或大驚小怪等兩極化的反應，有些醫師會表達支持，但卻也無助於解惑。一名擁有三個孩子的已婚婦女說：

我問醫師，但他說醫界還不知道液體究竟自何處流出，他安慰我不必擔心，只要盡情享受，而我真的做到了。不過，我還是想瞭解自己的身體變化。

然而，有些醫師同時抱著支持的態度也會提供解答。自一九五八年起，泌尿科醫師伯納・海門（Berbard Hymel）就不願為這類的女性進行手術，雖然其他醫師診斷她們為尿失禁，但根據他的專業判斷，她們只是經歷高潮後有液體流出。海門看過研究報告，也知道G點和女性射精。他曾三度將他的看法告訴同事，不過他們都覺得他瘋了。明知道是對的，但他難掩孤單，直到遇見惠普，對方對他的見解予以肯定。

回顧女性射精的歷史文獻，重點會集中於眾所皆知的內容，以及探討為何被門外漢或自稱專家者所忽略。過去有同一批人同時關注G點及女性射精的議題，但外界均予以忽略。本章節之初曾討論亞里斯多德，但並非只有他們撰文討論G點及女性射精。一本名為《珍珠》的雜誌集結了維多利亞時代的短篇小說、詩、書信及民謠，內容充斥著女性射精的傳說。然而，這些內容卻被視為男性情色幻想而不被重視。

一九二六年，席多・范戴維爾（Theodore H. van de Velde）出版了一本極受歡迎的婚姻手冊，其中提及有些女性會在高潮時流出液體。人類學者亦曾提及，女性射精於某些非洲部落的成年禮中確實扮演重要的角色，例如烏



干達的巴塔洛部落有一種習俗名為Kachapati，也就是「噴牆」。村莊裡年長的女性會教導適婚的年輕女性如何射精。

一九五〇年，葛瑞芬柏格對女性射精與滿足之間的關係有很詳盡的描述，提及高潮時偶爾流出的液體，他描述：

當到達高潮頂端時，通常會伴隨液體流出。如果有機會從旁觀察，可以看到大量透明液體由尿道噴出，而非出自陰戶。這些大量的分泌物伴隨高潮而來，但不具有潤滑的意義，否則他們早在性行為之初就會流出，不必等到高潮。

雖然葛瑞芬柏格指稱已經檢視過液體，但他並沒有詳述檢視的步驟。

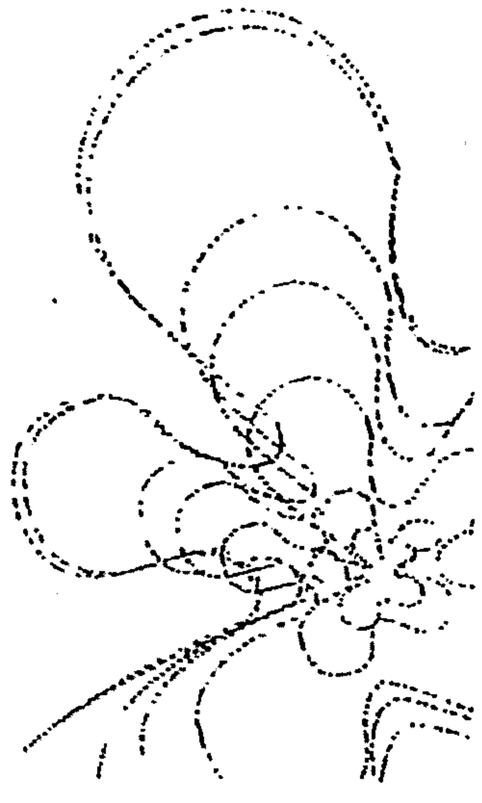
一開始，膀胱括約肌因高潮的強度而開始變化，性學文獻提及會有大量的尿液流出。而在我們觀察的個案中，那些液體不像是尿液，我相信女性高潮時流出的「尿液」不是真的尿液，而是尿道旁腺管的分泌物，主要

與陰道前壁沿著尿道的敏感帶有關。

既然液體自尿道排出，重點是要以科學方法證明女性射精和尿液確實不同。目前確信的是，男性高潮射精時所噴出的液體不是尿液，但除了葛芬伯格外，直到一九八〇年才有其他關於女性噴出液體的研究報告。

當年，由艾德溫・貝爾茲（Edwin Belzer Jr.）、惠普及培瑞組成的研究團隊，募集一批志願受試者蒐集她們的尿液和射精時流出的液體，蒐集樣本前最少四十八小時不得接觸到男性精液。接著，立刻冰凍樣本送至加拿大哈利法克斯的達爾豪斯大學（Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia）。一九八一年二月，其中一件樣本的分析結果刊登於《性學研究期刊》（*Journal of Sex Research*）。

其他樣本的分析結果和文章內容十分接近。化學分析根據四項試驗歸納的結論是，液體並非尿液。射精液體內的酒石酸抑制性酸性磷酸脢（tartrate-inhibited acid phosphatase）和葡萄糖，均高於尿液檢體，而尿素（urea）、肌酸酐（creatinine）則低於尿液檢體。



法蘭克·亞迪耶哥（Frank Addiego）及惠普將樣本送至當地的實驗室進行化學分析，樣本包括接受輸精管切除術的男性精液、女性射精的液體及尿液。同樣結果顯現，液體內的酒石酸抑制性酸性磷酸脢高於尿液，而男性射精的液體含量最高。

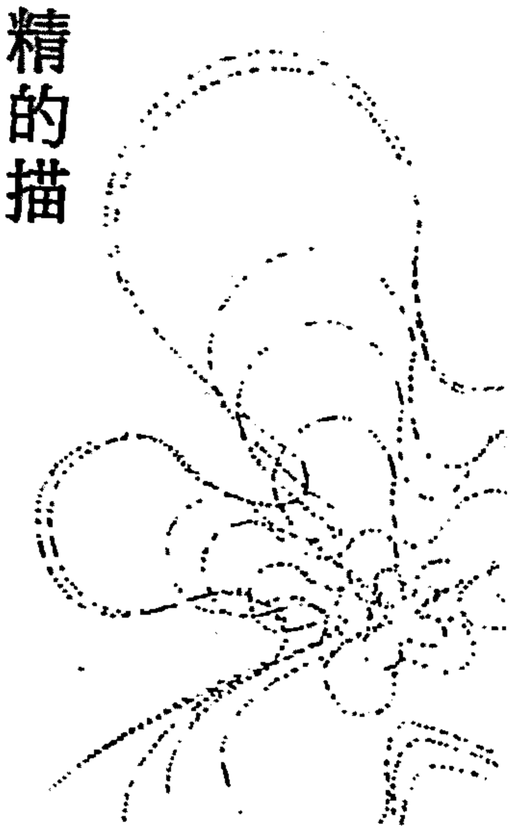
在貝爾茲的理論之前，賽維利與班奈特詳盡搜尋與此相關的文獻，同時撰文寫下結論，這篇名為〈女性射精及女性攝護腺〉的文章於一九七八年二月刊登於《性學研究期刊》。他們認為，女性可以射精，而且是經由尿道排出液體，液體則為攝護腺液。雖然未以化學方式分析液體，但他們廣泛瀏覽醫學文獻及大眾書籍，歸納出女性性行為時流出的液體，有助於性愛歡愉。

一開始，所有胚胎的生殖系統均相同，懷孕約六週後，受精卵開始分化出生殖腺體、內部生殖器，最後才是外部生殖器。卵巢和睪丸一開始的結構相同，但會依男性、女性各自有不同的發展。胚胎學者和解剖學者使用「退化」、「萎縮」的字眼形容男性、女性有許多相同的事物，而這些事物沒有明顯的功能，似乎頂多是異性體內對應腺體及器官的退化殘留。

述，回顧歷史，儘管醫學文獻及大眾化的資料有許多關於女性射精的描女性射精。但一直到賽維利、班奈特的文章發表後，現代的性學專家才願意正視一九六六年，馬斯特、強生形容女性射精是一項錯誤流傳的觀念。一九五三年，金賽對此議題投入較多的關注：

既然攝護腺和儲精囊是女性唯一退化的結構，她並不是真的射精。高潮之後，陰道肌肉收縮會擠出一些生殖器的分泌物，少數案例還得用力擠出分泌物。情色文學通常將其描述為女性射精，但這個名詞不能僅使用於情色文學的範疇。

傑爾曼．葛瑞爾（Germaine Greer）於一九七〇年出版的《女性閹割》（*The Female Eunuch*）中提及，雖然多年前已證實錯誤，但所有關於女性的不實概念依然流傳。例如許多男性堅稱，女性射精是幻想的情節，但事實上，女性射精概念的成形有長遠的歷史。



賽維利和班奈特認為，女性射精不被接受的原因一部分與語言有關，過去精液這個字主要是形容「種子」或「射精」。迪葛拉夫曾提及前輩的假設是，所謂的射精包括女性精液。然而，顯微鏡檢查的結果顯示，僅有男性射精的內容會有「精子」。因此，這個字眼原本在科學文獻中，可同時使用於兩性的液體，但如今只限男性。既然女性射精的液體內未含「種子」，就很難找到字眼形容。

除了G點及骨盆運動的重要性之外，南太平洋的托布倫島的民眾也知道女性射精。島上使用momona一詞可以同時形容男性、女性排出液體（Ipipi. momona，意味著噴出液體）。當地民眾認為流出的液體可以潤滑也能增進愉悅。西方人類學家理所當然的將女性射精視為神話，也強調許多美拉尼西亞的族群均在高潮時小便。不過，托布倫島的居民不可能將射精當成小便，同時將射精液體的功能定位為潤滑及性趣。生理上，男性幾乎不可能在高潮時排尿，同樣地，對女性而言，除非膀胱功能不佳或是肌肉無力，否則她們不可能在高潮時排尿。托布倫島女性通常在高潮時排尿的說法不僅牴觸島民自己的陳述，在生理上亦令人質疑。

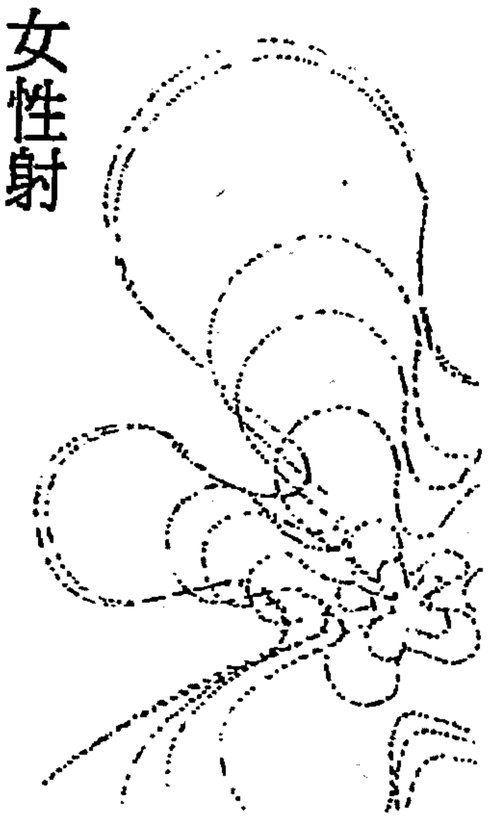
培瑞與惠普放大賽維利和班奈特的理論，「只要未經醫學正名，女性射精很快就會從科學研究中消失。另外，如果除去生殖目的，女性射精的功能只剩性愛時的歡愉，只為自己享受，這算是很新的概念，因此很少有人形容射精時的液體並未具有生殖功能。」

有時，很難界定女性射精及應力性尿失禁的差異，打噴嚏、咳嗽、大笑、跳躍或高潮時都會導致尿失禁，有時甚至同時發生，雖然尿失禁比較可能發生在骨盆底肌肉無力的女性，而能夠射精的女性多數擁有有力的骨盆底肌肉。

即使診斷為應力性尿失禁的差異，手術前應該完整評估骨盆的肌肉，因為尿失禁通常可藉由肌肉訓練而矯正。（第四章將討論肌肉狀態對性反應的重要性）

若僅將射精反應視為手術後產生的改變，這明顯是個不保險的說法。然而，有些婦女如這位擁有兩名子女的三十六歲婦女，二十七歲切除子宮後，她開始體會到手術可以幫助自己射精。

手術結束後，我開始想在性行為過程中排尿，那感覺如此美妙，我甚



至不想停止。我習慣在上床前上廁所，因此我確定那液體不是尿液。每次性行為我都要射精二至四次。我的內心深處深深覺得自己何其有幸能夠享受如此美好的性愛。當然，我不是鼓吹女性切除子宮享受性愛，但女性應該瞭解，子宮並非獲得性滿足的唯一途徑。

培瑞與惠普推論，射精的女性感染膀胱炎的機率較低，以下這名女性的說法至少可以支持這項理論，而這名女性會在射精時忍住不射。

性行為後，我很容易罹患膀胱炎，腹部絞痛。我猜想，這是否因為我試圖在性行為時忍住，不讓液體流出所導致。不過，我真的不知道那些液體究竟是什麼。

另一名女性提及：

我有點困惑，性行為過程中的尿意竟然可以演變為愉悅的感覺，之所

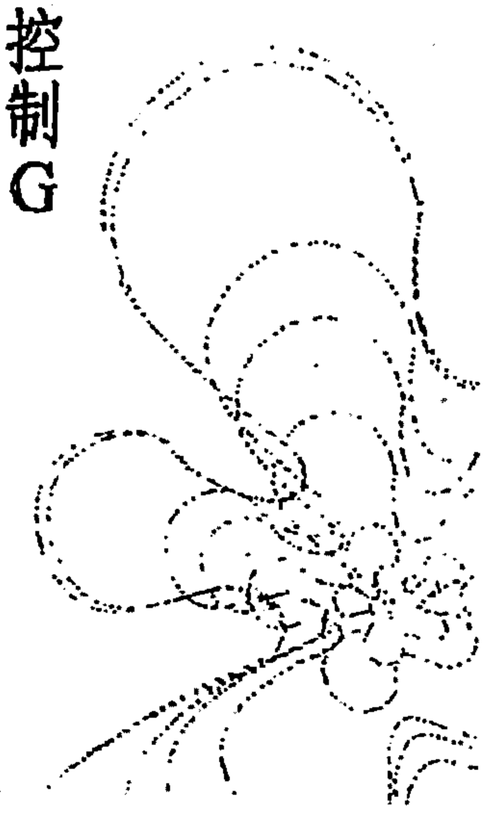
以困惑是因為急需排泄時的不適感，往往會伴隨著膀胱炎的症狀。抑或是因為沒有射精？

點難道會出現這些症狀？

有些女性亟欲射精，卻又忍住不射，可能因此成為膀胱炎的高危險群，類似的推論需要更進一步的研究證明，不過，這推論的可能性極高。類似女性哺餵母乳，當乳房充滿奶水，嬰兒無法吸食的時候，乳房腫脹可能會導致腺體感染。

有些女性會出現射精逆流的情形，亦即高潮時液體會射進膀胱，而不是由尿道流出。培瑞與惠普之所以有此假設，是因為女性在陰道刺激引起的高潮後，立刻有了尿意。但是當他們真的去上廁所，只流出少量乾淨或白色的液體，外觀看起來不像是尿液。

一名女性的脊椎神經在多年前受傷，她提出自己的經驗。



個女兒。一九六二年，為了解決膀胱宿疾，醫師為我施作迴腸造口手術，十歲時，我的脊椎長腫瘤，下半身癱瘓迄今，結婚十三年來，我有兩

亦即使用小腸的一部分為尿液改道，並未移除膀胱。原本應該沒問題，事實上並非如此。如今醫師決定移除膀胱，這讓我相當惶恐。我心想，如果醫師不知道液體來自何處，他們如何解決問題？如果女性是經由尿道流出類似精液的液體，我是否可以在射精時，膀胱同步發揮儲存液體的功能？

一名訓練人員提及自己生產前的經驗，而她知道許多女性也有同樣的經歷。預產期前不久，她流出大量液體，醫師告訴她是黏膜破裂，然而，醫師檢查時卻發現，黏膜完整無缺，類似的情形陸續又發生兩次。她的丈夫以顯微鏡檢視液體樣本，雖然沒有確定液體為何，但他說那並非尿液也不是羊膜水。也許是胎兒的位置或胎兒移動壓迫到G點，進而產生射精。

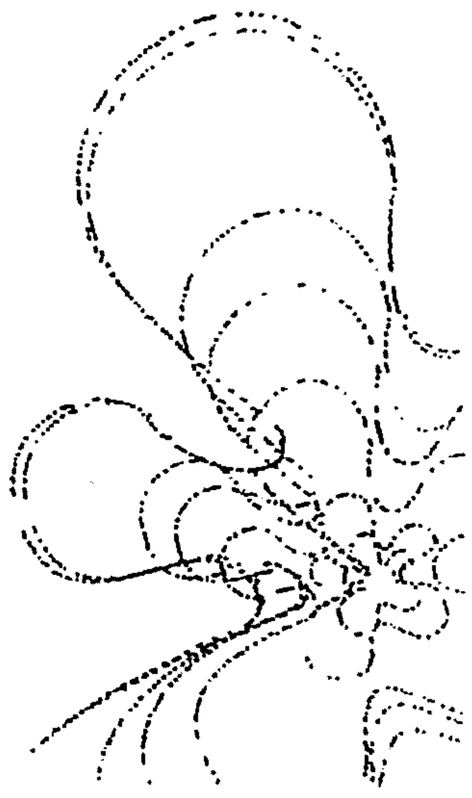
另一項值得研究的主題是，荷爾蒙與女性射精的關係。對更年期的婦女而言，G點通常會縮小，因此可由此瞭解荷爾蒙的作用。另外，我們沒有青春期前女性射精的相關報告，當然這並不值得意外，因為多數年輕女性鮮少討論性經驗。然而，如果女性和男性一樣，直到青春期才開始射精，或許荷爾蒙也確實對液體的產生有所影響。

一名接受荷爾蒙補充療法的女性寫道：

我今年六十歲，二十年前停經，這些年來始終服用高劑量的雌激素緩解更年期的熱潮紅。對我及丈夫而言，雌激素的濃度關係著液體流量。當雌激素可能引發癌症的說法出現後，我決定在冬天時暫停用藥，忍受熱潮紅，醫生無奈地同意。也因此，我仍然會出現熱潮紅，但幾乎流不出液體。我目前服用劑量最低的雌激素，服用三週，一週停藥，即使是停藥週的末期，仍有明顯差異。

一名六十七歲的喪偶婦女分享她的經驗，但希望採匿名方式，避免十二歲的孫女受到影響。

丈夫去世不久後，我開始服用雌激素，據說有助於改善焦躁型憂鬱症，結果似乎真的緩解我心中極度的焦慮、絕望及無力。或許雌激素可以促成液體的增加，雖然過去已有，但這幾年我更能感受到流量增加。



六十五歲時，子宮頸抹片的結果顯示我體內有少許癌細胞，切除子宮後，確定子宮內沒有任何癌細胞。性行為時，仍會噴出少許液體，雖然流量已經減少，但這也顯示切除卵巢及子宮後並未影響液體的流出。我的性趣盡失，但噴出液體的機制依然在運作。而這是不同於一般的潤滑功能，因為切除子宮後，我的陰道變乾，我希望一些前男友們能夠瞭解當時其中的差異。

對異性戀的女性而言，女性射精並非特殊經歷，而許多雙性戀或同性戀的女性也同樣在高潮時會流出液體。事實上，根據我們初步的報告，女同性戀射精的發生率高於異性戀者。或許這是因為手指較陰莖容易接觸到G點等敏感區域，亦或許女性較男性更能接受噴出液體的情形。

一一名來信的女性提及：

我是個偏向同性戀的雙性戀者，在和我的同性伴侶發生關係時，就曾於高潮射精，主要是發生於手部刺激時，這對我們兩人而言，都是一大驚喜。

有著不可思議的慰藉效果，陰道還會噴出大量液體，不論是外觀、氣味都和尿液有所區別。十七歲時，我第一次有如此感受，也非常好奇，後來是一名女同性戀者向我解釋其中的奧妙。

另一名女性則解釋：

我曾經歷兩種高潮，然而，由G點引發的高潮是很不同的經驗，因為

開口十分接近，甚至就在其中，這或許可以解釋為何這些女性認為液體是從陰道流出的案例，有些尿道開口與陰道

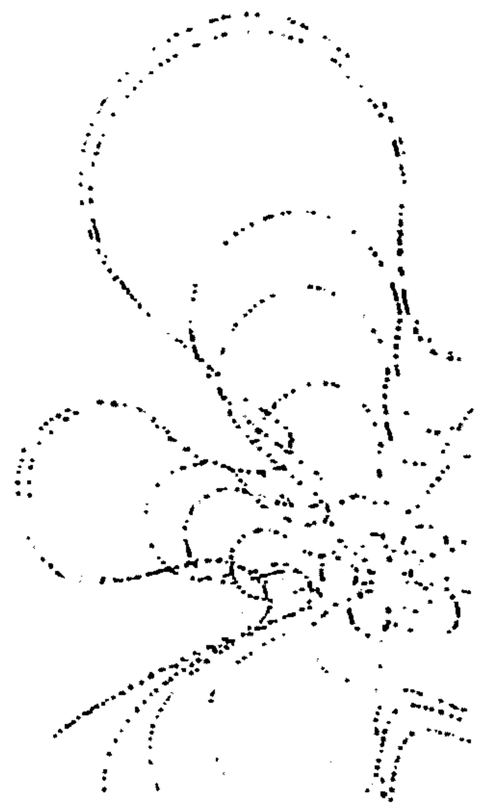
培瑞與惠普團隊檢視一些液體自陰道流出的

論味道或外觀都不像尿液。一些女性記得自己曾有春夢，不過其他人完全沒有記憶。還記得本章節一開始提到的麗莎吧。

有些女性和男性同樣擁有「鹹濕的夢」，在一片濕意中醒來，而液體不

如同對G點刺激的回應，女性射精一開始和恥骨骶骨肌有關，以下是一名於孕婦教室參與凱格爾運動的練習。

有兩個孩子的十九歲母親的心得，而她曾



學習這項運動之前，我的膀胱和腎臟都有點問題，從未在高潮時精，生產後，我開始練習凱格爾運動，藉此緊縮陰道肌肉，結果膀胱問不藥而癒，也開始在高潮時射精。我的丈夫為此興奮，這讓我感覺相當好。或許所有女性都能藉由凱格爾運動享受高潮射精時的愉悅，同時強周邊的肌肉。

雖然許多女性終其一生都不會有高潮射精的體驗，不過藉由運動骨盆底的肌肉，可以讓女性享受更加愉悅的性愛，而這也是下一個章節所要討的主題。



論 腔 化 美 題 射

第四章

# 骨盆肌肉健康的重要性

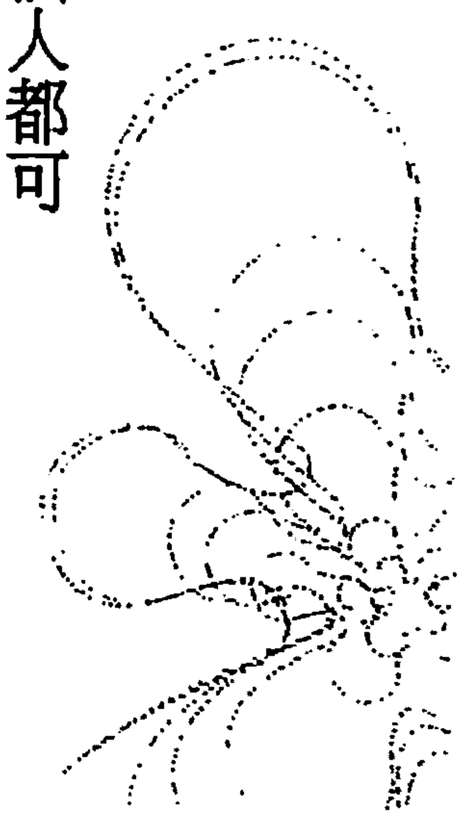
這塊肌肉的專門術語叫做恥骨骶骨肌，也有人稱之為「性愛肌」。

恥骨骶骨肌越健康，可有效刺激G點，女性和男性就越能享受激情愉悅的性關係。

從實用的觀點來看，肌肉狀態非常重要，透過教育或治療，每個人都可以活動自己的肌肉，對性反應可以產生正面的影響。本章就要教你如何自己動手做（有需要的話也可以尋求一些幫助）。我們假設每個女人都有G點，每個男人都有攝護腺。它們的功能有一部分要仰賴鄰近的肌肉。大多數男人會射出精液，而很多女人也會噴出愛液，射精時使用到的肌肉狀況也會直接影響這個過程。

全身的肌肉狀態對性功能有很多重要的影響。身體老是收縮繃緊的人能體會到的感覺受限，能表達的情緒也不多。肌肉不結實的人則受到不同的限制，他們的體會和表達內心感受的方式不一樣。腹部、臀部及大腿的肌肉對性經驗和表達來說尤其重要。如果這些部位的肌肉太緊繃，移動骨盆時一定會牽動雙腿和軀幹；如果肌肉軟趴趴的，骨盆可能根本動不了。但本章的重點不在討論一般的肌肉組織，而是一塊環繞和支撐性器官的特殊肌肉，與生殖器的健康和性愛的愉悅都有密切的關係。

這塊肌肉的專門術語叫做恥骨骶骨肌（pubococcygeus, PC group），骨盆腔底肌肉群包括好幾塊肌肉，但我們說「骨盆腔底肌肉」時通常就指所有的



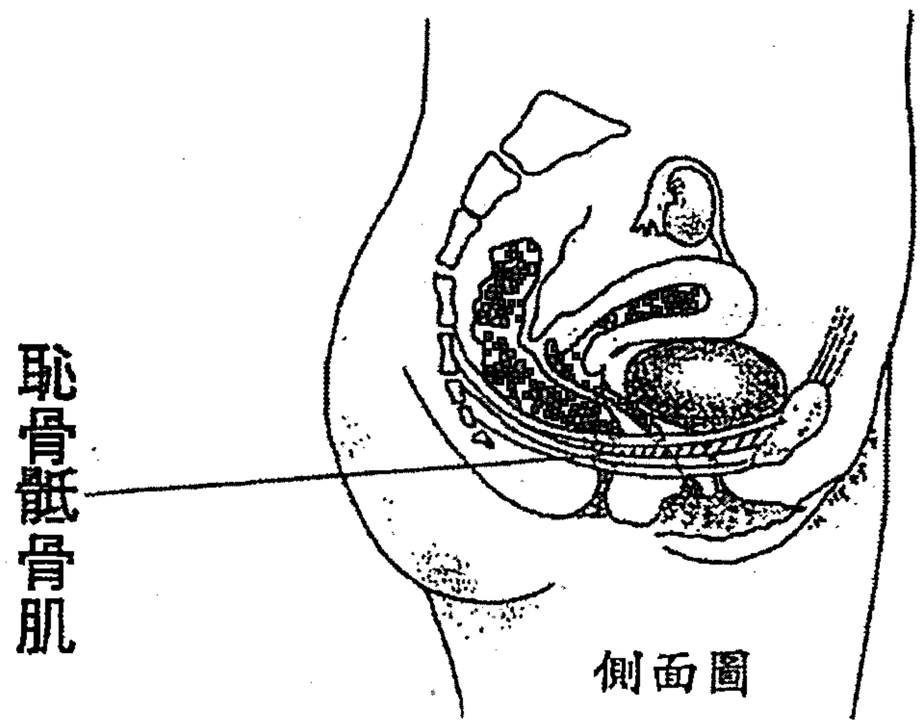
這些肌肉，因為它們幾乎總是一起移動。（審訂註：骨盆底肌肉一般指「提肛肌」，提肛肌之中有一條叫做「恥骨骶骨肌」，也有人稱之為「性愛肌」。）

恥骨骶骨肌從身體前方的恥骨延伸到尾骨（coccyx，脊椎末端的尾椎骨）。動物搖尾巴時就會用到這塊肌肉。人類的恥骨骶骨肌支撐肛門和旁邊的內部器官，有助於防止下垂。恥骨骶骨肌通常位於皮膚表面下兩、三公分的地方，薄的則超過五公分。這群肌肉大多受陰部神經（pudendal nerve）支配，當陰部神經偵測到陰蒂、陰唇、陰道口和肛門部位的刺激時，會傳送信號到大腦，再將信號從腦部傳送到恥骨骶骨肌，引發高潮時的肌肉規律收縮。

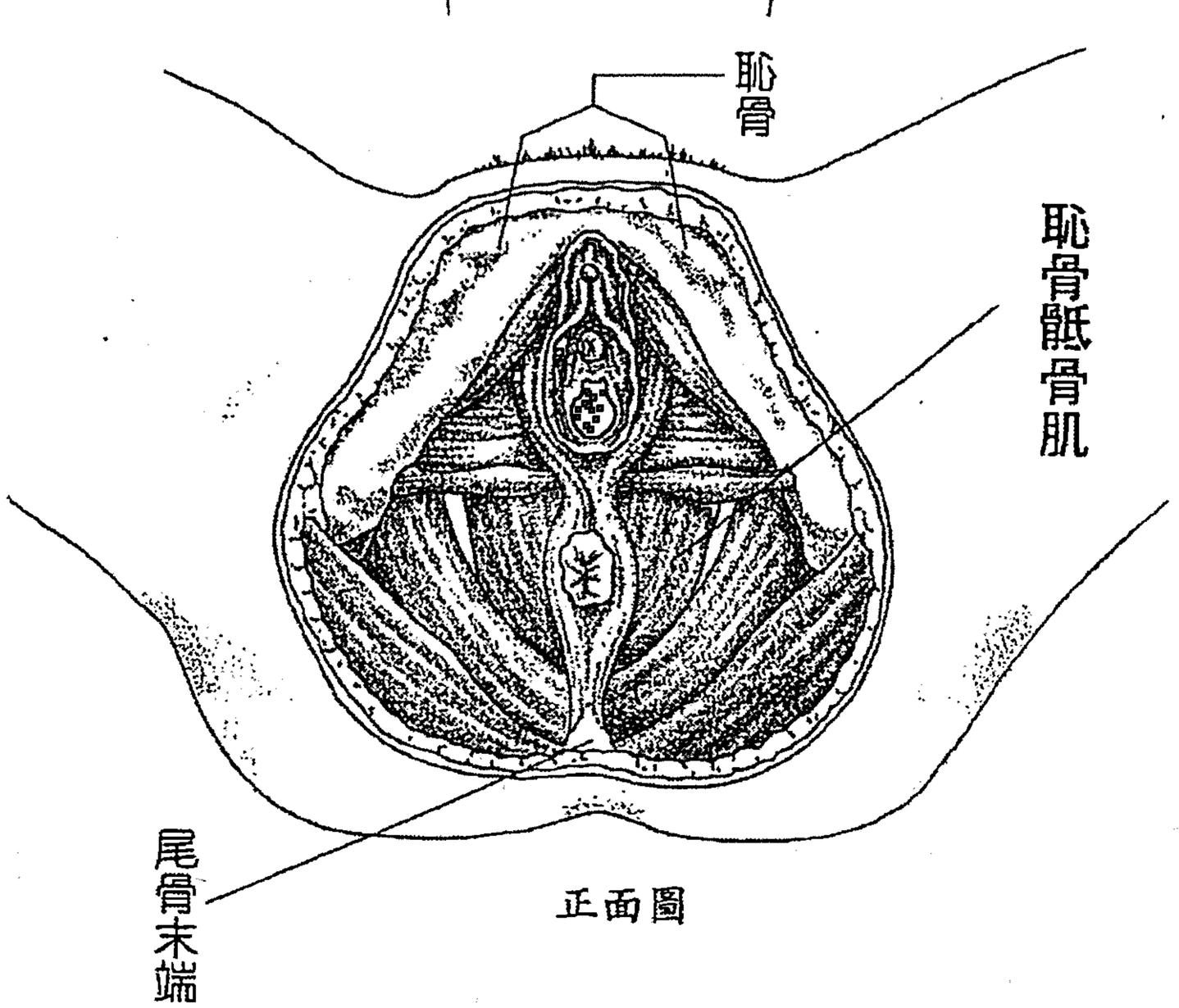
雖然很多專家相信對恥骨骶骨肌而言只有陰部神經比較重要，但恥骨骶骨肌的較深處，更靠近子宮的地方，也聽令於骨盆神經（pelvic nerve）。大家都同意，骨盆神經是人體最複雜的神經之一。骨盆神經的一支連接肛門、子宮（男性身上則是連接攝護腺）與下脊椎神經；另一分支則連接同樣的器官與下腹神經叢（solar plexus）後方的脊椎神經。

骨盆神經與陰部神經支配的區域大小，因人而異。而恥骨骶骨肌的雙重

圖四 恥骨骶骨肌




側面圖




正面圖



神經支配構造，或許可以解釋為何高潮反應是如此的變化多端，這些我們將在第五章討論。

男人也有恥骨骶骨肌，這些肌肉的狀態對男性高潮也有同等的重要性。一般而言，恥骨骶骨肌越健康，女性就越能享受性關係。還好，和人體其他部位的肌肉一樣，適當的運動和訓練可強化恥骨骶骨肌，只是很多人都不知道而已。

在我們的文化中，由於恥骨骶骨肌位於人體的私密區域，要評量恥骨骶骨肌的狀況不是一件簡單的事。在標準的骨盆檢查中，醫師通常會跳過恥骨骶骨肌。就算知道恥骨骶骨肌的重要性，醫師也不太願意要求病人在檢查時收縮恥骨骶骨肌，因為這種刻意的肌肉動作也可能導致性興奮。美國的醫師尚未接受性學訓練。事實上，在過去幾年內，只有幾家醫學院在課程中納入有關性的素材。

某些異國文化則有系統的訓練女性使用恥骨骶骨肌。以觀眾和舞者都能享受樂趣的中東舞蹈為例，教導舞者練習單獨使用許多通常會一起動的肌肉。肚皮舞者主要接受的訓練就是學會如何單獨使用骨盆內外的肌肉，移動

特定的肌肉時，不牽動其他肌肉和身體的其他部位，甚至要學會如何在移動一組腹部肌肉時不會動到其他的肌肉。除非能單獨移動恥骨骶骨肌，否則舞者難以控制肚皮，這種練習也是為未來的性行為和生育做準備。

一九四〇年代早期，前衛的婦科醫師凱格爾（Arnold Kegel）領先群倫，率先讓恥骨骶骨肌成為聚光燈的焦點。當病人因「應力性尿失禁」前來求診時，他並不幫她們動手術，而是教她們如何透過運動來強化恥骨骶骨肌。因此，大多數的患者不需要動手術，很多人也因此體驗到生命中第一次的性高潮。

此外，凱格爾還發明了一種陰道壓力計（perineometer），用來測量患者的恥骨骶骨肌，以便給她們更好的訓練，這可能是世界上第一個有特定功能的生物回饋裝置（biofeed back device）。這個裝置包含一個中空的小塑膠圓錐，底部有一塊阻隔物，好將此裝置塞入陰道中被恥骨骶骨肌圍繞的區域。圓錐上連著一根管子，通往一個簡單的氣壓計。只要看著氣壓計上的指針，患者可以觀察自己的恥骨骶骨肌收縮強度，經由練習，改善肌肉狀態。

無論從哪一個方面來看，凱格爾的發明極為簡單。不論這個裝置有什麼治療上的優點，光是它的簡明就可能違反了二十世紀的科技趨勢。引發短暫



的流行熱潮後，凱格爾簡單機械裝置（價格為三十九點九五美元）慢慢為人遺忘，有些醫師則用藥治療病患的應力性尿失禁。

雖然凱格爾的陰道壓力計可說是朝正確方向邁出了一大步，但其主要的缺點是無法提供「絕對的」恥骨骶骨肌壓力值，因為陰道相對的大小和形狀都會影響精確度，例如，窄的陰道的讀數會超過鬆的陰道。第二個缺點則是凱格爾壓力錶上的指針只要恥骨骶骨肌稍微縮緊和放鬆，就會不停跳動，醫師只好「約略估計」平均的讀數。此外，因為形狀和設計的關係，使用時必須用一隻手固定，讀數因此更不精確。

凱格爾之後，科學家對生物回饋的興趣大增，現在市面上有很多種裝置，讀數也相當可靠。一九七六年，培瑞發明了「陰道肌動描記器」（vaginal myographic, EMG）回饋裝置使用。

（electromyographic, EMG）回饋裝置使用。

陰道肌動描記器用平滑的塑料製造，外形像個小啞鈴，可以像衛生棉條一樣的塞入陰道。定位後，不需要用手扶著。肌動描記器上的銀質條狀感應

器分布經過設計，能夠接觸到恥骨骶骨肌的區域。陰道肌動描記器使用標準的肌電圖機器，可以給出肌肉收縮和休止狀態的精確讀數。和凱格爾的陰道壓力計不一樣，女性不需脫下衣物，就可以自行塞入陰道肌動描記器（請參見培瑞醫師的網站www.DrGSopt.net，可找到更多關於此裝置和其他輔助品的資訊）。

但我們的討論已經離題了。在詳細討論如何用生物回饋設備檢查和運動恥骨骶骨肌之前，我們得先思考為什麼需要評估和運動恥骨骶骨肌、到底出了什麼問題，以及女性和男性要如何才能找到自己的恥骨骶骨肌，並在有需要的情況下學習自發控制恥骨骶骨肌。

最常見的問題就是恥骨骶骨肌軟弱無力，通常也有萎縮的情況。在一九四〇年代，凱格爾拍了一些年輕少女的照片，她們的骨盆區域已經明顯的發生鬆弛。這種提早老化的情況原因不明，這個問題雖然很重要，但本書不會討論問題的成因。

一般女性到年老時，才會出現骨盆肌肉無力和萎縮，也導致各種不同的生理問題，包括子宮脫垂、膀胱脫垂和直腸脫垂，分別是指子宮、膀胱或直



腸因為肌肉鬆弛而掉入陰道區域。估計有至少百分之八十的應力性尿失禁是因為恥骨骶骨肌無力的緣故，這就是凱格爾的運動治療會成功的原因。最近的研究也證明了凱格爾的信念，無法在性愛時達到高潮，無力的恥骨骶骨肌也要負一部分的責任。

很多人假設分娩時的創傷導致恥骨骶骨肌無力。但凱格爾和其他人發現，肌肉無力通常才會在分娩時產生問題，現在有很多專家會囑咐孕婦做產前運動強化恥骨骶骨肌。然而，還是有數百萬的年輕母親沒接受生產的訓練或準備就進入產房了，軟弱無力的恥骨骶骨肌常造成難產。

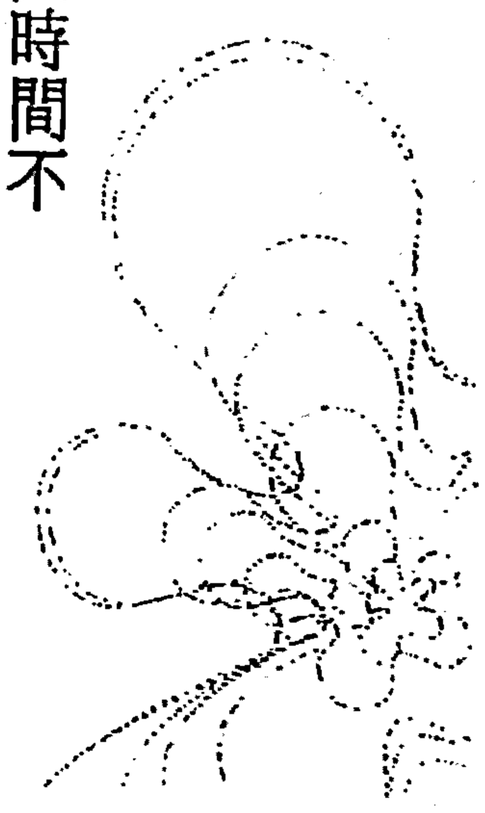
恥骨骶骨肌無力通常也是造成陰道麻木（沒有感覺）的原因。沒有運動、不夠結實的肌肉，反應力也很差；健康的肌肉對生理刺激會比較敏感。有時候女性抱怨做愛時沒有快感，其實並不是心理問題，而是生理狀況不佳。心理因素造成的。

的關係，不過心理和生理的問題很難明確區分，而且肌肉不結實也有可能是

你的手臂斷了打上石膏，在除下石膏後，要花費時間精力做運動，才能讓肌

大家都知道，如果肌肉沒有適當的訓練，就會鬆弛萎縮。比方說，如果

肉恢復之前的大小和力道。但人們還是會想像，性愛用的肌肉就算長時間不使用，只要真命天子出現，這些肌肉馬上就能奇蹟式恢復原本的功能。很可惜的是，恥骨骶骨肌需要一段時間的才能從荒廢的狀態中復原。



露絲是一名快三十歲的護理助產士，她的性愛關係一向不錯，她也會訓練產婦練習凱格爾運動。在一次會議時，露絲第一次聽到陰道肌動描記器這種儀器，她很希望有機會使用，她一直很好奇自己的恥骨骶骨肌到底是什麼狀態。

露絲自認為可以達到多次高潮，但儀器顯示她的讀數只有九微伏特（microvolt），和其他女性比起來算很低。從露絲的性經驗來看，我們會預期她的讀數應該高達十八。詢問露絲時，她透露，前一年她都沒有性生活，現在她有一位計畫要結婚的男朋友，但她與他做愛時從未得到高潮。露絲把她的性冷感歸因於「溝通不良」，她對於解決這些問題已經喪失信心了。

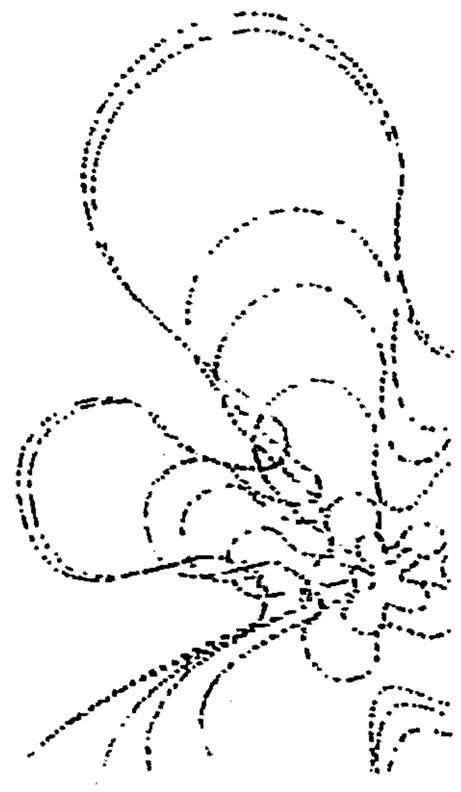
和很多反應力強的女性一樣，露絲在年輕時代靠自慰讓恥骨骶骨肌保持良好的狀態，在二十出頭時，則靠著頻繁的性行為。但在沒有性生活的

那一年，她從沒想到自己需要做凱格爾運動，因為她認為凱格爾運動只是為了生產而做的準備。露絲參加了為時二十分鐘的速成班，利用生物回饋儀器做做凱格爾運動，幾星期後，她寫信告訴我們，強化恥骨骶骨肌後，也成功解決了「溝通不良」的問題。

凱格爾運動包含恥骨骶骨肌的持久與短暫收縮，與時間相同的放鬆交替進行。在介紹凱格爾運動前，先來看看哪些問題和恥骨骶骨肌的狀況有關。

另一個同樣常見的問題比較少人知道，就是骨盆緊張。恥骨骶骨肌緊繃時就像其他肌肉發生緊繃的狀態一樣，可能是在特定時間而發作，也可能是慢性的問題。最常見的情境緊張型態是陰道痙攣，恥骨骶骨肌在陰莖（即使是很信任的伴侶）靠近時向下鉗緊，導致陰莖進入時感到疼痛或甚至根本無法插入。雖然陰道痙攣本質上可能是情緒的影響，但標準的治療方法通常從生理著手。用越來越大的擴張器，強迫陰道容納越來越大的插入物，協助女性察覺陰道口是可以擴張的。但是我們相信，生物回饋的方法比較溫和，也比較有效。

孕可能會奪走她的生命。米雪兒的病史讓她無法服用避孕藥或使用子宮環，不幸的是她的丈夫痛恨使用子宮帽、保險套和陰道殺精劑。顯而易見的，她的陰道痙攣絕對有心理的因素——陰莖插入可能會致死。討論過幾次後，米雪兒同意裝入子宮頸帽，避孕的問題解決了，但陰道痙攣還沒解決。因此治療師建議使用生物回饋訓練。熟悉裝置的使用方法後，米雪兒可以自己輕鬆插入陰道肌動描記器。肌肉放鬆的訓練進行還不到一個小時，她就可以完全控制造成問題的恥骨骶骨肌。一星期後，米雪兒說她已經沒有陰道痙攣的問題了。



米雪兒的問題出現在夫妻的性行為上，但很多其他問題可能都和慢性骨盆緊張有關。大多數人都知道肌肉長時間保持緊繃後，就會開始疼痛。要動到會痛的肌肉才有感覺，因此人們對疼痛的察覺度逐漸消失，直到緊張程度增加或減少時，人們才會開始嘗試移動肌肉。有些臨床醫師相信，病人說的

「下背部疼痛」其實通常是恥骨骶骨肌緊張。說自己的背部疼痛，可能比承認陰道緊張來的好說出口。感覺不夠敏銳的話，會無法感知到正確的情況。我們治療過一些病人，開始時都抱怨下背部疼痛，後來學會放鬆恥骨骶骨肌後，情況就紓解了。

慢性恥骨骶骨肌緊張也可能會偽裝成其他身體部位的疼痛：

四十歲的心理治療師瑪麗幾年來都為「輕微」結腸潰瘍所苦。醫師說的「輕微」，意思是他找不到潰瘍的部位當作證明，但對於瑪麗的腹部痙攣，這是他做出的最佳解釋。當瑪麗終於有機會嘗試生物回饋治療法後，她說她沒辦法找到適當的性發洩管道，但她在工作的時候常會覺得性慾高漲。

她從不自慰，可是自慰也是緩和這種緊張的一個方法。最後她決定嘗試自慰，而不願忍耐討厭的性伴侶或繼續忍受慢性緊張，她告訴我們那「輕微潰瘍的結腸」已經永遠消失了。

無損於以上的結論。

當然，這也可能是壓力造成的腸躁症（irritable bowel syndrome），慢性骨盆緊張可能是某些病情的成因或助力。培瑞早期做的初步研究暗示，多半都常發生陰道或尿道感染，例如膀胱炎（cystitis）和念珠菌陰道炎（monilia）。做過測試的女性，如果恥骨骶骨肌緊張的程度很高，



但並深愛自己的丈夫，她的丈夫也非常喜歡性愛。他覺得性愛是每天早晚的最佳儀式。在婚後的第一年，凡事都完美極了，只有一個問題是法蘭欣的膀胱炎不斷發作。十個月內看了八次醫師，唯一的解釋是新婚夫妻有時候一向性致勃勃」。她對宗教也非常虔誠，法蘭欣喜歡做愛，說自己「

「性行為過於頻繁」，造成所謂的「蜜月膀胱炎」。法蘭欣不認為一天兩次算是過量，她只能繼續每個月服用抗生素。

次陰道肌動描記器的例行檢查，顯示法蘭欣的恥骨骶骨肌非常發達。事實上，她的收縮力道可名列前百分之十。但結果也顯示法蘭欣無法放鬆她的恥骨骶骨肌。法蘭欣的一般女「放鬆」程度實際上高過受測試的

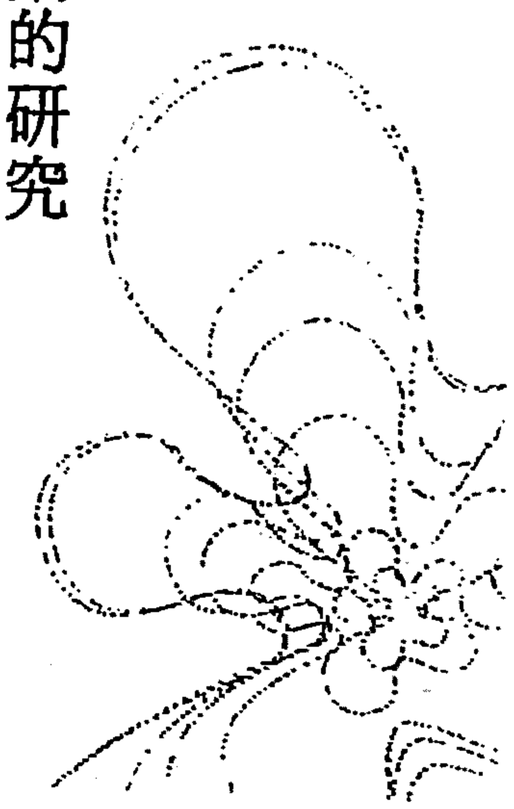
性的「最大收縮」程度。從她個人的經驗中很快就可以看出慢性骨盆緊張的成因。法蘭欣的父親疑心病很重，在家中非常有威嚴，他認為「所有的公共廁所都充滿細菌」，從上幼稚園開始，法蘭欣就被教導，不管她多麼尿急，都要忍到回家才可以上廁所。因此她學會了縮緊自己的骨盆肌肉，而且可以持續好幾個小時，一般人若是忍了這麼久，早就尿濕褲子了。

慢性骨盆緊張是否會造成陰道和尿道感染尚無定論；但很明顯的是經常拉緊的肌肉會造成血液和淋巴循環不佳（握緊拳頭，血液被擠出指節組織以外後，指節就會變白。常常緊繃的恥骨骶骨肌也是這種情形）。當循環不良時，白血球就難以發揮搜尋和毀滅細菌的作用。更常見的是，醫師常常直接開給病人抗生素，而不考慮功能性的成因和治療方法——例如學習放鬆緊張的肌肉，好讓身體能夠自行預防疾病或痊癒。許多女性因為感染一再發作，而被冠上「濫交」的罪名，我們也無法估計到底有多少受害者，陰道中的某些微生物並不會造成感染。應該說是陰道和尿道的生理情況決定哪些微生物可以繁殖。

中，未經診斷的慢性骨盆緊張也會導致更嚴重的問題。在我們早期的研究
伏特，另一位實驗對象記錄下來的骨盆緊張程度非常高，高達三十五到四十微
自己的情況，但她要到遠方的城市開始新工作，無法接受治療。幾個月後培
瑞聽說她得了子宮頸癌，他假設這種慢性的循環不良，特別是子宮頸內和四
周，可能讓這名受試者更容易得病。（審訂註：子宮頸癌的致病元兇是簡稱
為HPV的人類乳突病毒，通常因性行為而被傳染HPV，過了多年之後才會產
生子宮頸癌。）

除了軟弱或過度緊張，恥骨骶骨肌還有另一種特有的情況：難以控制。
就像之前說到的，我們常碰到的病患多半完全不知道自己有能力收縮或放鬆
這塊肌肉。很多人甚至不知道恥骨骶骨肌在哪裡。我們觀察過恥骨骶骨肌的
劇烈肌肉收縮，強度可以匹敵腿部肌肉發生的抽筋或痙攣，而病患似乎完全
沒發現自己的陰道內外正在進行如此激烈的肌肉動作。月經期間的痙攣可能
就和這種緊張有關。

身體大多數部位的肌肉，若無預警的收縮或以上面說的方式交互收縮和



放鬆，都會引起注意，我們也會很快就醫治療。如果痙攣的地方是恥骨骶骨肌，為什麼要完全忽略呢？很多人，尤其是女性，已被訓練成不要注意骨盆區域內的感覺。在忽略性衝動的過程中，很多人學會漠視這些信號，不想去控制自己的恥骨骶骨肌。

人們避免注意到骨盆感覺的一個方法就是長期繃緊這些肌肉。一位生物能量分析師在評論自己帶領的療程時說到：

大多數女性由於骨盆區域非常緊繃，無法移動自己的骨盆時，她們會察覺到移動時的痛楚，而且因為移動骨盆而深感罪惡。她們會提到有關身體和性行為的教導。除了教她們移動骨盆外，我還教她們如何把自己的肚子挺出來。我會讓她們用平常的姿勢站著，就像別人教的一樣，然後用相反的方式站立，讓她們感覺到差異，察覺到自己有多麼僵硬，而且用了多少力氣憋住下腹部。最後有人開始說，她們的性生活更美滿了、性高潮次數增加了，以及覺得更輕鬆了，尤其是在男女相對的情境中。

樣，能夠收縮和放鬆腹部肌肉當然有很好的理由，因為就像恥骨骶骨肌一骨肌的活動。當衛生棉條越來越受歡迎，使用棉條可能也在無意間造成女性忽略恥骨骶到自己寧可忽視的感覺。這個情況越普通，女性對陰道地帶的其他感覺就會更加遲鈍。

三十歲的琳達因為抱怨自己的生殖器完全沒有任何的感覺，被引介過來治療。

有時候，甚至能從個人病史看出這種刻意培養的漠視還有更極端的。

手術，切掉子宮頸上的小瘤。當麻醉的作用過去，琳達醒來才有人告知她的子宮已被完全切除。她說她沒有得到任何諮詢（醫師只有建議她等到疼痛過去後，至少要兩個星期不能行房）。在後續的討論中，她才發現，醫師根本無法預知她在莫名其妙失去子宮的情況下所感受到的沉重心理打擊



和生理疼痛。她學會了用忽視來面對這種「痛」。後來她發現自己完全無法體驗性愛的感覺時，她假設醫師在切除子宮時也不小心切掉了她的「性愛神經」。醫師說這都是憑空想像，勸她接受心理治療。而心理治療師對她與父親的關係比她本人更有興趣，所以她只好停止心理治療。六年來，琳達就活在「性冷感」的污名下。

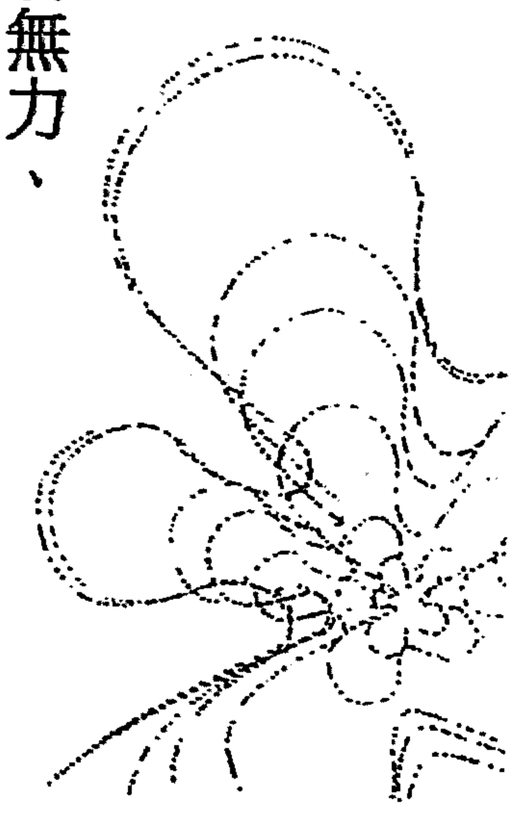
陰道肌動描記器的評估顯示琳達的恥骨骶骨肌會斷續的收縮和放鬆，但她本人毫無知覺。十秒鐘收縮強度的例行測試顯示變化很大，最高可達二十五微伏特，最低只有五微伏特。

糾正的治療相對來說很簡單。琳達觀察自己恥骨骶骨肌的生物回饋，讓她相信自己的性愛神經事實上完好無缺。然後我們教她做凱格爾運動，鼓勵她利用生物回饋儀器做約一個小時的練習。刻意養成的漠視得到解釋後，我們要求她讓她的另一半也每天陪她做恥骨骶骨肌的運動。一星期後再度看診時，琳達的肌肉控制已經達到正常的標準，她也承諾會繼續在家練習。當她體認到問題並不是自己的憑空想像時，忍不住喜極而泣。

這些只是恥骨骶骨肌會發生的一些問題：可能會萎縮、變得軟弱無力、太緊張或無法控制。當然恥骨骶骨肌也有可能狀況良好。如果你沒有以上描述的問題，也還沒到需要考慮是否以恥骨骶骨肌運動作為替代賀爾蒙療法來改善陰道濕潤度的年齡，你還是可以為了加強性愛的享受來學習恥骨骶骨肌運動。

女性學研究剛萌芽的時候，有一個假設是血管（血流）活動是性反應的「主要」原因機制。但陰道肌動描記器及對男性受試者使用較小型直腸肌動描記器的研究指出，在男性勃起或女性分泌愛液之前，恥骨骶骨肌已經非常活躍。說到精確感知體內肌肉活動時，女性跟男性差不多——男女兩性都會忽略恥骨骶骨肌的細微「抽動」，而這才是構成初步性反應階段的要素。

當女性收縮恥骨骶骨肌時，在每次收縮後血流會湧進陰道組織，讓陰道組織的顏色變暗，同時增加滑潤度。性治療師通常會建議陰道潤滑緩慢的女性想辦法推延伴侶的求愛，直到自己「真的準備好」為止。鑑於目前的知識範疇，建議女性訓練自己的恥骨骶骨肌，進而加快潤滑的過程，這種積極的策略才有幫助。對年長的女性來說又特別有用，因為她們可能有陰道內壁乾



涸的問題。解決這個問題的一個方法是使用雌激素乳膏，但運動恥骨骶骨肌也能達到同樣的目標。

多年來，醫師都忽略了一點——每個人都應該為自己的恥骨骶骨肌負責。醫師有三個治療的方法：外科手術、化學治療和電療，第一種顯然是最普遍的。恥骨骶骨肌和周圍的區域可做的外科手術多達將近五十種，目的在於控制應力性尿失禁。

在二十世紀中期，約為一九三〇到七〇年間，大多數的外科治療法都相當粗糙。基本上，切開恥骨骶骨肌後用浸漬的方法，期望這裡形成一塊傷疤組織，讓尿道變得更緊窄。但一段時間之後，恥骨骶骨肌又變得鬆弛，於是再切開一次，希望另一塊組織能夠成型。少數幾位婦科醫師依然堅持手術前，應先試試運動有沒有效。沒有人正式研究此類手術對性反應的影響，所以這種方法可能會造成的有害副作用還算是個未知數。

近年來，外科手術愈發精密。尿道的長度、角度、尺寸和形狀都先用X光及超音波仔細觀察過，但基本的方法還是一樣：重組尿道或肌肉組織，幾乎不考慮到患者也有自救的能力。

有些外科醫師急欲動刀的心態為許多醫師所詬病，很多醫師都推薦先採用化學療法，使用藥物來阻絕可能造成漏尿的肌肉活動。但還是沒人嘗試解決漏尿最基本的肌肉無力問題。

在第二次世界大戰後，醫界引進了電療法，從那時候開始到現在，電療就一直起伏於流行與不流行之間。用類似一九五〇年代很流行的瘦身儀器上的電極，誘導肌肉動作。有些研究人員會用高伏特的電力短暫電擊受試者，也有人嘗試用微小的電流找出骨盆區域的自然頻率，類似心臟節律器的作用。但這兩種方法都只能讓女性患者被動的接受治療，無法完全治好失禁。

後來，有許多將電極直接塞入陰道的便宜裝置申請了專利。這些使用電池做為動力，在家使用應該也很安全。我們花一點時間做了實驗，將這些裝置結合生物回饋（非電擊）治療，但女性受試者覺得這些裝置很噁心（有幾個人直截了當的拒絕使用），我們只能將它們用在少數幾個案例中。

幾份已出版的研究宣稱他們證明了這些電刺激裝置的效用，但其中都有嚴重的方法論缺陷。在我們看過的研究報告裡，電療法都結合了凱格爾運



動，無法確認是電刺激加上運動還是運動本身造成的益處。由於沒有提出證據來證明電刺激有助於運動，我們認為運動本身比較像是改善的原因。凱格爾運動也不需要花費，而且更安全，做起來也更令人開心。

如果想要更了解你的恥骨骶骨肌，首先要考慮個人的經歷。在骨盆承受壓力時，是否會不小心漏尿？例如大笑、打球、跑步、跳躍。如果答案是肯定的，你的恥骨骶骨肌可能有點無力或萎縮。你是否覺得自己很難達到性高潮？這可能也是肌肉無力的另一個徵兆。

如果你常感覺下背部疼痛、經常陰道或尿道感染、陰道插入外物時覺得疼痛或陰道毫無敏感度，則可能有慢性骨盆緊張的問題。如果生理期時子宮會嚴重痙攣，或性反應變化無常，很可能是肌肉控制的問題。

伴侶對你的感覺也能提供有用的資訊。如果伴侶能夠感覺到你在性行為時刻意收縮恥骨骶骨肌，你應該沒有肌肉控制的問題。如果伴侶覺得你的陰道很緊，你應該沒有恥骨骶骨肌無力的問題。如果伴侶用言語或手勢表達他感覺不到什麼，那麼你就該懷疑自己的恥骨骶骨肌很無力了。

麗蓓佳和丈夫到診所求診，因為丈夫抱怨她的陰道變得非常鬆弛，他甚至感覺不到自己的陰莖已經滑出來了。就算他言過其實，麗蓓佳真的有點問題。經過兩個星期的生物回饋訓練，麗蓓佳的丈夫覺得她「從門戶大開變成一個小鑰匙孔！」剛開始時治療師假定「有些男人就是愛挑剔」的恥骨骶骨肌動描記器測量過麗蓓佳的恥骨骶骨肌後，很顯然的，麗蓓佳需要一些課程，教導她如何收縮和放鬆恥骨骶骨肌。麗蓓佳只學會收縮自己的恥骨骶骨肌，下一步則是要學習控制和放鬆。

考慮過個人的經歷後，下一步是找到你的恥骨骶骨肌在哪裡。你可以獨自進行或找伴侶幫忙。我們建議讀者先用一面小鏡子觀察自己。有些女性覺得觀察自己的生殖器沒什麼大礙。但許多女性覺得撫摸自己的生殖器還可以，觀察這個部位則是一件讓人害羞的事情（男人就很習慣看到自己的生殖器，所以比較不可能有相同的感受）。如果你不願意觀察自己的生殖器，或這個念頭讓你心生恐懼，想想看，這也是你身體的一部位，屬於自然或上帝的創造，不應該讓你覺得可恥。當然，說比做簡單，多年以來的訓練讓一些

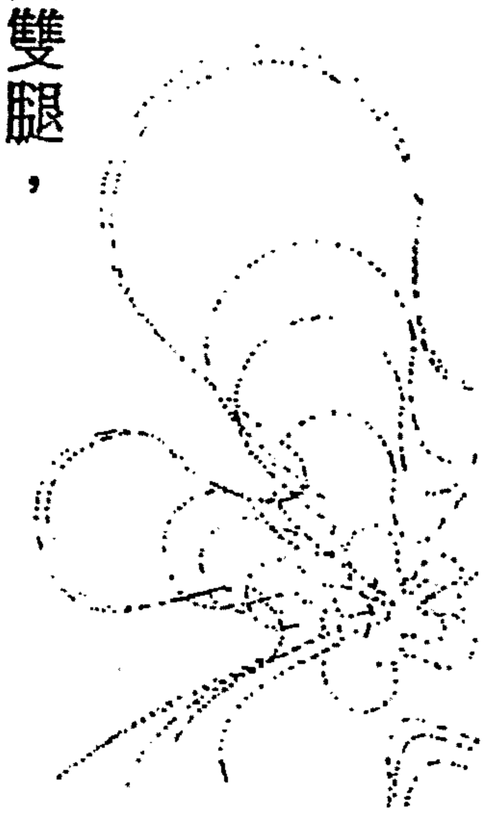
女性（和男性）深深覺得生殖器是羞辱的同義詞。

如果要更了解你的恥骨骶骨肌，躺下來，用鏡子觀察生殖器。如果這是你第一次觀察自己的生殖器，先用幾分鐘的時間辨別不同的部位——陰道、陰蒂、陰唇、尿道和肛門（見第108頁的圖三）。

等到觀察生殖器不會讓你心生恐懼或害羞，而且你也更熟悉該處的景象時，開始輪流拉緊（好像要停住尿流的感覺）及放鬆（類似要排便的感覺）。一直看著鏡子。如果你能順利控制肌肉，而且肌肉也相當有力的話，應該可以看到會陰隨著你的控制而前後移動。觀察這個區域時，注意你的腹部、臀部和大腿肌肉是否跟著移動。如果會的話，表示你還沒學會單獨使用肌肉。

為了訓練恥骨骶骨肌而做的練習並不等同於為了增加性快感而做的運動。一般來說，如果要增加性快感，能用到的肌肉越多越好。因此性生活活躍的女性可能在一開始時也無法順利單獨使用自己的恥骨骶骨肌。但為了利用練習增強恥骨骶骨肌的功能，你必須先學會如何在不移動其他肌肉的情況下運動恥骨骶骨肌。若能成功單獨移動恥骨骶骨肌，練習的成果會更好，你也不會因為練習而感到疲累。

下一步也需要用到鏡子。很多女性能夠轉動自己的骨盆和張開雙腿，讓陰道口稍微開展。如果你也可以的話，在良好的光線下，就能觀察陰道口隨著恥骨骶骨肌收縮和放鬆而開合。這也可以幫助你觀察自己的控制能力和肌肉強度。如果你不能放鬆讓陰道口開展，或許就有慢性骨盆緊張的毛病。



評估恥骨骶骨肌的第三個步驟是用手指探索陰道內部。將一根手指插入陰道（男性則應插入直腸）後，辨別恥骨骶骨肌就很容易。初次將手指放入陰道時，就像對著鏡子做的一樣，先收縮再放鬆恥骨骶骨肌，找到恥骨骶骨肌的位置。陰道壁的表面並沒有劇烈起伏，但將手指伸進去一兩寸時應該可以感覺到恥骨骶骨肌就在陰道壁下面。稍微彎曲手指，向內每伸進去半寸按一下陰道壁，直線朝著子宮頸（子宮的開口）的方向前進。每伸進去半寸，就拉緊一下恥骨骶骨肌，注意你的手指是否能感受到動作。

根據凱格爾的說法，健康的恥骨骶骨肌應該有三指厚，而無力的肌肉可能「就像鉛筆一樣又窄又細」。如果研究過陰道壁每隔半寸的地方，你應該可以在一兩個或甚至三個停頓的地方感覺到恥骨骶骨肌的存在。按壓恥骨骶

骨肌前方和按過整塊肌肉，並朝著背部的方向向後按壓後，應該可以找出恥骨骶骨肌的位置。如果碰觸陰道讓你覺得不舒服，剛開始時可以用電刺激器幫助你找到恥骨骶骨肌在哪裡。經過練習後，你會變得更有自信，能夠克服觸摸陰道的反感。

用過一根手指後，再嘗試「兩根手指的測試」。將兩根手指併攏插入陰道，進入到你覺得還可以的最深處。然後張開手指，就像做出剪刀的手勢一樣。接著收縮恥骨骶骨肌，試著將手指推攏。如果可以的話，你的恥骨骶骨肌沒事。如果很難的話，繼續讀下去，你需要更多的練習。

如果你做練習時有伴侶從旁協助，你可以要求伴侶先用一隻手指檢查你的陰道，然後再用兩隻手指。除了注意到肌肉的強弱外，也要注意你的陰道是否有某些部位的反應會比其他部位更強烈。

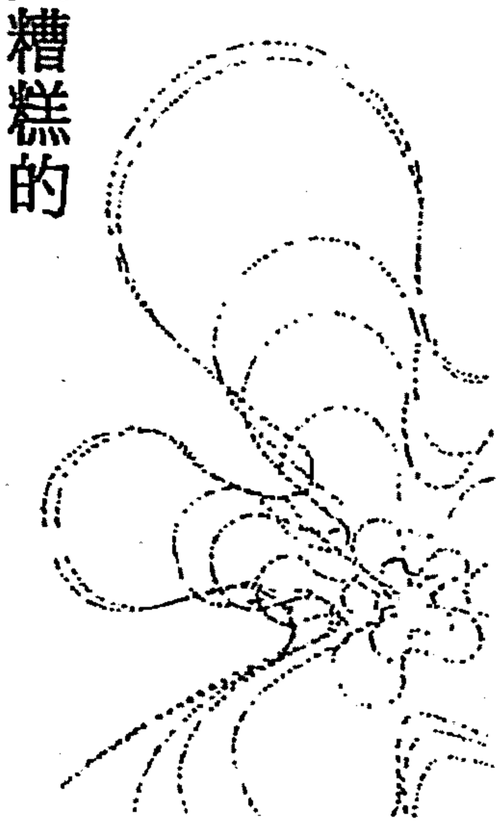
手指檢查法不應該用來比較兩人的恥骨骶骨肌，因為陰道尺寸的生理差異及體脂肪等因素，對個人的主觀印象都有很大的影響。另外也要記住，陰道的大小和恥骨骶骨肌的強度沒有絕對的關係。某人可能陰道很寬，而且肌力很強，另一人的陰道小而窄，但是肌肉無力。

是）有些女性要在性行為時才會收縮骨盆肌肉，在其他場合或（更糟糕的究骨診所內，就完全無法移動骨盆肌肉。幾年前，我們用陰道肌動描記器研得坐在躺椅上，有些人則在女性的健康診所接受測試，她們婦科檢查檯上。其中一名女性在兩個地方都接受了測試，躺在檢查檯上時，她的讀數比較弱，所以我們也回頭檢查資料。沒錯，根據檢查的場所，肌肉強度也有顯著的差異。

另一個辨別恥骨骶骨肌的好方法則是在排尿的過程中停住尿流。如果你的肌肉有力，控制程度也不錯，就可以精準的開始和停止排尿。如果第一次就做不到，別失望。學習收縮（或放鬆）正確的肌肉也是其中一項練習。

在說明該做什麼練習前，我們花了很多的篇幅討論找出恥骨骶骨肌位置的重要性，這有一個非常重要的原因。很多女性聽到凱格爾運動後，花了幾個月或甚至幾年的時間練習，但是卻用錯了肌肉，結果一事無成。

貝慈是一位四十多歲的護士，她認為自己做的是凱格爾運動，而且已



經努力不懈的練習了十多年。她堅信自己的膀胱出了問題，即使她這麼認真的練習，應力性尿失禁的情況還是越來越糟。最後她找了一位生物回饋專家看診。陰道肌動描記器最初的讀數顯示貝慈的骨盆肌非常軟弱。評估過她做凱格爾運動的方法後，專家發現，貝慈主要用的是臀部和腹部的肌肉，而不是恥骨骶骨肌。生物回饋練習幫助貝慈的肌肉強度持續改善，讓她的失禁痊癒。對貝慈來說更重要的是，規律運動幾個月後，只要接受陰道刺激就可以得到性高潮，這是她之前夢寐以求但從未達成的心願。

貝慈的故事相當重要，告訴我們就算是研究過生理構造的醫療專業人員也可能運動到錯誤的肌肉而不自知，對身體的自覺度就和其他人一樣的貧乏。

透過手指測試或停止尿流訓練找到恥骨骶骨肌的正確位之後，下一步就是養成運動的習慣。

恥骨骶骨肌的運動有兩種，一種要將抗力裝置插入陰道，另一種不用。使用裝置來收縮和放鬆肌肉的確有重要的益處。當凱格爾建議病患做運動時，他指示病患在練習時要使用他的陰道壓力計。不使用抗力裝置的運動可

以有效保持恥骨骶骨肌的收縮及陰道的濕潤，但如果肌肉已萎縮，及增強，就無法加以糾正。

很明顯的是，凱格爾從未提供手寫的講義或運動說明給病患，紀錄中描述了他建議病患做的練習，每個案例的說明都不太一樣。師和書本給的說法可能有很多種，或甚至分歧。很多醫師相信運動決生理問題的有效方法，很可能就是因為沒有一套詳細而始終如一針，他們無法給病患適當的指示，說明該如何做運動。舉例來說，忘記建議病患使用抗力裝置。

該用什麼裝置？在哪兒可以買到呢？抗力裝置不需要花很多錢是很不錯的替代品。此外，人造陽具和電動按摩棒也算是抗力裝置產品還有讓人不會聯想到性愛的外形及顏色，如果你不想自己到店裡購買，也可以使用郵購（細節請參考www.DrGSpot.net）。不論你選擇何種裝置，必須要硬度適中，但有一點彈性。有些女性說，如陰莖形狀的按摩棒這種用硬塑膠製造的裝置，會讓她們感覺疼痛。

先來討論抗力練習。由於頻繁的定期運動才能改善恥骨骶骨肌的功能，



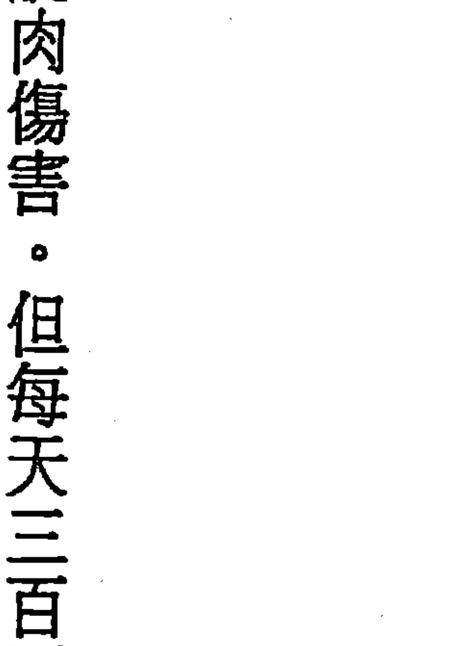
每天至少要排出兩次、每次十五分鐘的空檔。選一個你比較不容易被打擾的時段。把門鎖起來、拔掉電話的插頭，而且有需要的話，在門上貼一個「請勿打擾」的標語。使用抗力裝置，擠壓恥骨骶骨肌三秒後放鬆三秒。連續做十次。如果剛開始沒辦法保持收縮三秒鐘，先持續兩秒或一秒都可以。等你的力道和耐力慢慢累積，逐漸將時間加長到十秒。放鬆的時間和收縮的時間一樣，而且不要跳過放鬆的時候。這和收縮一樣重要。等到做過十次收縮和放鬆後，練習用恥骨骶骨肌短暫的彈動。快速收縮和放鬆肌肉，連續做幾分鐘。剛開始可能會覺得根本不知道是在收縮還是在放鬆，但長時間練習下來，你會覺得越來越簡單。一名喜愛音樂的女性說這很像在鋼琴上彈奏震音。她習慣播放自己最愛的樂曲，然後一邊按著節拍運動自己的恥骨骶骨肌。等到更熟練後，她會用恥骨骶骨肌敲打出曲調，叫她的丈夫猜猜看她在表演哪一首曲子。

每次練習時，該做幾下收縮呢？凱格爾常說，每天必須做三百下，才能明顯看到成效（他是指用他的陰道壓力計監測的收縮次數，每次幾秒鐘）。做那麼多次收縮可能太過頭了，特別是在剛開始的幾週內。就像其他的運動規

畫一樣，開始時要循序漸進，免得造成肌肉傷害。但每天三百下收縮，大約是每次練習做一百下，為了達成療效，或許還算是合理的目標。隨著你的進步，長期持續練習比每次做很多下收縮更重要，後者會讓人覺得無聊，結果在還沒看到成果前就放棄了。

不使用抗力裝置的練習有一個重要的優勢，隨時隨地都可以進行，而且別人都無法察覺。開車、吃晚餐、聽演講、打橋牌或打字時，都可以在不使用抗力裝置的情況下做上面描述的運動。我們稱之為自發性練習。在研究中，我們發現享受性愛且規律進行性行為的人一整天下來，會經常運動到自己的恥骨骶骨肌。

你可以在看得到的地方擺一個小東西來提醒自己做運動。比方說在公事包、電話、冰箱、時鐘或檯燈上貼一個顏色鮮明的小圓貼紙。每次看到貼紙時，就收縮恥骨骶骨肌幾次。另一個方法則是利用某項經常發生的事件。一名股市營業員則是在電話響起時做幾次快速的收縮。找出你生活中經常發生的事件，然後在事件發生時記得做練習。



做固定式或自發式練習時，也要注意到自己的反應。很多人只要一有性興奮的想法，就會無意識的收縮恥骨骶骨肌。這可能會導致陰道潤滑。有些女性看到覺得很有性吸引力的人就會分泌陰道液體，她們可能在收縮恥骨骶骨肌時毫不自知。如果你的肌肉無力，或找不到恥骨骶骨肌在哪裡；就無法培養這個習慣。

規律訓練幾週後，你可能要重做手指測試或尿流練習，和第一次做的結果比較看看有什麼差別。務必了解自己進步的程度，只要方向對了，些微的變化也能提供鼓勵和繼續的動力。大多數人很容易氣餒，還沒看到成果就放棄。如果不重新評估成果，要等一兩個月才能看到明顯的進步。

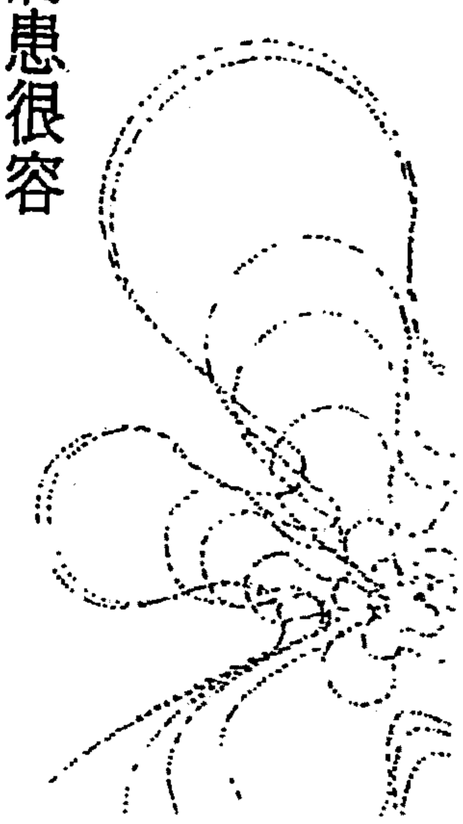
如果你看診的醫師可提供測量恥骨骶骨肌的裝置，這非常有幫助，有問題需要評估或訓練恥骨骶骨肌的女性也一定要使用這些裝置。陰道肌動描記器等大多數的設備都非常昂貴，一般人都負擔不起，但使用這些設備的確有好處。最重要的就是正確的診斷：肌肉是否太軟弱？肌肉是否長期繃緊？專業設備也有助於確認病患鍛鍊的部位是否正確。使用儀器也能讓醫師準確量化病患的進步，比較每週的變化。儀器提供的數位讀數或長條圖紀錄上會記

錄非常微小的改進，讓病患看了更受鼓勵。如果沒有有效的監控，病患很容易失去信心、無法成功或進步不如預期順利。

通常伴侶會最早發現你的恥骨骶骨肌有了一些改變。如果你的伴侶是男性，你可以在行房時練習收縮恥骨骶骨肌。根據肌肉最初的強弱程度，可能要過了好幾天或甚至兩個星期他才有感覺，不過他應該不久就會注意到了，如果他願意參與，你可以扭轉形勢，叫他插入後開始收縮他的恥骨骶骨肌，這會強化他的肌肉，讓陰莖朝著肚臍的方向上升，有可能更容易刺激到你的G點。如果你感覺不到他的收縮，或許他也需要閱讀本章，然後開始規律的練習。

要記得，沒有規律練習的話，不可能看得見成效。請看這個例子：

瑪西並沒有意願要強化自己的恥骨骶骨肌或性反應，但她的男朋友非常堅持，所以她在六個月內來了三、四次。每次用陰道肌動描記器測量她的讀數都只有三微伏特（非常微弱）。瑪西承認她根本沒有做運動，時，她只是因為男友極力要求才來看診（最後他們分手了，瑪西再也沒來過）。



另一方面，勤奮練習則可能有立竿見影的變化：

桃樂絲很年輕就當了母親，每天忙著照顧孩子，她對性愛越來越沒有興趣。她的丈夫因此有了外遇，而且外遇關係讓他發現強力的恥骨骶骨肌有很多好處。他告訴桃樂絲他有了外遇和他的發現，還威脅她如果她不去求診改善無力的恥骨骶骨肌，他就要離婚。

桃樂絲是虔誠的教徒，她很傷心丈夫有了外遇，但也承認自己的問題。讀過相關書籍後，她去看婦科醫師，在檢查骨盆時，她問醫師有關恥骨骶骨肌的問題。令桃樂絲很驚訝的是，醫師說他對恥骨骶骨肌一無所知。

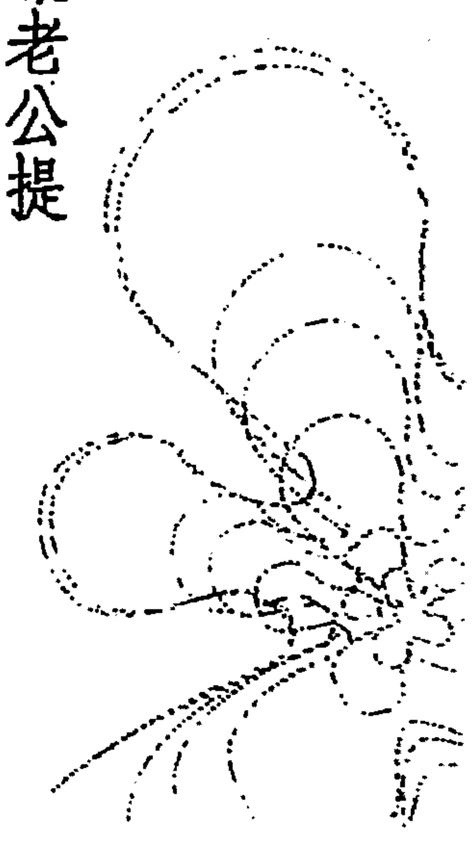
桃樂絲覺得很挫折，於是她花了六個月的時間來了解恥骨骶骨肌運動，但不怎麼成功。最後她找到一名提供陰道肌動描記器的生物回饋治療師，於是立刻預約看診。

治療師說：「她是我開業以來最好的病患。為了不讓自己下地獄，她

的動力十足。桃樂絲相信因為她忽略了自己的恥骨骶骨肌，才會讓老公提出離婚，在決心拯救婚姻後，她努力鍛鍊自己，幾近瘋狂的程度。第一次做評估時，她的讀數很低，但接著開始每天都做三百次十秒長的收縮，週後回診時，她的肌肉強度已經超過美國女性的平均值。到了第二個星期，她的讀數接近十九或二十，算是在接受測量的女性當中，排名進入前百分之二的了。」雖然桃樂絲的婚姻還有其他的問題，需要婚姻治療師的幫助，但她的丈夫再也沒抱怨過她的肌肉很無力了。

在本章前面說到用運動來解決恥骨骶骨肌的問題對身體「沒有有害的副作用」。但還是有個會導致很多問題的副作用——運動恥骨骶骨肌可能會導致性衝動，而女性多半不知道該如何自理。運動可以改善應力性尿失禁等病情，但治療師多半忘了告訴病患她們的性衝動也可能變強。這應該算是一件令人開心的事，也表示你的身體健康，不應該讓你覺得焦慮或有罪惡感。

在我們的研究中，我們訪問了數百位嘗試過的女性，她們曾經利用運動改善恥骨骶骨肌，但卻在問題解決之前就放棄了。在探索很多案例的原因



時，我們發現，無法解決的性衝動是一項重要的因素。

由於開始恥骨骶骨肌運動的女性幾乎都發現自己對性愛關係的渴望了，運動導致的性衝動「問題」該怎麼解決呢？如果你的伴侶不怕你的高漲，解決方法就很顯而易見，你們兩人也都會很享受。另一個滿足自己的性慾出口就是自慰了。

這個主題的爭議性很強。很多女性從小就被教育不要碰觸自己的器。有些宗教認為不論是男性或女性，從事所謂「自瀆」的行為，就是罪惡。對於信仰這些宗教的人來說，自慰絕對無法當做解決方案。但自有正面的觀點，有人認為自慰是一種合乎本能、令人愉悅的活動，從很時候就開始，「過度」沉淪於自慰是其他問題造成的，而不是造成其他的原因。

我們相信自慰有其重要的生理和心理因素。這是學習本身反應的最佳方法。讓你有機會單獨體驗用不同的方法碰觸自己、碰觸不同的部位和性滿足的各種方法。如果沒有適合的對象，也不需要硬找到一名伴侶。候，自慰會讓你更了解自己的身體，你可以和伴侶分享這些資訊。如果你不時有達到

敢跟伴侶分享你的發現，這可能表示你們的關係有問題了。

美國的女性大約只有三分之一有自慰的習慣，但男性則高達三分之二。一般而言，經常自慰的女性比較不容易得到肌肉無力的問題。這裡有兩個因素。會自慰的女性可能也比較容易察覺骨盆區域的感受。如果透過自慰得到高潮，也能確保你的恥骨骶骨肌有運動的機會，讓你更容易察覺生殖器的敏感度。這好像兩條盤旋的線，缺乏自覺會導致自慰次數更少，進而造成恥骨骶骨肌運動減少，最後導致肌肉無力和萎縮。

本章主要在討論女性的恥骨骶骨肌，因為在我們的社會中，恥骨骶骨肌嚴重無力的患者還是以女性居多。雖然此中的原因不在本書的範圍內，其中一些因素其實大家都看得出來。不過，很多男性也有恥骨骶骨肌無力的問題。一個徵兆就是反應期很長，這是指射精後到下次再度勃起的期間。研究的結果讓人不得不相信，男性也跟女性一樣可以多次高潮，而這項能力最不可或缺的因素似乎就是有力的恥骨骶骨肌。

男性可以從直腸內找到恥骨骶骨肌的位置，就像女性伸手到陰道內找到這塊肌肉的方法一樣。男性也可以做同樣的手指測試和尿流練習，自發性練



習對他們來說也有同樣的益處。培瑞設計了一個直腸肌動描記器，像是比較小的陰道肌動描記器，用來訓練男性（或有陰道痙攣的女性）控制恥骨骶骨肌。持續縮緊一段時間後放鬆，兩個動作交替進行，以及快速彈打恥骨骶骨肌，對男性和女性來說一樣有效。

另一個很有益的運動「毛巾魔法」，也是男性可以練習的。恥骨骶骨肌健康的男性應該可以在勃起的陰莖上掛一條小毛巾，然後收縮肌肉，隨心所欲的抬高和放下。如果毛巾會滑下來，用一條比較輕的。萬一恥骨骶骨肌並不那麼有力，先用手帕來練習。勃起的陰莖必須相當堅硬，才能做毛巾魔法，大多數男性會希望一開始時先私下練習，因為「表現焦慮」是男性勃起的大敵。

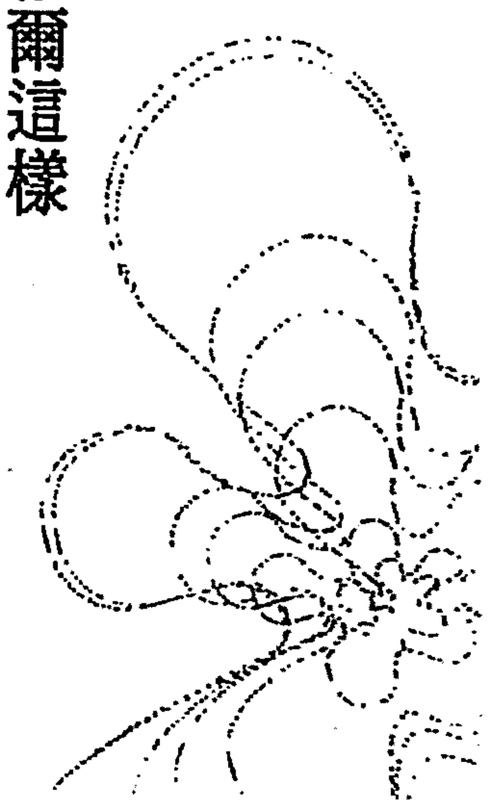
從歷史上找尋證據時，很明顯的是，我們對於健康恥骨骶骨肌的發現已經是老生常談了。在一九二六年，范戴維爾出版了一本書《理想婚姻的生理學和技巧》（*Ideal Marriage: Its Physiology and Technique*），成為之後二十多年來最受歡迎的性愛手冊。在馬斯特和強生成為性愛權威前，這本書再版四十多次，影響了數百萬的人。在八十年後，雖然我們對人類構造和生理學

有了更進一步的了解（比方說荷爾蒙的作用），但沒有人能像范戴維爾這樣從美學的角度來研究性慾。

事實上，范戴維爾也完全明白，能夠按心意控制恥骨骶骨肌對性有多麼重要，也清楚闡述了之後研究學者一而再、再而三反覆發現的原理，也就是某些女性「特別熟練和精通」如何控制恥骨骶骨肌，「隨心所欲——在性技巧中無比重要的技能……但女性完全忽略了骨盆腔的運動，幾乎沒有例外。」

一名六十多歲的女性告訴我們，她在青少年時期讀了范戴維爾的著作，也和自己的密友分享其中的資訊。星期六下午，她們不去看電影，反而坐在家裡鍛鍊恥骨骶骨肌。一名少女說：「我開始運動了。」另一人回答：「真的嗎？」這名女性發育出非常強壯的恥骨骶骨肌，也能多次達到高潮。但她沒有練習如何放鬆肌肉，所以不時會發生陰道痙攣的問題。

范戴維爾在幫病患做婦科檢查的時候，其中一項例行公事是指導她們做肌肉運動，他也鼓勵其他婦科醫師「利用此類無可避免的專業場合給予病患這方面的協助」。可惜除了凱格爾外，很少有人聽從他的忠告。



在一九四〇和五〇年代，性慾仍是專業醫師避免的話題，大幅削減了凱格爾的研究成果可能造成的衝擊。凱格爾讀過范戴維爾的書，在一九四〇年代晚期，他開發了「一整套」恥骨骶骨肌復健的做法，拓展他的觀察結果。在一九四二年以前，凱格爾已經有了足夠的臨床經驗來說服自己他的方法有效，可以大幅降低恥骨骶骨肌需要外科手術的比率。

凱格爾在一九五〇年代早期發表了一些文章，宣稱在三千名應力性尿失禁的病患中，有百分之八十六接受陰道壓力計和運動法治療後已成功痊癒。他也提到，在幾乎每個案例中，恥骨骶骨肌的力量和控制得到改善後，可以立即改進性反應，許多女性因此得到人生中的第一次性高潮。

凱格爾就像葛瑞芬柏格一樣，在主導科學研究圈的智力權力鬥爭中敗下陣來。一九五六年以後，當金賽及馬斯特和強生的「陰蒂至上」派成為性學權威後，他再也不曾發表著作，直到最近，凱格爾和葛瑞芬柏格才回到主流。

即使在今日，雖然世界各地都有人在做凱格爾運動，除了產前教育專家外，美國的醫師卻很少囑咐病人做這種運動。

這是性治療史上的一個謎，雖然「凱格爾運動」已經世界知名，而且各地都有人用這種方法治療應力性尿失禁，但大家似乎都忽略這項做法和性有關的地方，即使是金賽及馬斯特和強生這麼出名的研究學者也一樣。

這個對於現代性研究發揮了深刻影響力的團隊居然未能認同凱格爾的發現，真的非常可惜。

等到一九七九年，對於恥骨骶骨肌和高潮能力之間的關係，才真正首次出現統計及實驗的證據。同年，性治療師格瑞博夫婦（Benjanmin Grabe and Georgia Kline-Graber）分析他們從二百八十一名女性看診者身上收集的資料。他們把患者分成三群：完全無法達到高潮；直接刺激陰蒂可以得到高潮，但性愛時無法高潮；以及經由陰蒂刺激和性愛都可以達到高潮。可以預期的是，第三組的恥骨骶骨肌是最有力的（凱格爾的陰道壓力計平均讀數為十七），完全無法高潮者恥骨骶骨肌是最無力的（平均讀數只有七）。中間那一組，只能透過陰蒂刺激得到高潮的人，肌肉強度則介於兩者中間（平均讀數十二）。格瑞博的結論是「無法達到高潮的女性體內有一塊環繞陰道的



主要肌肉已經受損」。

格瑞博的結果符合培瑞和惠普的研究。根據對求診者使用陰道肌動器的經驗，他們認為肌肉越有力的話，女性越有可能經由陰道刺激而得到高潮。在另一份報告中，他們觀察到，在高潮時噴出液體（至少有一次經驗的人），恥骨骶骨肌的收縮強度明顯超過從未噴出液體的女性。

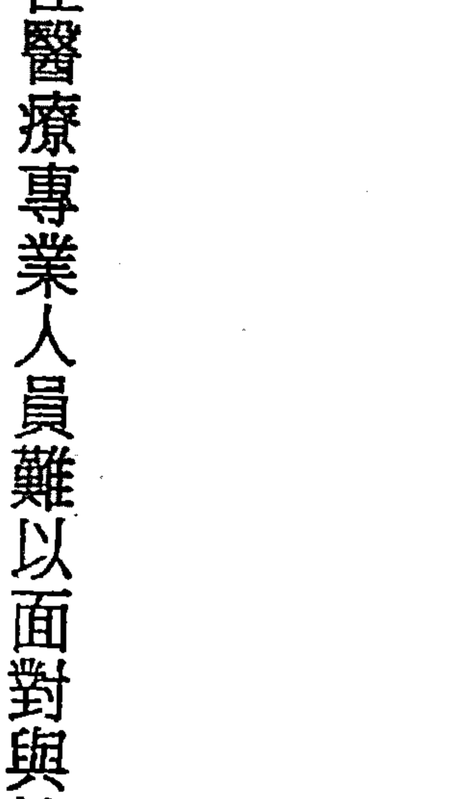
在一場生物回饋的會議中，一位全國知名的女性講員在生理治療和的研討會中，發給參與者每人一本小冊子，裡面用圖片詳細描繪人體的塊肌肉。在看過圖片後，一位參與者問道：「為什麼圖上肚臍下面和雙間是一大塊空白呢？」

講員滿臉尷尬的回答：「哦，說實在的，骨盆中有一些很重要的肌但生理治療師傳統上都加以忽視。」

婦科醫師和生理治療師等專家希望盡可能避免接觸到病患與性愛有肌肉，有很多理由。不幸的是，我們的社會寧願選擇不理會這種現象，不惜妨礙我們的健康。美國精神科醫師都加入美國精神醫學協會的醫療保險。其中患者與治療者間發生性關係的損害賠償，也算在「醫療過失」項

目中，最高理賠金額也還算可以，難怪醫療專業人員難以面對與性愛肌肉有關的問題。

但更不幸的是，大多數人對性愛肌肉都有強烈的個人感覺，相較於身體其他部分的肌肉，這種感覺更為激烈。當人們開始注意骨盆肌肉時，就會讓人想起早就埋在內心深處的回憶。生物能量分析則認為，在身體其他肌肉放鬆時，也會有這種情形。



茱蒂四十多歲，開始以陰道肌動描記器治療應力性尿失禁。肌肉進步愈多，她反而愈不快樂，最後終於放棄運動。治療師要茱蒂多往好處想，恥骨骶骨肌無力也是有「優點」的，沒多久，她才頓悟。多年前，茱蒂迷戀上同辦公室的一個男人，她坐在電腦前幻想，同時還收縮她的恥骨骶骨肌，長達好幾個月。有一天，茱蒂心目中的白馬王子注意到她，對她相當友善。但這個男人愈友善，茱蒂就愈害怕。因為她太沉迷於幻想中，卻無法想像在現實中兩人會發展出一段情。她開始在恥骨骶骨肌收縮時，出現不道德和危險的念頭。許多年後，當茱蒂開始訓練恥骨骶骨肌矯正膀胱問

題時，多年前沒有結局的戀情，危險和罪惡感又清楚的浮現在腦海。

茱蒂的故事告訴我們恥骨骶骨肌訓練的副作用。練習時打開塵封已久的記憶和恐懼，並不特別，可能需要專業諮商，或至少患者要好友適時給予支持。專業人員參與肌肉訓練，可以發現並處理過程中的阻力和障礙。通常會建議放慢肌肉訓練的步調，先解決發生的情緒問題後再繼續。

另一個要注意的問題是，幫患者訓練恥骨骶骨肌時，患者容易對幫助她們的人產生好感。歌手愛上指導老師，也是類似這種情形。打開喉嚨的肌肉和打開骨盆的肌肉很像，會誘發強烈的性慾。歌手有時會相信是指導者教他們使用肌肉的新方法，才能讓他們透過自己的動作，體驗前所未有的快感。類似的事情也可能發生在接受恥骨骶骨肌訓練的人身上。就跟所有的治療一樣，治療師必須熟知這種現象，以專業的誠實、熟練與了解，掌控自己和患者的情緒反應。

一開始討論骨盆肌肉時，我們提到有另一組更深的肌肉，約在恥骨骶骨肌三分之一處，上面分布骨盆神經，這就是尿道肌肉。培瑞和惠普研究女性

射精時內部肌肉扮演的角色時，他們發明了尿道肌肉收縮儀，跟子宮頸帽一樣直接蓋住子宮頸，邊緣貼著肌電圖感應器。它可以偵測尿道的肌肉活動。英格蘭則有學者發明更具侵入性的檢查方法。

惠普和培瑞利用這個儀器發現，二十位參與研究的受試者中，有兩人可單獨收縮恥骨骶骨肌和尿道肌肉；其他十八位受試者都是兩組肌肉一塊動。可以單獨使用兩組肌肉的能力雖然令人驚訝，但卻幫助學者解釋，不同高潮和女性射精的機制。范戴維爾在一九二六年明白指出：「女人必須學習如何單獨移動不同的肌肉，可以同步控制或是一個動完換另一個。」

本章一開始提到骨盆外部的肌肉，對性反應也很重要。除了有臨床的證據，也從拉達斯的研究「女人和生物能量分析」中得到證實。

從人類學中也可找到證據，馬林諾維斯基曾描述另一個托布倫人的細繩遊戲，顯示性愛時隨意移動骨盆的重要，「繩子被拉到中間的繩圈中，代表生殖器，快速上下左右移動，這……是性交時的動作。」

在《性愛的感覺與動作》（*Movement and Feeling in Sex*）一書中，精神科醫師亞歷山大．洛文寫著：



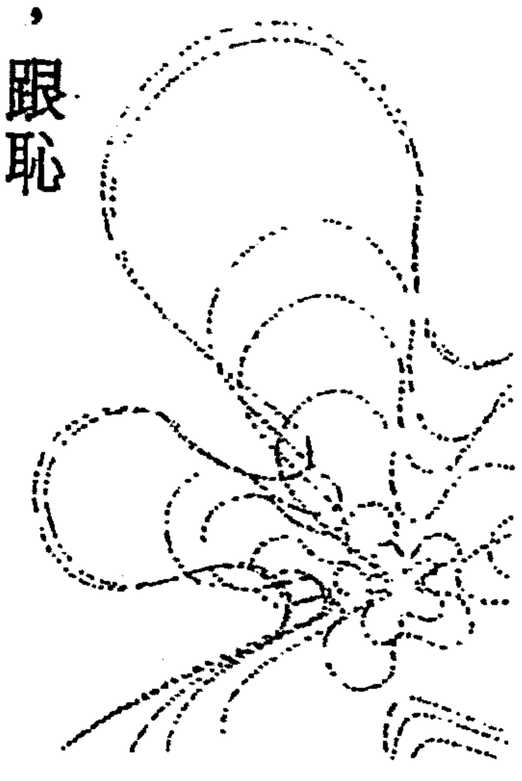
健康的性交包含感覺與強烈的動作……這對男女來說都一樣。性交動作要靠肌肉，無論是自主性的動作，有彈性和強壯的肌肉，才能在性交時持續做出具有節奏性的動作。跟恥骨骶骨肌一樣，外部肌肉太過鬆弛時，不能發揮功能，也會喪失敏感度。根據洛文建議，做愛第一要做的是撫摸全身，而「動感的愉悅來自骨盆律動」，性行為第二階段時則愈顯重要。如果骨盆不能自由擺動「就像可以隨意搖擺懸盪的兩條腿一樣」，骨盆的律動沒有增加時，性敏感度就會跟著下降。

有一些狀況會妨礙骨盆的律動。慢性肌肉緊張時，骨盆肌肉、大腿和腰椎無法分開移動，使人要動骨盆時，不得不動全身。這樣一來，不但阻礙製造快感的動作，感覺也會遲鈍，也不能刺激內部性器官。許多人自有一套解決的方法，有人繃緊臀部肌肉推動骨盆，取代自然的推力。有時則是緊縮腹部肌肉把骨盆往前拉。洛文認為，兩種招數都可能會阻礙感覺的流動和全身的放鬆。

骨盆外部肌肉鬆弛無力、甚至因不用而萎縮時，會產生的問題，跟恥骨肌鬆弛萎縮時差不多。下半身與上半身不協調時，身體的律動就會大打折扣。肌肉動作缺乏一致性時，動作變得僵硬，做愛時就不會有溫柔的感覺。根據生物能量理論，心理層面也會發生的問題，生理層面也會發生。做愛時，若狀況好，高潮時骨盆會有不自主的律動，類似自主性的律動。肌肉若不能在自主的律動時正常作用，在不自主律動時也一樣會有問題。

這段簡短的介紹，告訴大家無論男女，外部肌肉健康的重要性。回答愛麗絲和哈洛第一階段問卷的女性指出，治療可以幫助她們放鬆緊張的肌肉，鍛鍊鬆弛的肌肉。百分之八十一的女性治療後，達到高潮的能力都有明顯的進步。百分之五十四的受訪者表示治療後可以更隨心所欲的移動骨盆，百分之四十三則認為做愛時所花的力氣變少，這也再次強調肌肉健康的重要性。健康的肌肉也可讓人更能享受激情的快感。一位受訪者描述自身的經驗時說：

> 治療前我簡直像個死人，我的肌肉和感覺像被箝制住了，放不開。我



一直很遲鈍，下半身緊張僵硬，情緒更是焦慮。治療後，我開始有了以前沒有的感覺，享受性生活，還可以達到高潮，真的是太棒了。

另外一位女士告訴我們健康肌肉的重要性：

當我開始接受生物能量治療時，我的腿連騎馬時都沒有辦法夾住馬鞍。四年間我沒再騎馬，對我來說比較好過。但是我從沒有高潮，開始透過陰蒂刺激達到高潮，然後性交時配合陰蒂刺激，也能有陰道高潮。現在不需要陰蒂刺激，當我整個人放開時，感覺陰道快要融化了。身體的激情，是在陰道裡。肌肉不緊張時所帶來的激情，是完全不一樣的。

其他女性則說，「隨便就會有好幾次高潮，我還要性伴侶配合我」、「身心合一的感覺」、「是個不受意志干擾，激烈的全身經驗」。

還有像這樣的評論：「是一種從頭到腳高潮迭起的感覺。」可見性愛的

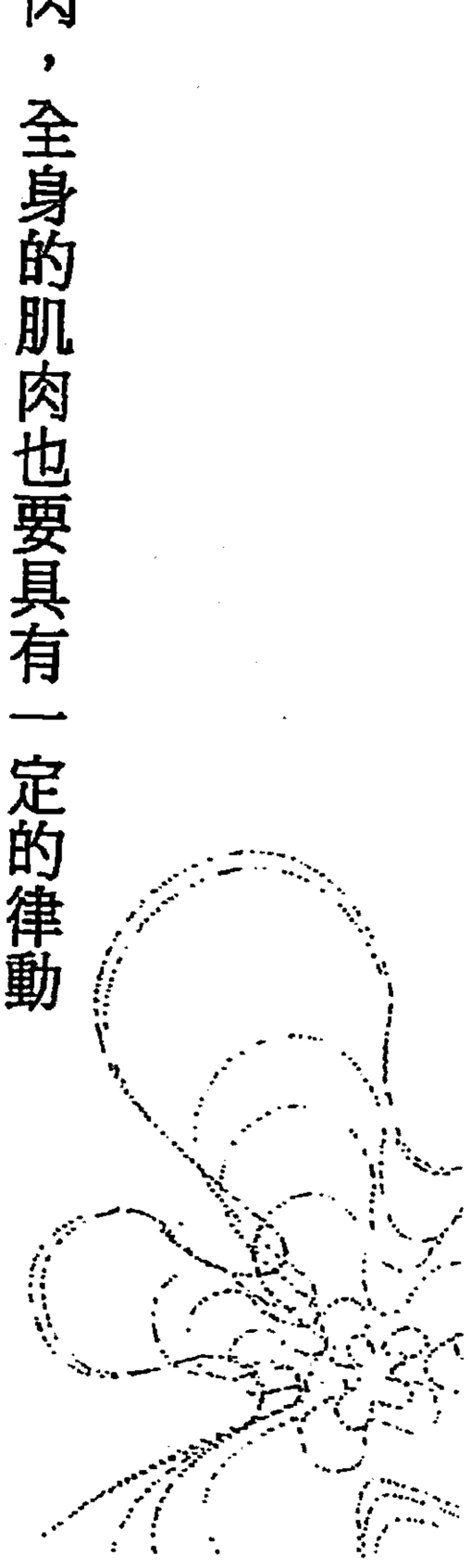
律動不只要靠健康又隨心所欲的骨盆肌肉，全身的肌肉也要具有一定的律動性。前面提到身心合一，不受意志干擾的說法也相當正確，因為當肩頸和胸部肌肉放鬆時，就會有這種感覺。

一位治療師描述肌肉組織和態度的關連性：

> 一開始，許多女性因為骨盆緊張，才不知道如何，也不會主導性生活。但治療後，她們開始告訴我，性生活改善，常達到高潮，也更放鬆。

幫助患者放鬆緊繃的骨盆肌肉，或身體其他部位的肌肉不同，訓練恥骨骶骨肌時會出現一些問題，比其他肌肉的問題更難解決。快感焦慮（pleasure anxiety）就是其中之一，一位女士說：

> 不再僵硬時，我感受到前所未有的快樂，但我卻怕得要死，因為沒有人告訴我發生什麼事。



另外一位女士則說：

當思緒與身體脫鉤時，我比治療前更能享受性愛的快樂；在治療時，思緒回來了，我感到害怕、更緊張，甚至暫時不能動，這應該只是過度時期的問題吧！

然而，許多人靠自己努力伸展、發達和運動骨盆外部肌肉和恥骨骶骨肌，通常是為了增進性功能。許多文化把像草裙舞、中東舞蹈和東方舞踏融入日常活動中，做為發現、控制、強壯骨盆肌肉的方法。不是只有上述舞蹈才有這些作用，迪斯可對骨盆肌肉也有幫助。

雖然我們認為訓練骨盆外部肌肉有助於恥骨骶骨肌的健康，目前還不確定是否真有效果。但我們可以確定的是，只要恥骨骶骨肌強壯有彈性，可以自由隨意動作的話，性交時更容易刺激G點或陰蒂。這在拉達斯的第二次調查中，也獲得證實。生物能量分析師和其他專業治療師答覆問卷時指出，做愛時健康的骨盆肌肉與姿勢、性伴侶感情投入的程度同等重要。

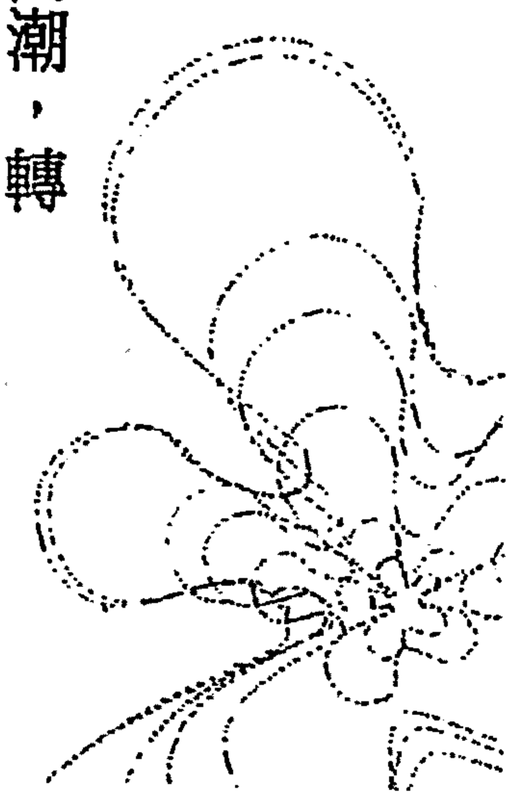
變成為不需要陰蒂刺激也能從陰道交媾獲得高潮：

許多參與拉達斯第一次研究的女性指出，她們從只能達到陰蒂高

治療前，我的性生活很愉快，也有高潮，但主要都是刺激陰蒂而來。

四年以後，雖然有時候性交時還是會碰到陰蒂，但我開始不需要刻意刺激陰蒂，就能感受到陰道高潮。陰道的高潮令人滿足，一點都不覺得失去什麼。但我不想有人要我放棄陰蒂高潮，畢竟有時感覺還是很好，我也想要。重點是，我現在不需要刺激陰蒂也可以獲得高潮。

這位女士的敘述提醒我們，高潮的經驗不只一種，大多數人都不想畫地自限，也正好帶領我們進入下一章——「持續的高潮反應」。



# 第五章

## 持續的高潮反應

性愛是由陰道開始，牽動全身，但最後合而為一個高潮，而非產生多個高潮。一些女性在連續刺激G點的情形下，可以有「多次射精高潮」，持續長達一小時。

性學的範疇裡，多元才是人性的本質。唯有考量人類的多樣性，可以讓我們不只容易接近真實，而在滿足自己的需求的同時，更能珍惜世上萬物的豐富面貌。人類就好像雪花，每個人長得都不一樣，高潮也是如此。

生化學家羅傑．威廉斯（Roger Williams）說：「人類生理與醫藥都應多花一點時間注意個別差異。」金賽研究團隊在一九四八年提出的報告寫道：「從各種不同的角度觀看我們生活的世界，會發現它是個變化極為隱微難察的連續體（continuum），人類的性行為也是如此，我們只要在性行上愈快發現這點，就能愈快了解真實的性。」

從那時起，許多性學家的研究，擴大人類對性經驗的了解。如果不要只拘泥在所謂正確、正常和健康的方法，或許更能幫助許多人享受自己獨特的經驗，增進情趣，達到滿足。許多「專家」都聲稱有一套控制飲食或性愛祕方，令人驚訝的是，有一堆人真的聽他們在說什麼。事實上，有很多方法可幫你增胖和減肥，或吃得更健康一樣，性愛也一樣，享受的方法不只一種。

金賽的理論引起世人注意陰蒂是女人最重要的性敏感部位之後，醫學界和實驗室都只專注於發現標準的性反應機制模式。當馬斯特和強生在



一九六六年宣稱所有的高潮在本質上都一樣後，許多人覺得鬆了口氣，把這個理論當成教條，信守的程度甚至遠超過馬斯特和強生自己。

在公開場合反對馬斯特、強生與他們的信徒，不是件簡單的事，所以當培瑞和惠普在一九八〇年美國性教育者、諮商師與治療師學會會議發表「連續高潮」（continuum of orgasm）的理論時，心裡還是有點忐忑不安。幾個月後，一九八〇年十一月美國性學研究學會開會時，拉達斯也提出連續性反應的觀點，這可說是三人合作的起點。拉達斯的研究挑戰另一個正統：就是性愛是由陰道開始，牽動全身，但最後合而為一個高潮，而非產生多個高潮，生物能量學派也認同類似的觀點。

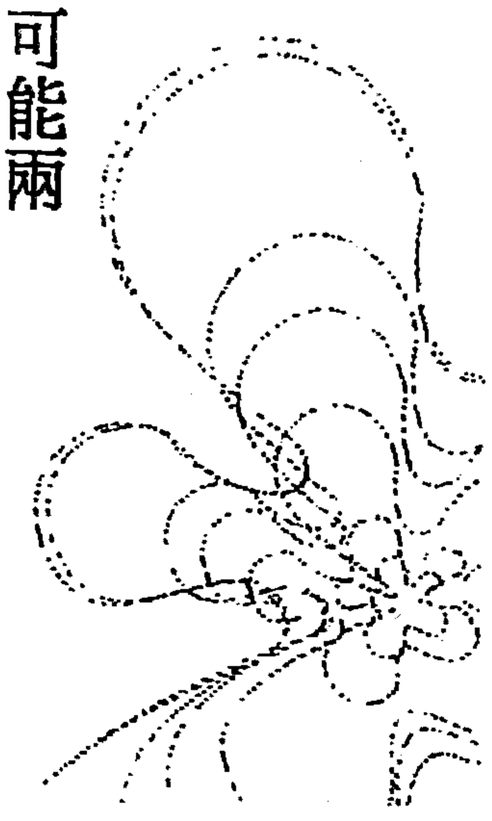
精神科醫師發現許多婦女因為喜歡陰蒂帶來的快感，因而感到罪惡、不道德或低級，也因此受傷害。但另一方面，女性主義者認為，女性把注意力從陰道轉移到陰蒂的價值在於，可將女人從過度依賴男人的習慣中解放。這兩種值得深入探索的觀點，最後卻變成研究者找尋真相的絆腳石，使研究者喪失客觀性。

我們傾向採納金賽的說法，認為高潮是連續性的反應。首先它跟誘發性

反應的部位有關；女性是陰蒂或是攝護腺，也可能兩者都可以一起有反應，其他部位也可能會有作用。再來則是刺激決定性反應的型態。生理活動可能一直都一樣嗎？還是會有變化？只有一次高潮，還會有一連串的高潮？反應集中在生殖器，還是全身都可以感受得到？另外高潮也跟情緒有關，可能是怨恨和憤怒，疼痛和厭惡，也有可能是愛和狂喜。高潮也跟發生的對象甚至物體有關，範圍可能從手淫、物品、動物到同性或異性的人，同時與一人或多人等；性伴侶的年紀、體形、生理特徵不同，都會有不同的影響。是隨興的性行為、玩樂，還是以身相許，也都影響高潮。性雖然有這麼多重要的面向，但本書只討論三項：誘發性反應、反應的效果、身體專注的程度。

第二章裡我們討論G點，事實上有很多女性早就知道刺激G點和刺激陰蒂有一定程度的不同。但在確定G點的位置和為它命名前，一談起陰道刺激，總是說不清楚。

一位接受性治療的女士就點出這樣的問題。



蘇珊是牧師的女兒，一談起生殖器，就困窘不已。當治療師談起新發現的G點時，她露出微笑說：「真有趣，二十九年來我們一直有這個問題，只是一直覺得不好說開來。查爾斯喜歡把他的陰莖刺向我的陰道深處，但說真的，他深入大概十公分的地方讓我覺得最有快感。」（實際上，她形容的十公分恐怕太深了，因為陰道深度也不過才十公分左右，G點距陰道口不到五公分。）

蘇珊喜歡的是陰莖龜頭刺激G點，但丈夫卻一點都沒感覺，每次只會插入深處。治療師歸納後認為：蘇珊忍受這些事長達二十九年，聽說G點以後，他們發現溝通性愛和性姿勢的新方法。

前面曾提到，通俗作家將馬斯特和強生陰蒂刺激的結論發揚光大，但所謂的「結論」，事實上，根本是在沒有進一步研究前，就照單全收金賽的理論。一九八一年美國性教育者、諮商者與治療師學會年會時，馬斯特再次強調他的理論說：「所有的高潮都與陰道刺激有直接或間接的關係。」

我們卻不這麼認為。我們的研究發現，許多受試女性長期以來只是把

陰蒂當成可以喚起高潮的附屬品。雖然會陰和陰蒂都連結陰部神經，但大多數的女性能清楚區分刺激這兩個部位時的感覺並不相同。刺激G點時，始得多花幾分鐘，才能讓大腦接收到訊息。G點的接觸會引起膀胱脹尿的反應，大多數女性必須克服這種會陰部位與性不相干的感覺，才能真正享受性愛的樂趣。接生時，為了讓寶寶的頭容易擠出產道，會執行外陰切開術（episiotomy），但對許多女性來說，刺激會陰在性行為中相當重要，醫師在動手術前應該三思。

在陰蒂獨大的理論中，還有一個有趣的變化在《女體新觀點》（*A New View of a Woman's Body*）一書中被提到。作者對於陰蒂通常被描述成一個跟陰道還有點距離的「迷你小芽」感到十分驚訝，因此他們發明了一個新的字彙來形容與陰蒂毗連的部位跟陰蒂一起構成了「完整」的陰蒂。這是對陰蒂最廣義、範圍也最廣的描述。前面提到的G點，變成「陰蒂的尿道海綿」。「陰蒂新觀點」的確拓展陰蒂研究的視野，再也不是金賽用棉花棒刺激的迷你器官了。

即使是在傳統限制下，陰蒂還是比許多研究者所了解的要複雜得多。隨



便一本基礎解剖學教科書都指出，除了有神經系統經由陰部神經連結陰蒂頭以外，陰莖體和接繫處則與身體深處的骨盆神經連結。但性學研究者常小看這些有重要意涵的生理構造，其實這些生理構造能幫我們了解不同女性享受的多種性愛。

許多醫學教科書對陰莖著墨甚多，對陰蒂則很少，不只描述很少，無論是陰莖或陰蒂，實質的討論都相當有限。對於男人性刺激的本質，除了提到陰莖尖端和陰莖體「敏感」外，很少人會想要找出其他的解釋。至少在科學出版品中，沒有任何著作曾經提到男性攝護腺的性敏感度。攝護腺位於陰莖體的根部，發炎、不適時，才會有人注意到它。因此從上面的推論來看，攝護腺應該會被重新命名為「陰莖的尿道海綿」。然而，在情色文學中，情形卻不一樣，對男性攝護腺敏感的描述，讓人聯想到G點，也讓人不禁想起刺激攝護腺和女性尋找G點的相似處。這並不令人意外，因為兩者是從同一種組織演變而來。

攝護腺敏感度在男性的性反應中扮演重要角色，這種說法可能讓很多讀者納悶，因為直腸內診，常會讓人覺得不舒服，因此男性對攝護腺都只有負

面的感覺。類似G點被手術破壞時，女性再難享魚水之歡；男性因為攝護腺手術喪失性功能的案例時有所聞。但男性對攝護腺、排泄物和肛門的嫌惡，使得大多數的西方男性從來不覺得攝護腺是性器官的一部分。

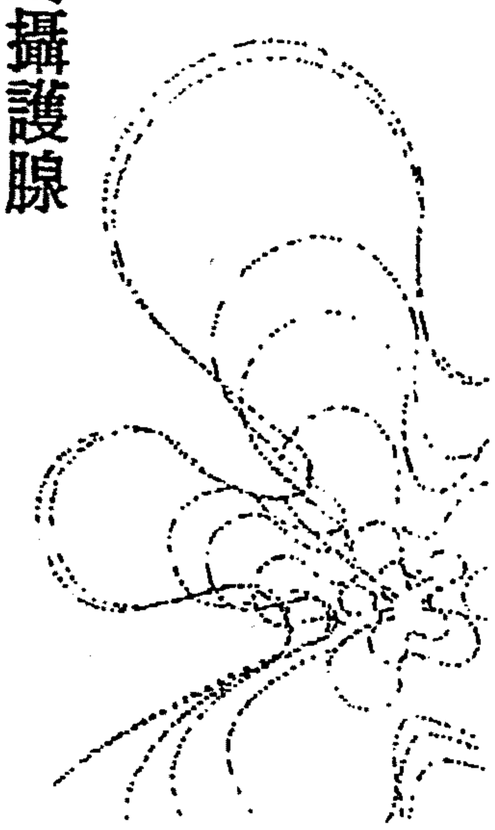
看看這位男性心理學家的經驗：

女性描述刺激G點的經驗時，都堅持的確有一個「點」的存在，碰觸時會覺得比陰道前壁其他地方來得舒服，這讓他感到十分疑惑。

他說：「沒有。」護士要他躺下，伸入潤滑過的手指。當她很快找到攝護腺的位置時，他大叫：「哇。」

他描述那是一種刺痛的感覺，好像攝護腺被長指甲刺到一樣。他要求檢查護士的指甲，結果護士根本沒留指甲，讓他十分驚訝。

「感覺怎麼可能差這麼多？」他自問。做為一個心理學家，他知道答案：身體感知——或者，更精確的說，大腦對感覺的解釋，是經由學習而來的。這次的感覺卻特別不同，不是劇痛，卻也不是悶痛。雖然這種肛門



被指甲刺到的感覺有點「奇怪」，他卻不得不承認讓他覺得滿舒服的。事實上，沒多久就開始變得很爽。

後來他評論這次經驗的啟示。當碰觸到攝護腺時，他並沒有把這種感覺與性經驗，也就是射精連結在一起。他發現，他一直認為攝護腺只是陰莖根部，在射精高潮時也會跟著抽動。

他的觀察讓我們開始審視男性攝護腺的性功能，這些觀察也提供更進一步的證據，讓我們注意到男人跟女人其實遠比大家想像的要更為相似。

培瑞和惠普開始在科學論壇討論攝護腺刺激之後，一些男同性戀者認為他們提出的觀點「正中目標」。雖然很少公開討論，但男同性戀肛交時，接受陰莖進入的那一方就因陰莖直接刺激到攝護腺而產生快感。作家伊蓮·摩根描述的「犬式」性交，陰莖比較容易碰到G點，這對男同志來說也一樣，像狗交配一樣的性交姿勢，也讓男人的陰莖容易碰觸到性伴侶的攝護腺。事實，同性的性交中比異性性交更容易刺激到攝護腺，可能也是許多男人喜歡同性性關係的原因之一。除了男同志，培瑞和惠普有關女性射精和G點位置

研究，也對美國邁阿密一個女同性戀社群產生重大影響。

一九八〇年培瑞和惠普的著作問世，書中指出，陰道裡能引起女性高潮的地方不只一個。早期馬斯特和強生的研究，目標是找出性高潮的共同「本質」。為了找出共同點，他們反而忽略很多非典型的例子，也摒除很多跟他們最初的假設不同的資訊，例如，就沒研究自慰時完全不碰陰蒂，卻能獲得高潮的女性。這也讓他們發現了想找的：一個符合研究對象的共同模式。但正因他們的樣本偏差，他們無法發展出符合其他女性的模式。

大多數的人讀了馬斯特和強生的報告後犯了一個解釋上的錯誤，大家都認為他們「發現」或「證明」了「所有高潮都一樣」。事實上，高潮的一致性，根本不是「發現」，只是「假設」。

金賽報告出現後，男性和女性都開始表現與官方報告一致的行為，坊間的通俗文學也很快把報告的內容融入小說情節中。但諷刺的是，教育程度愈高，愈容易取得書籍資訊的人，就愈容易受影響，認為高潮都一樣，都來自陰蒂刺激。

美國麻省理工學院哲學教授艾文·辛格博士（IrvinG Singer）認為，金



賽區分兩種對立的「習俗系統」。金賽描述的第一種型態為「加長前戲一種可以考慮使用的技巧變化，性交前大量的刺激，可以導致延後性交後兩性可以同時達到高潮。」馬斯特和強生的性治療中也認為前戲是一想的進步。

但相反的，另一個習俗系統則較認同簡單和直接的性交——一種英美法（Anglo-American Law）保護的選擇——有人將之揶揄為「衝、謝謝妳、女士」，當年在教育程度低者與勞工階級間相當流行。正如辛言，喜愛這種性愛的人，有系統地被馬斯特和強生被排除在研究之外，的研究對象大多是受過大學教育的女性。本書中所提到的來信中，對G激和女性射精的反應相當不同，可能是來信女性的多元背景導致。

馬斯特和強生的研究出版後的十年間，大家都保持沉默，有一些意袖偏好「簡單和直接」性交，站出來主張自己的看法並駁斥馬斯特和強研究。反對者認為，不論官方報告怎麼說，她們有不同的性經驗。例如位女性心理學家寫道：「我常發現專業著作中的主張跟自己的經驗衝突了解性經驗完全沒有幫助。」這位女士是人類學家的女兒，父親熱中於

是，最個，，

曾受、撞格所他們點刺

見領的生一對研究

性習俗，許多其他的文化中，以性交為基礎的性愛是很常見的。她的薰陶中成長。幾年後她學會自慰陰蒂，雖然有時這麼做，但還是喜歡性交時高潮的感受。

堅持所有的高潮都一樣的女性，有下面兩種可能：一、說的是實話，因為自己只有過一種高潮的經驗；二、錯，因為不是放諸四海皆準。只有曾經感受過兩種以上不同高潮的女性可以解答這個問題。幸好，這些女性開始發聲，下面的信是一位女士自身的經歷：

我幾乎可以確定自己有兩種不同的高潮。一種來自直接刺激陰蒂和陰蒂周圍，來得快，去得也快，感覺也沒那麼強烈。另外一種高潮則是來自性交，我認為這是一種「內在的高潮」。我躺下，男人在上位時，可獲得最佳的高潮經驗，另一個姿勢是男人坐在椅子上，我坐在他身上，兩人面對面，可以讓我很快達到高潮。

另外一些女性發現她們在上位時，比較容易高潮。另外一位寫道：



喜歡在上位，感覺更好，也更容易達到高潮。

一位女士說：

我經歷兩種高潮已有一段時間，藉由按摩棒刺激帶來陰蒂高潮後，發現兩種高潮的不同。以前，我從性交上得到快感和滿足，但是我一直好奇，是不是還有別的。自從發現我可以享受兩種但卻一樣愉悅的高後，對自己的性感，有更強烈的感覺。你們的研究應該繼續下去，造福我一樣還沒發現兩種高潮的女性，她們將會感謝你們為大家早就知道卻願意面對的事實提供專業意見。

我們在實驗室找到證據，驗證許多女性表示自己有兩種高潮的說法。近代人道主義心理學家亞伯拉罕．馬斯洛（Abraham Maslow）認為太多理論是根據研究「病人」而來。例如，精神病患。他建議，理論學家研究自我激勵（self-motivated）和自我證成（self-validating）的人，也就是應，不像潮很我

「自我實現」（self-actualized）的人。一九七八年，培瑞的性學研究決定用一個類似的策略，找受試者在實驗室裡驗證馬斯特和強生的肌肉收縮資料。他要男大學生選出校園內最「性感」的女生，他付費請這些女生來當受試者，其中有一位同意了。

在一項性愛喜好的紙筆問卷中，她獲得最高分。她的恥骨骶骨肌相當強壯，她的恥骨骶骨肌正常，隨著自慰時間增加，她的控制力也不錯。一開始自慰時，肌肉活動卻消退了。當時實驗室技術人員以為受試者只不過是暫停一會喘口氣——結果，遙控的信號燈閃爍了起來，表示她已有了高潮。

當我們稍後訪談時，她確定自己知道什麼是性高潮，而且表示她在測試時就有高潮，跟平常一樣。是她錯了？她說謊？或是她經歷「別的東西」？還是她經歷馬斯特和強生描述所謂「正常」的高潮？無論如何，她是因為特別才被選出來，可不是因為她正常才選她。

培瑞踢到鐵板。他讀過辛格的「三種高潮」理論：與馬斯特與強生類似的「陰部高潮」、推擠子宮頸的「子宮高潮」、第三種是混合第一、二種的



「融合高潮」。但是就像當時其他的學者一樣，他不願相信任何對馬斯特與強生的批評，直到他在一九七九年加入惠普「女性射精」的研究團隊後，亦格才認為可能有其他類型高潮。

大多會射精的女性指出她們的射精高潮類型也有許多差異，但約百分之十的女性表示，只有在口交刺激陰蒂時才會射精。其實是因為性伴侶的臉貼近尿道，察覺到射精的現象，才讓這少數的女性得知自己會射精。另外，較多的女性指出，只有在少數非常激情的性交時才會射精。從受試者的第一手資料發現，她們的經驗與辛格理論的「子宮」或「推擠子宮頸」的高潮不謀而合。

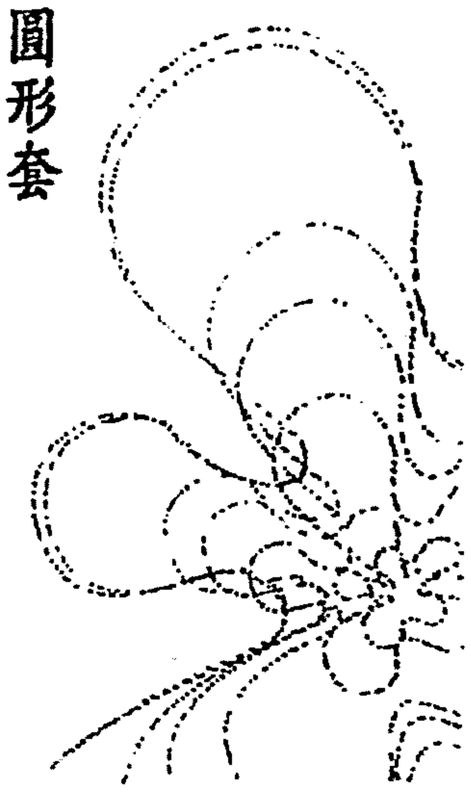
另一些女性的陰道性敏感經驗，則對新理論的形成有非常大的幫助。她們常常或只有在性伴侶手指直接刺激G點時才會射精。前面提到，這些女性的經驗，不只讓我們開始注意到G點本身是一個性興奮的中心，與陰蒂不同；也提供G點在持續性刺激下會充血腫脹的證據。最後，這些女性指出，在射精高潮的瞬間，陰道經歷非常戲劇性的變化。

我們觀察到兩種現象，一種是沒有形成所謂的「高潮平台」（陰道下三

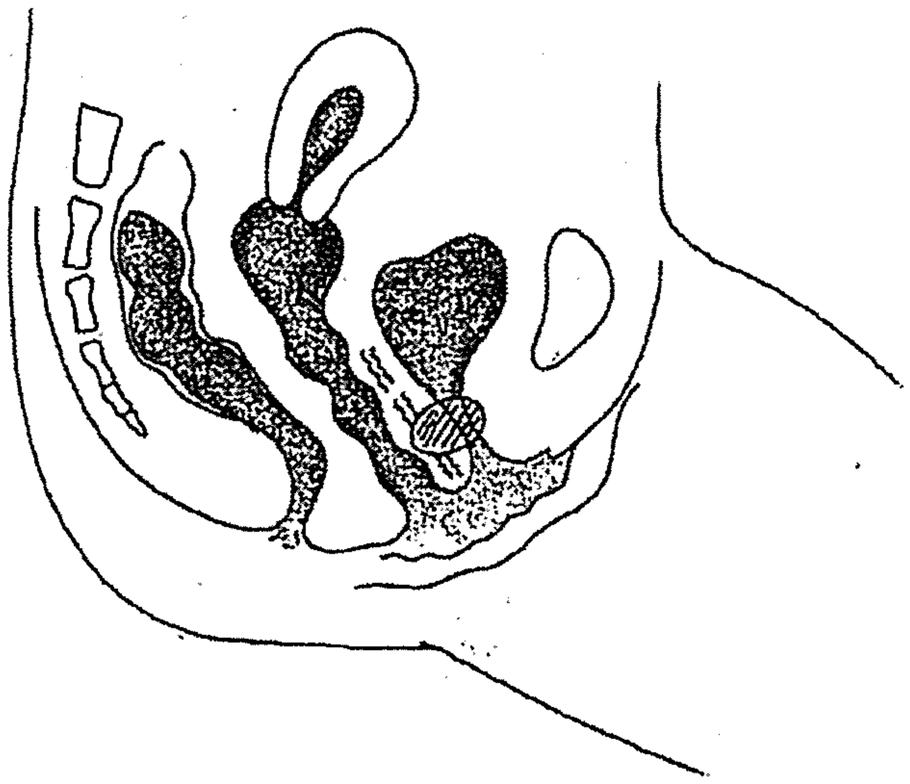
分之一處的組織充血腫大，導致陰道縮窄，形成性交時可以抓住陰莖的圓形套子），或出現像馬斯特和強生提出的陰道緊縮現象。這些女性指出，陰道沒有緊縮，反而放鬆，陰道口張開。而骨盆肌底肌肉的放鬆效果和陰道口的擴張，也不會妨礙陰道口的組織充血腫大。

第二種現象更戲劇化，沒有出現馬斯特和強生描述的「帳篷效應」（tenting effect）。所謂「帳篷效應」是指陰蒂高潮時，陰道內部會像汽球一樣漲大，把子宮推往腹部深處。因為陰蒂高潮有時會讓恥骨骶骨肌會異常緊繃，而陰道內部卻不斷擴張，反而使得與陰莖的接觸感消失了（這種效應在用手指查探的時候更明顯）。雖然馬斯特和強生把這種現象取名為「帳篷效應」，但卻像是倒過來的帳篷。

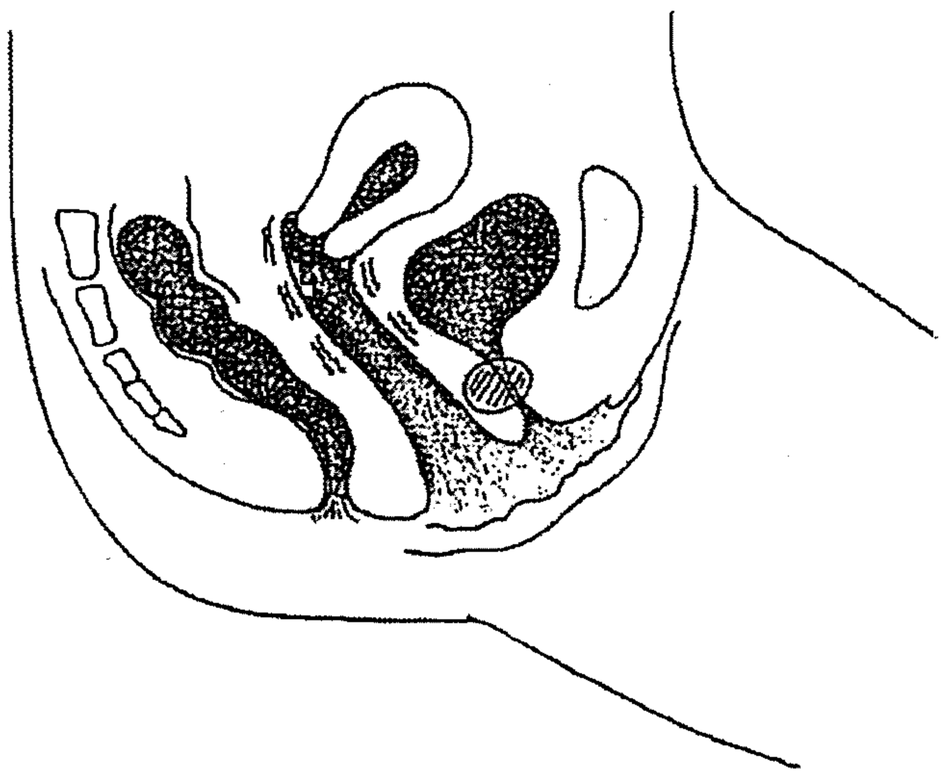
射精高潮卻出現完全相反的反應——不是陰道內部擴張和子宮被拉起，而是子宮被往下推，陰道上半部跟著壓縮。許多會射精的女性，都形容會有像「伐氏操作」（Valsalva maneuver），就是憋氣用力排便的感覺。培瑞和惠普稱為「A字形效應」（A-Frame effect）和「帳篷效應」區別，以代表其中的不同（如下頁圖五所示）。許多射精的女性指出，來自內部器官的壓



圖五



馬斯特與強生的「帳篷效應」（上下倒置）



培瑞和惠普的「A字形效應」

力常會把伸進來刺激G點的手推出陰道。有些女性還說，高潮時有時連陰莖都會被推出去。一位男士就曾表示有類似的經驗，不只陰莖被推出去，他也覺得沮喪。

突然發現在她高潮時，自己卻被晾在旁邊的感覺很差，她也一樣不好受。一開始我以為這是因為我的陰莖太小，但後來我學會跟她一起享受這樣的感覺。

然而，A字形效應不是只在射精高潮時才會發生。一位沒有射精經驗的女性描述她的兩種自慰高潮時說：

我有兩支按摩棒，帶來兩種不同的高潮。當我想要一般的「陰蒂」高潮時，便用一個大的插電式按摩棒，振動起來嗡嗡的很有力。但有時想要另一種，就用一個小的子彈型的按摩棒，大概只有四寸，可以完全塞進陰道中。它雖然只是搔動我的G點，但卻像是顆飛彈一樣，引爆我的高潮。



許多證據拼湊起來後發現，高潮絕不止一種，我們更有一大堆資料可證實。第一，許多報告指出，他們堅持曾經歷過至少兩種以上不同的高潮。第二，實驗室的證據指出，一些女性達到聲稱的高潮卻未出現典型的高潮平台。第三，我們發現女性射精是存在的事實，特別是在刺激G點的時候，就會出現這樣的反應。粗略檢視過一些解剖學的文獻後發現，G點並沒有神經的神經路徑，陰部神經也沒有通到陰部神經路徑通到子宮或其他內部器官。G點是透過骨盆神經與脊柱連結，骨盆神經同時也掌控膀胱和子宮，因此我們認為這是射精或其他「內在」高潮反應的神經傳導路徑。

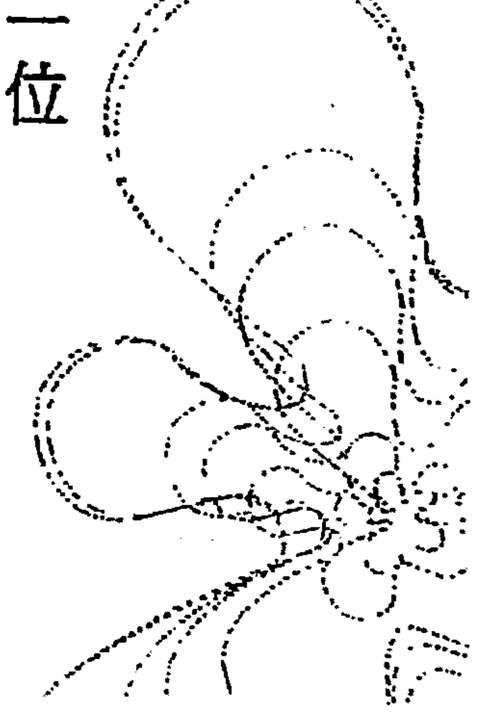
骨盆神經是人體最複雜的神經系統之一；還有一個主要的神經分支，稱為下腹神經叢（hypogastric plexus），往上延神到內臟和脊柱中段。下腹神經叢的傳導，可能連結骨盆肌肉活動和暫停呼吸，是約瑟芬和艾文辛格所稱「子宮」高潮的典型特徵。

骨盆神經與性行為有關的主張，也解釋為何脊椎下半部損傷的人還可享受性愛。如果只有陰部神經負責傳導性行為的感覺，這些脊椎損傷的人做愛

時應沒感覺才對；但卻不然，因為下腹神經叢才是他們的性神經頻道。一位三十多歲的研究生寫道：

> 我因為脊椎受傷，胸部以下癱瘓。醫師一直告訴我我不可能有「正常」的高潮，但G點的研究幫我描述我的高潮，我很感興趣。

世界上有許多學者證明骨盆神經和陰部神經在性功能上的重要性。培瑞和惠普發明子宮肌動描記器（uterine myograph），配合第四章提到的陰道肌動描記器（vaginal myograph），用來測量性刺激時，恥骨骶骨肌和子宮肌肉收縮的情形。過去研究者只放一個電極在陰道裡，但這樣無法確定發出肌肉訊號的方向，因此他們在陰道裡放了六個肌電圖（EMG）的電極。他們把三個陰道肌動描記器的電極直接放在高潮平台或恥骨骶骨肌上，另外三個則用子宮肌動描記器的吸引器上，固定在子宮頸上。單一電極對陰道口或陰道最深處發出的肌肉訊號一樣敏感，無法區分到底是哪裡的訊號。就好像用單聲道的耳機聽立體聲的錄音一樣，可以聽見所有的聲音，但



卻無法分辨是從哪個方向來的。

使用六個電極感應器的嘗試結果令人滿意。其中一個實驗裡，用強烈刺激陰蒂尖端，發現恥骨骶骨肌的活動比子宮肌肉多兩倍。再以式慢慢刺激陰蒂，得到相反的結果。與骨盆神經連結的陰蒂體及根部慢的刺激，有比較好的反應；陰部神經則對陰蒂尖端的刺激較有反應。

蒂刺激帶來的「表面」高潮；經歷「水乳交融」的性交時，則會達到較深層的子宮高潮。自慰陰蒂時子宮頸反應平平，大概是十微伏特，G點時的高潮反應就會高達十四微伏特。

培瑞和惠普在另一個研究中，觀察聲稱有兩種高潮的受試者，一重新檢視實驗證據和辛格的三種高潮分類後，培瑞和惠普提出另一種是陰

## 第二欄就是馬斯特與強生所謂的「陰部」高潮，因為陰蒂是主要的刺激

論——女性高潮的連續序列：一端是「深層」或辛格所說的「子宮」高潮。下頁表格合併兩種理論：

則是「外部」或是陰蒂引起的高潮，另一端

誘發點，也被佛洛伊德學派稱為「陰蒂高潮」。最明顯的性反應證明就是恥骨骶骨肌的律動性收縮。

## 培瑞和慧曾的高潮反應連續理論

| 參考值 | 1----2----3----4----5----6----7----8----9----10 | | |
|---|---|---|---|
| 辛格分類法 | 陰部高潮 | 融合高潮 | 子宮高潮 |
| 肌肉反應 | 恥骨骶骨肌 | 兩種肌肉 | 子宮肌肉 |
| 刺激誘發點 | 陰蒂 | 數個 | G點 |
| 神經系統 | 陰部神經 | 兩個神經系統 | 骨盆神經與下腹神經叢 |
| 高潮次數 | 一次或多次 | 一次或多次 | 一次或多次 |
| 感受焦點 | 高潮平台 | 陰道 | 子宮和骨盆器官 |
| 男性反應 | 高潮但不射精 | 典型射精高潮 | 無射精高潮 |
| 通稱 | 陰蒂高潮 | 陰道高潮 | 陰道高潮 |



有這類經驗的人，高潮大多集中在生殖器表面，或比表面再深入一點擴大到全身反應則是另一個完全分開的連續反應。它可以從非常輕微的生器局部痙攣收縮，到全身每處肌肉的震動，但大多侷限於局部。許多女性按摩棒刺激引發的高潮大概都像以下的描述：

一位研究受試者在陰道肌動描記器監測恥骨骶骨肌的情形下，以按棒自慰。一小時中我們記錄到七十次不連續的高潮，像馬斯特和強生描的恥骨骶骨肌收縮大約有六到十二次。受試者說，在家裡有時一小時可達到二百次高潮，但情感上卻不見得能得到滿足。

上頁表中連續序列的另一端是辛格描述的「子宮」高潮或其他學者謂的「深層」高潮。一些「陰道」高潮可以列入這個類別中。但你會注意「陰道道」這個字也放在中間那一欄。因為陰莖在性交時插入的關係，融合高潮幾乎每次都會發生，但刺激G點時也會產生高潮，尤其是對會射精的女型到所以述摩用殖。性而言。

我們假設G點是神經的中心或是這類高潮的刺激焦點，骨盆神經和下腹神經叢提供主要的神經路徑。雖然鄰近的骨盆結構包括陰道上半部、膀胱、肌肉和其他支撐結構也會感受得到，但子宮為主要出現反應的部位，特別是射精的時候。

生過孩子的女性較能明確指出這種高潮與其他女性感受到的有何不同。這並不奇怪，因為許多女性都是在懷孕後，才清楚感受到子宮的存在。我們也訪問接受子宮摘除術的女性，她們說，高潮就發生在以前子宮在的地方。

辛格認為，「子宮」高潮是性行為的終點，能達到就足夠了。也就是只要有子宮高潮，就不會再想或再需要另一個高潮。提出人類性行為「兩極理論」（bipolar hypothesis）補強我們的連續理論（continuum theory）的史丹佛大學茱莉安·大衛森博士（Julian Davidson）提出一個假設，她認為這種高潮可能誘發了肌肉機制的反應。然而證據卻顯示，大多數人類的性行為是學習而來，而非受荷爾蒙或其他生理因素控制，培瑞和惠普認為，高潮的終點，可能也只是一種學習的行為。觀察射精女性的證據可以發現，一些女性在連續刺激G點的情形下，可以有「多次射精高潮」，持續長達一小時。



再回頭看一下上面的表格，理論上我們可以在連續高潮反應的兩端中找到「純粹」的個案，也就是參考值1的陰部和10的子宮，但我們相信，大多數的高潮常落在兩個極端之間。也就是說，大多數的高潮是融合型的，位於高潮連續序列中的任何一點上。例如，理論上列在連續列上參考值3的高潮，比參考值6的高潮有較多的陰蒂刺激。事實上，就如馬斯特和強生所言，性交時當會刺激到陰蒂體，也增加了融合型高潮概念的可信度。陰部和骨盆神經交互連結脊椎身體其他部位，某條神經接受到的性刺激，與身體其他部位的感覺混合，可能是融合高潮較為常見的原因之一。

拉達斯的第二個研究也提供不少證據。超過四分之三的受訪者指出，曾有一種以上的高潮經驗，其中超過四分之一則曾達到一種以上的陰道高潮。

高潮反應的表格主要是根據女性經驗而來，但我們也納入男性的反應。從內部器官來看，男女構造雖然不同，但只是男人沒有子宮和其他相關的生殖器官，但男女基本的神經分布和肌肉架構並沒有太大差異，只有外生殖器有明顯的不同。

我們的第一印象是大多數的男人都能很快學會「融合」高潮或典型的射

精高潮。有人認為射精高潮是生物本能，但這個理論卻忽略了大多數的男性都被教導過，大多是從同儕那裡學會如何自慰達到高潮。無論是自己打手槍學來的，還是校園裡的馬路消息，大部分的青春期男生都覺得射精才有男子氣概，射得愈多，才愈像個男人。

雖然大多數的男人都被訓練成認為只有射精才是真正高潮，但還是有其他人開始嘗試收縮恥骨骶骨肌忍住射精，配合女性的陰部高潮。另外還有人則認為深層、非突發性，體內骨盆神經緊繃，只滴出少量精液的高潮經驗，才是最高境界。很明顯，無論男人或女人，沒有哪一種高潮才是對的。然而，不論哪一種高潮的擁護者，教大家了解高潮有很多選擇和變化，才是真正有用的資訊。

馬斯特和強生已經告訴我們，至少「陰部」高潮在一次性交中，可以連續發生多次。因此大多數的權威學者認為理論上，女人可有多次高潮。

生物能量學派的理論認為，多次高潮是很表面的且沒有什麼實質效果，只在沒有興奮感，也無法達到完整高潮時才會產生。然後，參與拉達斯第一次研究中，卻有百分之七十二的受試者曾經歷過多次高潮，且其中百分之



七十五指出，高潮的感覺很自然，其中百分之四十二的受試者相信，生物能量分析曾增進她們多次高潮的經驗。受試者關於高潮的陳述與生物能量學派的理論矛盾，在培瑞和惠普理論出現前，很難找到合理的解釋。但他們提出的高潮反應連續理論中，可以發現多次高潮多發生在融合型的高潮中，不是只有陰蒂高潮才會發生。

女人可達到多次高潮，男人卻被認為做不到。然而最近卻有報告指出，男人也可達到多次高潮，有男性指出，他們經歷一連串，令人滿足的「深層」高潮，最後才射精。多次高潮得具備一些重要的先決條件：健康的恥骨肌，相信自己不必在第一次高潮後就放棄等。身體健康當然也有幫助。

從近期性學的研究結果中我們發現一件相當重要的事，我們可以從其他的研究中增加對性的了解。我們對於男性攝護腺的了解，啟發女性G點的了解，則讓我們重視檢視男性攝護腺在性愛歡愉上扮演的角色。

男女在高潮時很相像的一點是，都希望能讓全身深陷在高潮中。傳統的性學中，高潮（orgasm）和高點（climax）兩個字是可以互換的，沒有什麼

不同。但這樣的觀點卻忽略了另外一個性的連續反應，就是從高點到高潮。

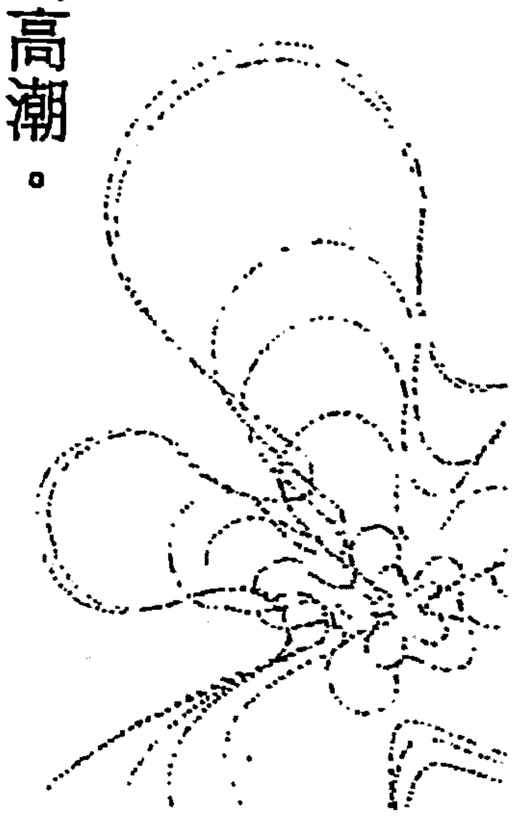
生物能量分析學派創始人威爾海姆·賴希（Wilhelm Reich）為高點下了定義，他認為，高點是生殖器的局部感受；高潮卻是肌肉和全身都參與的經驗，不只是下半身的感覺而已。二十二歲女性來諮商時明白指出兩者的不同：

一

我覺得克里夫跟我做愛時心不在焉，我一點都不喜歡跟他上床。當與奮到達最高點時，他的高潮來了，但卻不出聲，我聽不到，也感覺不到他的呼吸，所以事情都只發生在他的命根子上，真的讓我覺得好糗。我就正好相反，高潮時我會叫出聲音，身體像手風琴一樣折來拗去，雖然讓我覺得很爽，卻無法感受與他有任何關連。

賴希說，如果沒有全身投入，就不算真正的釋放，堆積的壓力會想要找出口，通常結果都不會太好。

一位接受生物能量分析諮商的男士說，每次做完愛後就會頭痛欲裂，聽歌劇時也頭痛，因為歌聲喚起做愛時全身「震動」的強烈反應。透過治療消



除枕骨的緊張後，從此能享受做愛和欣賞歌劇的樂趣，不會再頭痛了。

雖然詩人和愛情故事中曾經提到這位男士所謂的「震動」，但這個字眼，過去從來沒有出現在性學文獻中。亞歷山大和萊絲莉洛文的著作《活力的關鍵……健康的身體無論睡著或醒著，都必須持續律動……。要活就要動；只有死者才不動。」

《活力之路》（*The Way to Vibrant Health*）一書中就提到，「律動是活力的

一位女性寫道：

我發現做愛時雙腿的自由很重要……它們要能動來動去，我才能達到高潮。一旦達到高點，腿會不自主震動，高潮隨之發生。如果我的腿被壓住，上半身就會搖晃，感覺就沒有那麼強烈，快感也不夠。

洛文補充，性的愉悅與溫柔和「心」的感覺有關。就像一位男士所言：

高點是種性緊張的釋放，當我放入感情時，才能帶給我更滿足的高潮。

界。

然而，洛文所說的滿足，是一種完全釋放的充實感，是另一個愉悅的境身，。若只有部分生殖器或骨盆的肌肉，在長時間痙攣後放鬆，而不是遍布全，會讓人感到不夠滿足。

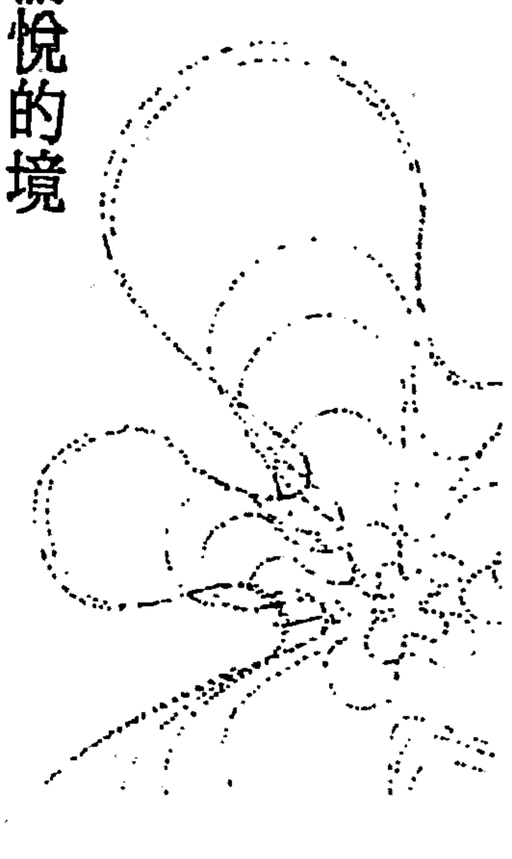
當我們問到是否能區分高點和高潮時，一位女士寫道：

一

高點——只有生殖器部位有感覺，從陰蒂開始，雖然感覺很棒，但身體其他地方不覺得滿足。高潮——從身體內部產生，會流往頭、手和腳，全身都在最亢奮的時候，就會刺激心底深處愛或悲傷的感覺，可能哭著收場。

其他男性和女性的說法如下：

高點通常是在陰道發生，腹部會收縮，還會流出熱熱的液體。高潮則是往上衝到全身，一種甜美令人酥軟的感覺。像全身塗滿了蜂蜜，在感情、精神和生理上都是享受。



高點是陰莖的快感，高潮卻強烈到全身器官都能感受得到。

高點——是高潮前，性興奮的小山峰。高潮——高點之後川流不息的情緒。

高點無法帶給我滿足，高潮卻能給我完全釋放的感覺。

我能清楚感覺到高潮在我體內上下遊走，我一點都不想讓它停下來。

換句話說，許多人所謂「不是很好的高潮」應該指的是高點。

艾莉絲·拉達斯第二次問卷調查的一百三十一位受訪者中，有六十人明確指出高點和高潮的不同。其中約有百分之九十特別點出高潮包含全身不自主的收縮，也投入更多的感情，呼吸也更深。百分之八十則指出，會不自主發出聲音。

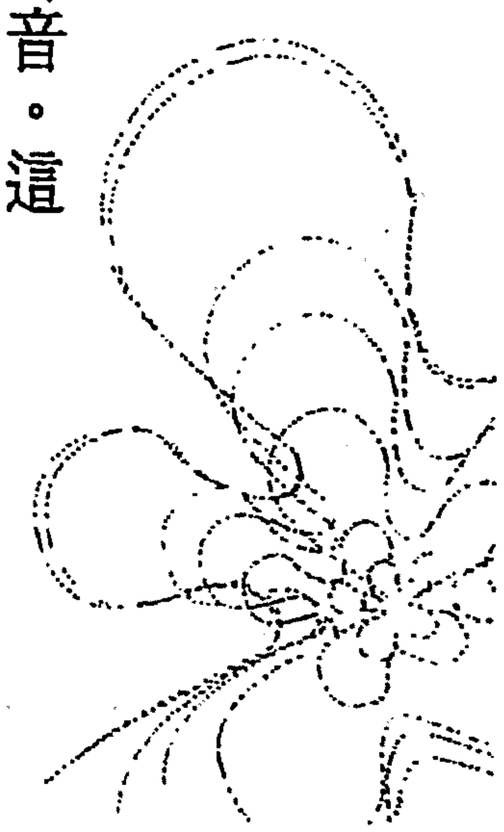
為了讓全身更投入痙攣性的收縮，同時釋放能量，不只要能自由的放鬆

和收縮肌肉，還要能自由呼吸，這樣也有助於在做愛時自在的發出聲音。這種放開一切的態度可以讓人在性伴侶面前比較不那麼害羞，也可能體驗身體的感覺。

培瑞和惠普的雙神經系統理論可以解釋，上三分之一恥骨骶骨肌和子宮的神經訊號傳導與高點的關係；骨盆神經將訊號傳到身體其他部位，可能是部分的人可以明確區分高潮和高點不同的原因之一。拉達斯研究中的受訪者指出，身體其他部位的亢奮，可增加快感，使關係更有意義、更充實也更放鬆。

許多的團體調查不熟悉賴奇和洛文的研究，因此需要更進一步釐清高潮和高點的不同，及與雙神經系統的關係。現在，不論男女，許多人都意識到兩者的不同，發現所謂的高潮應該比局部高點更令人滿足。

我們有許多高潮經驗的連續序列，人們決定高潮的喜好，而這些高潮照例都可在連續序列找到對應位置。我們沒有任何價值判斷，我們只希望大家了解自己的選擇，和達到高潮的不同方法。雖然我們前面已經說過，但還是值得一再提醒，不要用本書中的內容為你或你的性伴侶設定新標準，如果你這麼做，就只會破壞你早就擁有的性福。



# 第六章

## 完美不見得會更好

我們呈現的事實，是性高潮經驗的各種面向，例如我們希望會射精的女性知道這是一種自然反應，應該書中的知識不應該形成非得照做不可的壓力。不射精的女性，也應接受事實，不要拚命想射精，也不用擔心自己不射精，就會讓自己或性伴侶喪失性愛中某些重要的樂趣。

到這裡，你已經讀了不少有關性生理方面的新資訊，一定也受到某些程度的影響。住在美國密蘇里，一位三十六歲、結婚十四年女士的故事，應該可以讓你鬆口氣：

我做愛時會射出液體，無論是前戲或是性交時都會，我一直覺得很奇怪。射出的液體聞起來沒有什麼味道，顏色透明，所以我認為射出的液體應不是尿。我的確感受到你所說的那個點，丈夫依照我的反應找到它。我只是得寫信告訴你們，謝謝幫我找回自信，我相信還有很多像我這樣的女性，需要這樣的資訊。不過，雖然讀了你們的書，但我還沒找到解決「問題」的方法。

一位住在美國麻塞諸塞州的二十八歲女性也有類似反應，寄了長達五頁的信來，以下是部分內容：

四歲時，我躲在棉被下，用玩具熊的圓鼻子刺激那個特別的點，被我



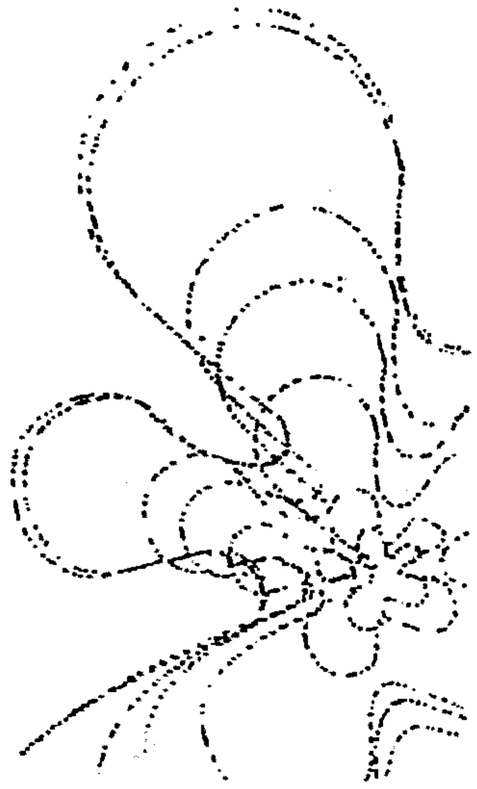
媽發現以後……就再沒見到那隻熊了。六歲時，我開始玩陰蒂，雖然感覺還不錯，但卻從沒帶給我全然的滿足。青少年時，跟同年紀的女孩子比較起來，我覺得自己跟她們不同。快二十歲時，我有一個交往穩定的男朋友。每週六早上媽媽去美容院做頭髮時，我和男友就在汽車後座做愛。他發現刺激「特別點」的方法，讓我可以達到多次高潮。我讀過金賽、馬斯特和強生的研究，嘗試陰蒂高潮，但卻做不到。二十二歲時，我注意到射出液體的問題，那時我百分之百認定自己不正常。接著，《海蒂報告》（*The Hite Report*）發表，確認一些我不願深究的事實，我更覺得自己的思想都跟一般女性不同。雖然外表女性化，想法卻比較像男人，我覺得我一定是個陰陽人。雖然我盡量不讓自己受到這個念頭的困擾，但第一次和丈夫做愛時，卻開始意識到自己的「問題」。我比他更早到達高潮時，他當場嚇得目瞪口呆，甚至可說是我的陰道把他推出去。我提到這些經歷，就是希望像我一樣與大多數人不同，被歸類為「異常」的可憐女孩，未來可免於被自我混淆的絕望感折磨。感謝老天，感謝你們的研究。

來自阿拉巴馬的一位女性來信提到：

怕」

的液體流了出來。我是一個求知若渴的讀者，這些年不斷找尋描述類似經驗的著作，卻什麼都沒發現。我想要丈夫讀一些關於性交和愛的書，但我從來沒拿給他，因為書裡總是在談女性的高潮時的收縮。他有時會有早洩的問題，我也希望他多讀點相關的資訊，讓他知道這是難免的，他並不是差勁的情人。可是我不能讓他看書，我怕他會讀到關於女性高潮的部分，發現我不只沒有高潮還尿出來，如果他真的這麼想，我真的會羞愧到死。這麼多年來，丈夫以為我的情形就是女人的高潮，因此一直以為我有「高潮」而十分興奮，但我知道根本不是這麼一回事。

現在我總算可以放心了，覺得自己還算正常，終於再也不用隱藏自己滿足和愉悅的強烈感覺，可以與丈夫盡情放鬆，享受魚水之歡。



除了鬆了一口氣，你也可能像這位二十七歲，來自美國懷俄明的男性一樣覺得興奮，等不及想和性伴侶一起探索性愛的新樂趣。

我太太喬安娜只能透過口交或手淫陰蒂達到高潮，以前我們沒聽說女性射精。我們第一次聽說後就開始實驗，一個月後，喬安娜在上位時，出現一些牛奶狀的液體，我安撫她，鼓勵她盡情享受。之後我們做愛時，喬安娜的反應變得更好了。

一位與同性伴侶生活十五年的女性說也有類似的經驗：

蘇珊娜和我對你們提到的G點十分感興趣，我們藉由幫彼此刺激G點，得到許多過去從未發現的新快感。我們也變得更大膽，讓手指在陰道內盡情探索。

四十八歲，住在亞歷桑納州的男士來信說：

但以前我從書上只學到這一招。當我們知道如何找出G點時，就開始實驗，性生活變得跟新婚時一樣興奮刺激。

認識G點真的幫了我們大忙。我太太唐娜一向不喜歡我玩她的陰蒂，

住在愛荷華州，一位育有四子的二十七歲女士來信說：

知道自己是正常的感覺真好。多年來我一直認為……性愛就只是如此嗎？但我發現有你們說的G點以後，輕鬆了許多。我很高興知道，除了媽媽告訴我們的以外，性愛還有廣大的世界等著我們探索。

或許你不覺得興奮，也沒鬆了口氣，而是有了新發現。你可能像這位來自南卡羅萊納的婦女，恥骨骶骨肌狀態不好，看了我們的資料後，開始運動恥骨骶骨肌：

當我得知肌肉狀態的重要性以後，我回想自己的病史……第二胎難產



後，我大笑或咳嗽時就會漏尿。謝謝你們絕佳的指導，我開始自己練習恥骨骶骨肌運動，兩個月內，我可以放心的咳嗽、打噴嚏或大笑。我不再用衛生護墊以防萬一，因為已經不需要了。

或者你的反應比較像這位住在緬因州的男士：

讀了肌肉健康的重要性後，對我們真的很有幫助。金生了第三胎後，對我來說，做愛的快感似乎變少了。金的陰道太大且鬆軟，是因為生孩子才變成這樣，我如果抱怨，對她很不公平，也沒有其他的法子可想。聽說你們的研究之後，我鼓起勇氣告訴金，做凱格爾運動可能有幫助。甚至當我的陰莖在陰道裡時，她都不忘練習。哇，差別真的很大。後來我發現，那段時間金也無法從性愛中得到滿足，現在我們已重拾過去的美好時光。

又或者你也像這位太太已經六十五歲的七十歲男士，照著新知行動：

的問題。過去幾年，瑪莉很難透過性交到達高潮，這是在新婚時根本不會發生對瑪莉很有幫助。如果我只執著於生殖器的交合而排除陰蒂刺激，根本不會有勇氣嘗試新的探索。

一對夫妻來信提到，他們為了探索辛格（Singer）所謂的融合型高潮，決定買生命中第一支按摩棒：

我們郵購了一支按摩棒，所以可以在吉姆的陰莖插入陰道時，還能同時持續刺激陰蒂。我們其實不是一定得用按摩棒才能辦事，但它能為我們比較傳統的性愛帶來舒服的震動。

自喻為情聖唐璜的男士抱怨我們的研究，洩露了他的祕密：

二十五年來，我努力發掘男女性愛的祕訣，熟練床上功夫，把自己變



成箇中高手，社交和性生活才能如此活躍。但你們的研究和著作，洩露我珍藏多年，價值非凡的商業機密。

這位風流男士不太清楚，他無論過去、現在或未來都不是唯一保有「祕密」的人。下面這對老夫老妻的來信，就是最好的證明：

我的天啊！你們這些人直到現在才發現G點嗎？我太太和我結婚五十一年了，新婚不到半年，就發現這個特殊的部位。我們為它取名為「兔鼻子」，現在也還是一樣。我七十六歲了，太太六十九歲，做愛的情況不同，不見得每次都可以達到高潮，但至少高潮的機率達百分之九十。

——

有些人，像下面這位來信的男士一樣，覺得需要提醒我們，小心研究帶來的負面影響：

不幸的是，你們無法控制人們如何使用或理解這些資訊。新的知識可

能帶給我們這種面臨性愛就緊張的人更多壓力。

他說得很對，不是每個人都會對「新事物」感到興奮。只有兩封信表達不滿，他們認為這些資訊應該只能在「診間、私人會議或是閉路電視上討論。」但有幾個人像這位來自賓州的三十二歲女士一樣，來信表達他們面臨的新壓力：

我先生習慣在做愛時問：「你興奮嗎？你高潮了嗎？」我實在不喜歡這樣的。應該不用開口問就能感覺到才對，一問就像要我趕快達到高潮似的。現在你猜他說什麼？「你射精了嗎？射了嗎？」我真想揍他……但我已經夠糟了，現在我還要得會射精才行。

一位住在南達科他州的美國原住民認為，新的研究發現破壞她的平衡：



現在我丈夫堅持，每個女人都有G點。昨晚他花了一個小時幫我找G點。拜讀你們的大作之前，我一直很滿足陰蒂刺激的快感，雷蒙也對我們的性生活感到滿意。但現在，他卻熱衷於探索新的方法，所以我們一天到晚吵得不可開交。

而一位二十五歲的男士來信抗議：

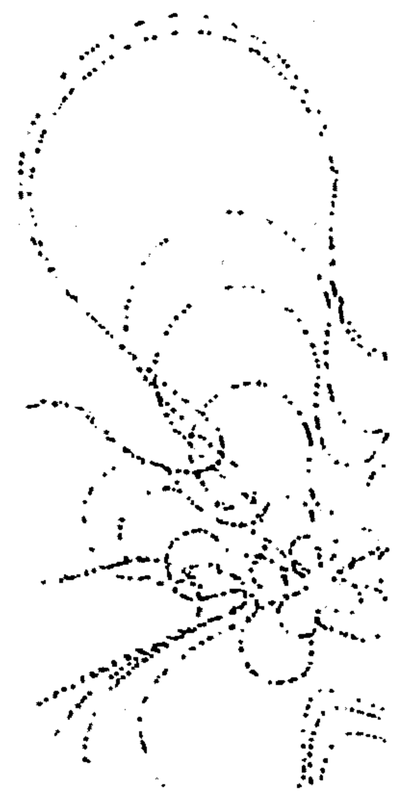
自從我太太知道G點和女性射精後，她不再讓我用手指或舌頭玩她的陰蒂，她以前明明很喜歡的。但現在她堅持我們要有性交，不需要太多前戲，偏偏我自己很喜歡前戲。她罵我不夠努力，沒有幫她射精，是個壞情人。或許我不是世界上撐得最久的男人，但我也沒有早洩啊！為什麼你們要來破壞我們的樂趣呢？

若把這些來信都歸納成少數的例外，並非常態，他們的反應顯示極不常見的敵意或是溝通不良，可能會讓我們心裡覺得比較舒坦。然而，雖然這類

來信實在不多，但很不幸的，這類意見卻也顯示出，類似的想法應該不少。

照章行事是壓力的來源之一。我們身處一個光說不練，口惠而實不至的文化中，嘴上讚揚個人主義與標新立異，鼓勵人們「要有自己的風格」、「要有原創性」、做自己；但實際上，每個團體和社群都有不成文的規定，即使是叛逆分子，性開放者、隨心所欲的嬉皮，都有自己的遊戲規則。有些場合我們會覺得自己的穿著不夠時尚，有時則是過了頭，但無論哪種情形，都會讓人覺得格格不入。一些人認為固定上教堂值得嘉獎，另一群人卻嗤之以鼻。自由派的母親鼓勵兒子玩洋娃娃，但這樣可是會嚇壞傳統型的母親，她們比較喜歡讓孩子寫詩和玩棒球。有些社區認為同性戀跟犯罪沒兩樣；另外也有一些社區認為同性戀是美好的。試著想像你是個民主黨員，卻住在共和黨的社區裡；反之亦然。這種照著規則來的壓力，隨時隨地在我們身邊。

這本書有許多不同男女因為自身的性經驗與「應該」怎麼做不同，而感到困擾。有一些人談到相信自己不正常，但有一些人則像這位阿拉斯加的男士，決定放棄，不再多說些什麼：



我和我哥哥討論性愛。他談到用什麼方法可以讓他太太達到高潮。我說：「女人不會那樣做！」他說：「會，她們會。」我說：「你瘋了。」我們結束了這個話題，從此再沒談起。多年以後，我常常在和太太做愛時發現，有液體射出在我往上翹的陰莖上。就好像水槍射出的細水柱一樣，她大概可以出現三到六次不等。我第一次問她是不是有類似射精的反應，她答說，沒有，她沒注意到任何事。我說：「妳是指妳沒有感到有東西從妳體內射出來？」她說：「沒有，這一定是你自己想像的。」從此以後我不再說什麼。我注意到，內心也有定見，但我想，問再多次得到的答案應該都一樣，就從此不再過問。

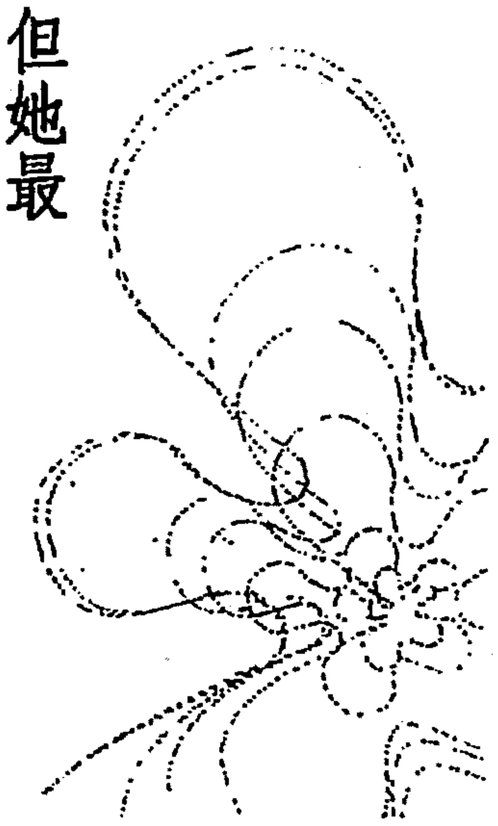
我們收到上千封的信，談到他們鼓起勇氣與人談性生活的經驗。下面是一位男士的來信，希望幫助跟他一樣，曾對自己與性伴侶感到困惑的人。

現在我知道為什麼前妻喜歡用某些姿勢或動作做愛。美滿的性生活，

曾讓我們的婚姻很幸福。希望不會因為我講的太寫實，冒犯大家，但她最喜歡的姿勢之一是，我躺在一張有椅背可以後傾的沙發搖椅上，然後她跨騎在我身上。椅子的搖晃和椅背後傾，增加動作的幅度。我們從沒跟任何人說過這件事。

我們擔心的是，這本書的資訊反而讓人弄巧成拙，一味只想嘗試新東西，卻破壞了原有的樂趣。G點和女性射精的資訊，除了豐富性生活外，的確可能讓很多讀者誤以為這樣才算是性愛「最高」境界，反而阻礙原有的性福。

我們並不想創造新的壓力，性愛應該是快樂的，但當它變成目標導向時，快樂通常就會消失。我們在這裡呈現的事實，是性高潮經驗的各種面向，例如我們希望會射精的女性知道這是一種自然反應，應該盡情享受。書中的知識不應該形成非得照做不可的壓力。不射精的女性，也應接受事實，不要拚命想射精，也不用擔心自己不射精，就會讓自己或性伴侶喪失性愛中某些重要的樂趣。



性愛是每個人生活中的一部分，人生來就是性的動物，不會改變，但如何表達卻是個人的選擇。性不只是生殖器的交媾而已，還包括撫摸、擁抱和許多其他的動作。擁抱、撫摸，有時可以讓人感到全心的滿足。達到高點或高潮並非性愛的終極目標。太多人對高潮有過當期待和想像，導致所有的男女交往，都硬要把上床這件事扯進來，這對感情反而是一種傷害。有些人則是認為無論多麼轟轟烈烈的感情，沒上床就不算完美，反而錯失許多只談感情的機會。

不能因為大多數的男人女人喜歡上床，就認為性才是一切。有些治療師相信，許多排斥性愛，或甚至不願與人產生親密關係的人，是因為童年或幼兒時期的打擊或傷害造成。

還是有許多獨身主義者自由自在的過著沒有性關係的生活。世人刻板的認為獨身主義者因為不得不做出退而求其次的錯誤決定，一定會很自卑，但這種想法不會讓他們活得更好。相反的，有些人並非自願過著無性的單身生活，只是礙於現狀，不得不勉強自己，但又苦於無法找到改變的可能性時，應求助專家。

女士說：

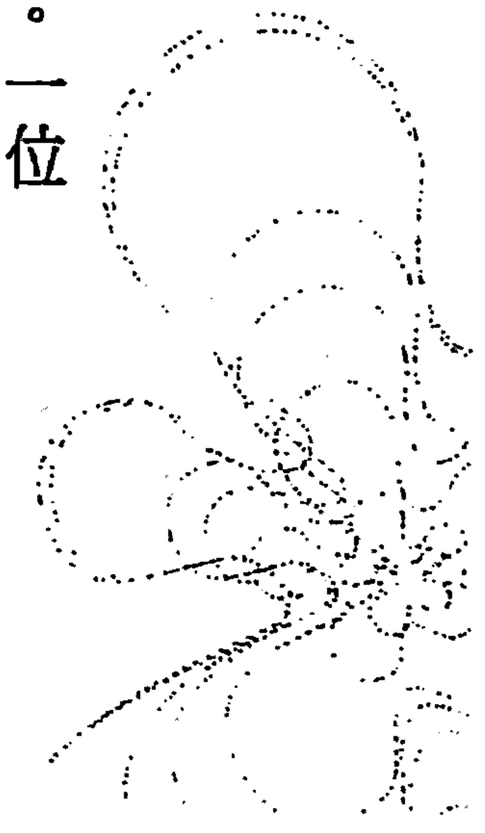
即使發生性關係符合雙方的期待，也不意味著要把高潮當成目標。一位

多年來，有沒有達到高點或高潮，兩者間是否不同的問題，已把我的生活弄得一團糟，感覺極度失調，後來，我決定不再理它了。

類似的情緒也在麥可．卡勒拉所著的《性：事實、行為和感覺》（*Sex, the Facts, the Acts and Your Feelings*）一書中也得到迴響。

問：高潮讓我覺得很棒，我也很享受，但是我一點也沒有雜誌或書上描寫的那種感覺，我應該接受治療嗎？

答：不用。大多數文章所描述的高潮建立在不切實際的標準和期待之上。我們總認為高潮應該是令人難以置信的爆發，拿自己的經驗比較以後，發現離「理想」十萬八千里。



切記，你和你的伴侶是否能從性愛中獲得滿足，才是重點。每個人對性行為是一種歡愉的經驗，不是要求特定結果的表演。快樂、享受、探索和分享比任何結果都重要得多。性愛可以直達內心最深處，碰觸我們最敏感的地方，任何新的資訊都不應該形成一種性愛壓力。

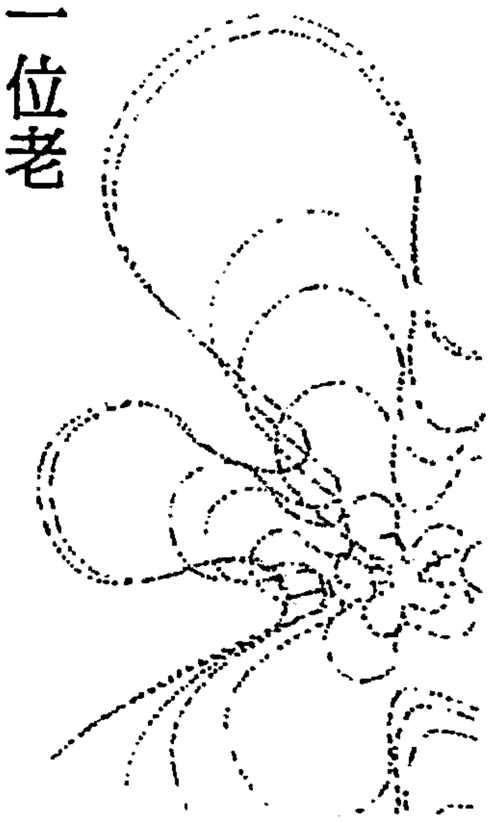
愛麗絲．拉達斯回憶小時候到朋友家玩，家具很豪華，但牆上卻空無一物。她好奇的問，為什麼房子裡沒掛任何一幅畫？主人回答說：「除非有林布蘭（Rembrandt）或魯本斯（Rubens）的名畫，否則我寧願什麼都不要掛。」這種追求完美的性格，往往是種阻礙。她朋友的父母堅持完美，寧願什麼都不要，結果就是住在一間無聊沉悶的房子裡。

不少神話、童話、歷史故事提醒我們，通往完美的道路上，都會有意想的反應也是獨一無二的。就算你讀到的絕妙高潮經驗是真的，但那是別人的高潮，不是你的，沒有人會有跟你產生一樣的高潮經驗。一心想著別人的性經驗，對你只有妨礙，沒有好處，你得跟著自己的感覺走。

不到的困難、貪婪和競爭，也都可能招致不幸。有一個故事，主角是一位老漁夫和他慾求不滿的妻子。一天，漁夫抓到了一隻神奇的魚，它求老漁夫放了它，只要放它自由，就可以實現老夫婦三個願望。老夫婦第一個願望只是希望有個小農舍，但太太覺得農舍太小，想要一棟宅邸，神魚實現了老夫婦的兩個願望。後來，太太又覺得不滿意，想要一座宮殿，神魚答應了，可是這座宮殿卻沒有想像中的豪華，太太堅持要漁夫跟魚許第四個願望，要一座更大的宮殿。終於，神魚受不了漁夫太太的需索無度，一氣之下，把夫妻送回原來住的泥磚小屋裡，什麼都沒有了。

我們身邊應該都有朋友因為一心追求完美，而有潰瘍、大腸炎、便祕或其他消化道不適症狀。現在愈來愈多的女性罹患心因性厭食症或其他原因不明的疾病，也都跟追求完美，或想更瘦有關。

作家、講師和演員，為了想要更融入角色，卻不經意的暗示一般人的生活平淡無奇，離理想境界還很遙遠。心理學家和婚姻家庭諮商師也都知道，許多夫妻因為覺得跟理想中的婚姻關係比較起來，還少了一點什麼，毅然決定離婚。他們寧願放棄近在眼前的好伴侶，去尋找心目中「最好的」那個



人，結果通常是繞了一圈回到原點，什麼都沒改變。

性是一個令人興奮的話題，即使談的不是「性」這件事本身，只是一些詞彙和圖片，也會吸引很多人的注意力。性愛文化的演進，都有一個獨尊的中心思想，從維多利亞時期的保守，到佛洛伊德的陰蒂——陰道轉移理論，到唯陰蒂獨尊，再到「給我高潮，其餘免談」的時代，最後走到唯性獨尊。我們現在應該融合各家學說，不要建立一個G點、女性射精、多次高潮、男性攝護腺等觀念獨大的時代。請記得每個人都是獨特的，不只跟別人不一樣，面臨生命中不同階段時，自己也會改變。即使兩個人有很多相似之處，也絕對不會過著一模一樣的生活。

我們不知道是否所有的女性都能有高潮。許多女性表示曾經有過某些形式的高潮。也有許多女性必須尋求專業協助，才讓自己第一次達到高潮，或產生更深刻的高潮反應，但是，我們要再次強調，即使有專業協助，有些女性還是不會有任何改變。

雖然一些性學研究者認為，無法達到高潮是不正常的，還替享受性愛卻無法達到高潮的女性貼上異常或官能障礙的標籤，但有些女性根本不相信這

種說法。也有一些備受尊敬的性研究者，支持女性不一定有高潮的說法。性學家西摩．費雪（Seymour Fisher）博士指出，「沒有證據顯示，倫．辛格．開普蘭就是其中之一，她認為，有一群女性的確沒有高潮反應，卻相當正常。

滿足感也是關鍵之一。許多女性表示，她們不用高潮，也可感到全心的滿足。性學家西摩．費雪（Seymour Fisher）博士指出，「沒有證據顯示，持續高潮的能力可以增強女性做愛的動機。」滿足感才是誘因。另一位性學研究者發現，與性伴侶的親密感才是性愛過程中最令人感到愉悅的部分，比持久或是高潮更重要，這個觀點也支持了費雪的結論。

一位男性患者問：

我就覺得她根本是為了迎合我才上床，我並不想要她這麼做。你的意思是如果珍妮佛沒有高潮時，我不應該生氣？她沒有高潮時，

珍妮佛回答：



真是胡說八道。高潮有時有，有時沒有，要看當時的狀況啊！我跟你說，有時我雖然沒有高潮，但卻跟你有合為一體的感覺。有時我有高潮，但感覺卻不是那麼好。我寧願沒有高潮，卻有親密感，所以別再一天到晚在乎有沒有高潮。高潮不是一切，它也不是你可以呼來喚去的，別再小題大作了。

四十二歲的女士說：

我生命中最銷魂的性經驗，都跟高潮無關。

性不是奧運競賽，沒有金、銀、銅牌。相反的，只要提供正確的資訊，和足夠的支持，讓大家發展獨特、個人化的性愛方式，並從中得到享受和滿足，每個人都可以是贏家。

二十五歲的女士說：

馬克陰莖碰擊我的陰蒂時，我會有高潮，但他在我體內時，用愛融化

了我，反而讓我更滿足。以這種方式達到高潮有點奇怪，但是我寧願選擇這種方式度過每一天，而不選大家認知中的「高潮」。

《海蒂報告》充滿許多相互矛盾的女性高潮經驗：「說高潮對女人不重要的人，一定是個男人。」接下來就會有人反駁，「女人為了表現高潮，承受很大壓力，尤其是性交的時候。」雪爾．海蒂（Shere Hite）觀察一些女性後發現，有些人還是難免受到社會壓力的影響，認為有高潮的女人比較像女人，是「真」女人。但其他的女性則認為，性愛中的高潮一點都不重要。

不難發現女人認同上述的任何一個或所有的觀點，或者是發現一位女性同時贊同這些觀點。四十八歲的葛瑞塔，經歷二次婚姻，她說：



當我好幾個星期都沒有高潮時，我覺得很糟，約翰也一樣。我好像比別人少，但我知道這不是事實。我一直很納悶，為什麼男女差這麼多，男人天生總是非常容易在性交時達到高潮，但女人就不一定了。

有些治療師懷疑這是一種文化誘發的現象，但我們沒有足夠的資料支持這樣的觀點。我們知道，許多女性有多次高潮，就像有些男人在性交時，有時選擇不在高潮射精，感覺更好。

精神醫師亞佛達．歐菲特（Avodah Offit）在她的《性自我》（*The Sexual Self*）一書中提醒，「我們可以告訴自己是誰，也可從我們的行為、思考、夢想獲得自信，散發性感。我們藉由不同的性行為，表達最自然的一面。」這句話就是描述性格不同的人，可能因為不同的問題和差異而感到困擾。我們陷入一種窠臼，認為世上沒有一個人可以贏，沒有人經歷過真正的歡愉、滿足和快樂，就算有，也很短暫。一般人也多認為，問題只會帶來負面的影響，這也就是為何許多精神醫學診斷手冊，都只強調負面的觀點。但若真是如此，我們如何解釋上千封性福夫妻的來信，寫著他們如何安靜私密的享受和探索自己性潛能？

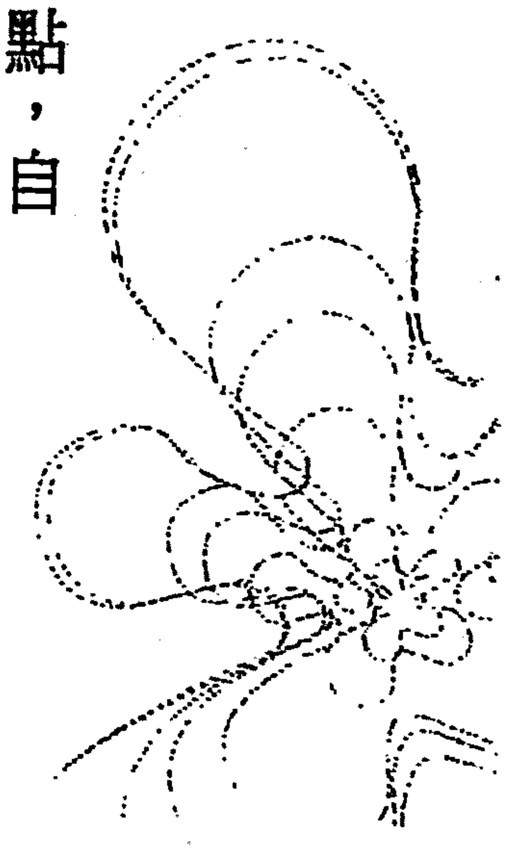
戴著有色眼鏡觀察，會看到不一樣的世界。無論生命的真相是什麼，淚眼婆娑看世界，就不可能帶來歡笑和快樂。過於強調正面的力量或許有點不

切實際，但是正面的態度的確可以放鬆自律神經，讓我們活得輕鬆一點，自然就能增加生活樂趣。

無論女性的高潮的真相為何，每個女人都有各種不同的可能，有些女性具有某些潛力，有些女性則沒有。無論是因為無法達到高潮而覺得挫折，或沒有高潮也有滿足感和快感，都要注意壓力對自律神經系統的影響，可能產生反效果。許多內分泌、大腦化學物質及不同的生活經驗，都會影響高潮，因此沒有人只靠自己的意志力行動就能達到高潮，性反應更沒有標準模式。

高潮，跟哺乳一樣，受許多因素影響，如果沒有外界干擾，身體自己會控制得很好。舉例來說，排乳反射（let-down reflex）對哺乳來說非常重要，心情要平靜，不能害怕，否則就算漲奶，壓力和緊張也會堵住出奶。性愛也是一樣，若心裡只想著要有超高水準演出，就無法持續享受性愛帶來的快樂。放手讓全身感官直覺主導一切，比較容易有高潮。但這並不意味不需要性教育，其實資訊和支援系統對健康的性愛反應也非常重要。我們要強調的是，一心只想著表現，想要「最好」，通常會讓你事與願違。

三大男高音之一帕華洛帝告訴我們他二十六歲時，還是個不紅的歌手，



他舉辦一系列免費巡迴演唱會。倒數第二場「簡直是場災難，我的聲音聽起來像是被勒住脖子的男中音」，他決定巡迴演唱結束後告別歌手生涯。但就在決定放棄後，最後一場演唱會竟然唱出如天籟般的聲音，他的演唱事業也就此展開。

馬斯特和強生發明的感覺集中練習可以幫助伴侶間克服性障礙，鼓勵男女將注意力集在性愛的過程，而非最後的結果。伴侶間要輪流愛撫對方，先撫摸不是高度性敏感的部位，再慢慢進行到敏感部位。剛開始，一方只專心感覺撫摸，稍後給對方鼓勵和回應。

這種方式可以讓彼此在不帶著指責和批評的情況下，了解對方不喜歡什麼，怎樣可以帶給對方快感，不是為了在某一段時間內創造性交高潮。隨便一個禪學大師都知道這個祕訣，專心於過程，會在無意識間，不花任何力氣，就得到想要的結果。美國職業網球選手提摩西．蓋洛威在《網球的內在遊戲》（*The Inner Game of Tennis*）一書中解釋：

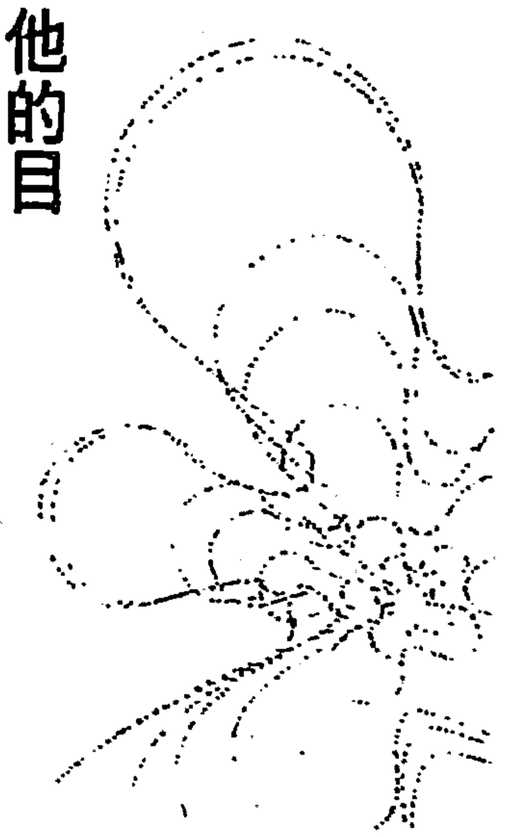
> 玩內心遊戲的選手眼裡，專心放鬆比其他任何技巧來得重要。他會發現

自信的真正基礎，並學到贏任何一場球賽的祕密是不要太拚命。他的目標是達到內心極度平靜，身心合而為一，不必刻意就能有水準表現……。

世界上，自然有效的學習和做事方式，比我們想像要多。這些方式我們也常用，只是很快就忘了，像小時候學走路和說話一樣，很自然，但怎麼學會的，長大後根本不記得。這就是無意識大於故意的「自我意識」；神經系統的脊椎和中腦（midbrain）比大腦皮質（cerebral cortex）重要得多。這個過程不必學，我們早就知道了。重點是，不要學會產生干擾的習慣，一切讓它自然發生吧！

到底什麼才是「最好」？它是種幻覺，是種遙不可及的絕對。一位傑出的藝術品交易商告訴我們他如何從一位知名畫家手裡搶救一幅油畫，這位畫家一次又一次不斷重畫，只想達到完美，這位交易商說：

「最好」這個字代表完美，也是陰險、墮落和無趣。「最好」是一種價值判斷，但你得問，是從哪一點來判斷。



「最好」是種理想，「好」則是踏實安全。「最好」總比敗在「最好」前面好。追求「最好」卻是高處不勝寒。當你達到目標，不再追尋，生活反而變得空虛。「最好」也否定努力的過程。一個人若氣餒不振，怎可能在人生中激出火花。

北極星指引方向，但不是最後的目標。海明威在《戰地鐘聲》（*For Whom the Bell Tolls*）中所描述的英雄和女英雄驚天動地，世界為之震動，但不表示每對愛侶每次做愛時都得讓自己像個英雄一樣，所向無敵。設定一個目標，要求每次都達到這個目標，只會帶來不快樂。驚天動地固然很好，卻不應當成目標，過高的期待到頭來可能是一場空。

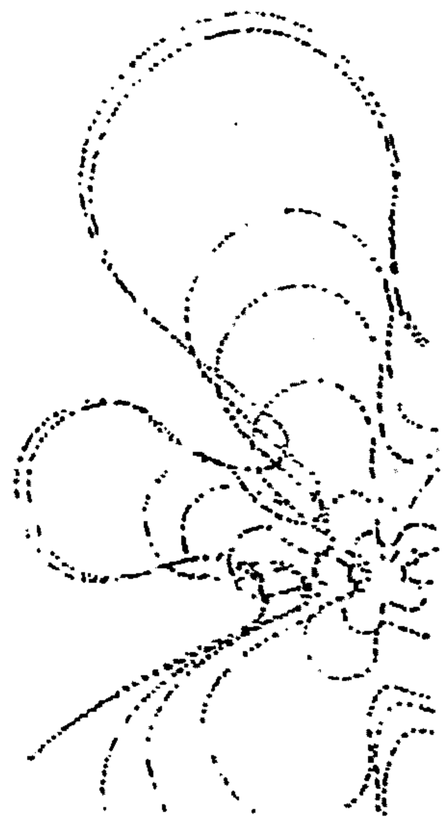
當然還是有些事情可以改進。努力求進步，可能慢慢向上修正，也比較實際。好的瑜伽教師告訴學員跟自己比較，依照自己的步調練習。內心滿足的人傾向設定程度合宜，按步就班的目標，也比較容易達成。但內心空虛的人，反而常有一個誇張的目標，也就是所謂的「最好」，他們不太可能達

成這樣的目標，當他們失敗時，最後往往只留下挫折和沮喪。

「最好」的概念，也會妨礙身體其他的感覺。拿比賽來說，勝利者是最後贏家，但從另一個觀點來看，他也是許多優秀但沒贏過比賽的參賽者的敵人。但也有一些例外，像美國甘迺迪家的小孩，特別是男孩，從小就接受菁英教育，其中不少也的確展現成就的野心。

對性愛而言，競爭不是重點，並不值得冒險追求最好的境界，一味的強求也難以達到目標。有時候，成功的祕密是什麼都不要做。順勢而為是生物回饋放鬆訓練、調解斡旋、甚至是功夫武術的成功關鍵。壓力研究之父漢斯・塞耶醫師（Hans Selye）就告訴我們：「承認世上沒有完美……。」

人人都會犯錯，但錯誤不見得就是批評或指責。不切實際或競爭心太強，才會導致批評和指責。假設你是一個跑步選手，八分鐘可以跑完一哩，你決定試試可不可以七分半內跑完，這還算是個滿合理的目標。但如果目標是想要贏得波士頓馬拉松比賽冠軍，除非你有適合的身體結構和天分，願意接受長期的體能訓練，否則就是一個不切實際的目標，註定會失敗。這個道理也可應用在性愛上，如果生理、心理都沒有準備好，是不可能一夜之間就



能達到射精的多次性高潮，這樣的目標只會帶來悲慘的結局。

「外國的月亮比較圓」的心態也很要不得。隔壁鄰居的所有事情都比我好嗎？太太比較美？朋友比較有錢？其實大多數人搞不清楚別人有什麼樣的經驗，才會覺得別人的都比較好。就算隔壁鄰居婚姻美滿，小孩聰明，還有最完美的性高潮，你也不會知道，你反而會追求一些比現在所有的更次級的事物。就算「外國的月亮真的比較圓」，比來比去對你一點幫助都沒有。

雖然有些人視性為一種具競爭性的活動，但不如把它看成是個人人都可以享受參與的活動還比較實際。不要覺得別人都享盡好處。讀了本書以後，你可以告訴自己：

我應該有更好的性經驗，更好的射精，更多和更好的高潮。

或者你可以認為有一些全新的領域，值得去探索。你學到一些以前不知道的事後，應評估身體能不能負荷，與伴侶間是否有能力做到。若你決定創造「超完美性經驗」，最後極可能以失望收場，甚至成為美好性愛絆腳石。

易改變。歐菲特說：「父母的管教模式，對人格特質的形塑影響深遠。」雖然我們可以換個角度觀察父母的管教方式，調整自己的反應，但還是沒有一個人可以回到過去，改變父母對待我們的態度。治療師其實也一再提醒，就算只是要改變對父母管教方式的觀點，也非常困難。

個人的生活。

但我們相信，還是有不少人可以持續使用本書的知識，改變他們的生全國各地的來信，就是最好的證明。讀者說：

問題比起刺激陰蒂，有些女人比較喜歡刺激陰道的感覺。不必擔心自己有現在了。

胎我知道肌肉狀態在性反應中非常重要，我正在鍛鍊我的恥骨骶骨肌，我知道許多女人會射精是很正常的事，我不會再覺得自己是個怪

我也不再因為自己做愛時反應不佳而感到羞愧無助。

我現在知道許多男性比較喜歡刺激攝護腺，而非刺激陰莖，我再也不會害怕開口請性伴侶幫我這麼做了。

還有更多更多的讀者來信，告訴我們書中資訊對他們的幫助。

大多數的人從來沒有，以後也不會去尋求治療師或臨床專業人員的協助。因為他們缺乏問題、動機、機會和金錢，但仍想要進步、改變或提升性生活的品質。或許你藉由陰蒂刺激可以達到高潮，但你也會想試試看陰道反應是否能達到一樣的效果。你會想要嘗試不同的姿勢，更自由的呼吸或是移動你的骨盆。或者你想試著改善骨盆內部或外部肌肉慢性痙攣的問題。

另一方面，或許你和你的伴侶享受陰蒂刺激的感覺。也有人未曾達到任何一種高潮，性生活卻相當美滿。與性伴侶配合良好，對探索新的性經驗不感興趣，那也沒有什麼關係。

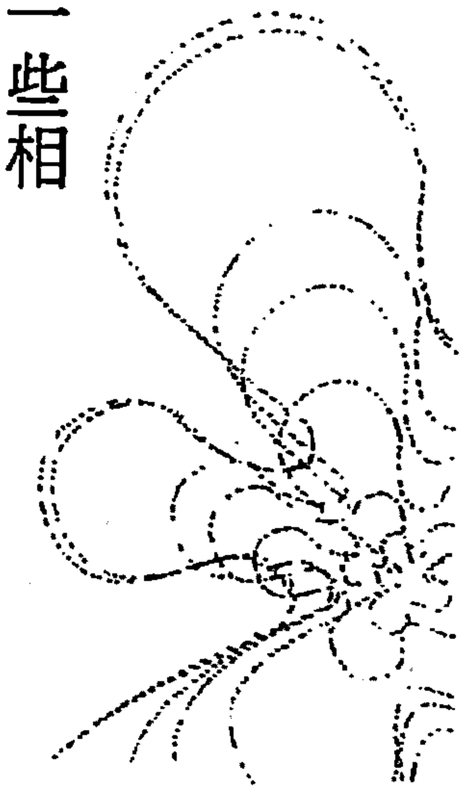
或許你是一個只要有性接觸就極度興奮的人，覺得自己總是慾火高張，

容易達到高潮，久久不退。如果真是如此，本書中的資訊，可以給你一些相當具建設性的建議。

過去幾十年，性的言論和興奮感把人沖昏頭了，雖是一種解放，卻也同時造成壓力。不只年輕人覺得一定要有活躍的性生活，還覺得這是件很流行的事；即使是年長的人也認為沒有性行為的話，一定有問題。

本書大部分的內容都是從女性的角度出發，其實也適用於男性。許多男人也跟女人一樣，想要也需要好好討論性事。有些男性高潮時，全身都有反應；但有些人想要學習如何達到多次高潮，其他則想要探索刺激攝護腺產生的快感。還有一些人需要親密擁抱。但對許多男人來說，這些事情都無足輕重，因為沒有所謂最好的性愛，有的只是許多美好及令人滿足的生活。

我們可以確定一件事，無論是性，還是其他事情，都有個別差異。金賽率先告訴我們，在性行為方面，什麼人對誰做了什麼事。性行為有優劣之分嗎？誰有資格評論別人呢？雖然我們選擇的性行為可以讓自己滿足，又不會傷結構、文化背景有關，但只要我們選擇的生活方式與生理遺傳、基本特質



害自己或其他人，就不應被質疑、評價或放在量尺中做優勝劣敗的比較。

許多男女讀了本書都會想要藉由刺激G點，探索高潮和女性射精的可性；也想知道更多自己骨盆肌肉或攝護腺的狀態。許多人想要發現他們是能提升自己的技巧，增進性愛的變化和快感，那就好好利用書中的資訊吧讓它支持你、引導你，但不要讓他控制你，或告訴你該如何做，如何感覺只要你承認，「完美不見得會更好」，就能將自己的經驗，昇華到完美。，否能的境界。

附錄

# 《女性和生物能量分析》的摘要、表格與結論

（*Women and Bioenergetic Analysis*）

愛麗絲·卡恩·拉達斯和哈洛·拉達斯◎著

然而引起性學研究者注意的觀點並非新理論，跟其他領域的科學發現一樣，發表後大家視而不見，包括：G點、女性射精、骨盆肌肉和持續的高潮反應。整合佛洛伊德與其他性學研究者的發現，成為容易又一致的理論。矛盾衝突在這裡獲得解決。

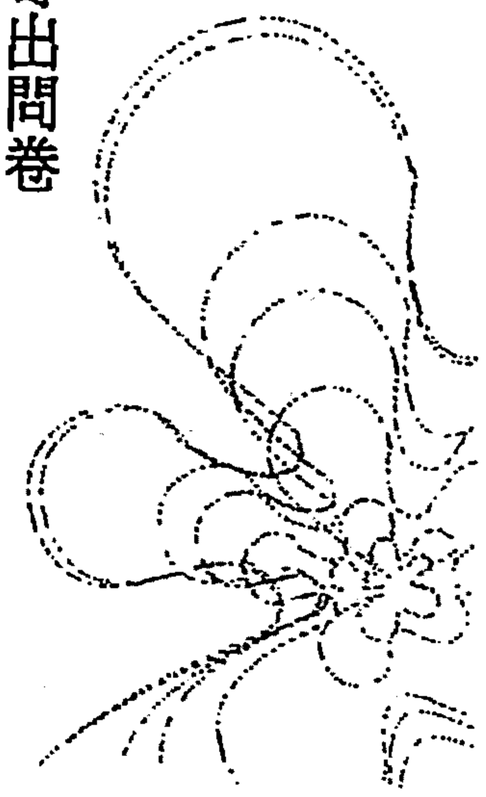
融合了陰道高潮還是陰蒂高潮，在這裡集大成。

摘要：研究對象為一九七七年生物能量分析學會全體女性會員一百九十八位，寄出問卷後，共回收一百三十四份有效問卷，回收率為百分之六十八。受試者均為生物能量分析學會會員。生物能量分析屬新佛洛伊德學派，是一種身體取向的心理治療。問卷題目涵蓋的領域包括：自身與病人的治療成效、生物能量理論的觀點評估、性觀念、經驗與習慣。問卷以異性戀觀點出發。

一如預測，百分之八十一的受訪者指出，治療後性生活獲得改善。但令人意外的是，百分之八十七的受訪者不同意生物能量分析創始人亞歷山大．洛文醫師提出的女性性行為理論。百分之七十三受訪者曾經歷陰道高潮，百分之八十七的受訪者卻覺得陰蒂也很重要，不應被忽視。

結論：很明顯的，女性不是生物能量分析的信徒，也增加這項研究許多正面發現的可信度。雖然受訪者不是完全認同生物能量分析的理論，但她們還是相信患者可藉著治療獲得幫助。此外，有百分之八十九的受訪女性認為接受生物能量分析治療後，自我肯定的能力增加，但是她們在會議或是著作中，仍難以表達自己反對的意見。這或許可能有一部分是政治的問題。

基本上，生物能量分析學會和它的地方分會，可說是現實社會的縮影，女性在真實社會中會碰到的困難，在學會裡也一樣會遇到。曾有一段時間，我們全都在重新思考性別角色。我們生活方式的觀念深深影響思考、行動和認知，因此要花很多時間才能開始改變，產生不同的理解和行為。有一種方法可以開始改變的過程，就是彼此交談、傾聽，開始對話。或許，這個研究能助大家一臂之力。



表二：女性生物能量分析成效研究（樣本數=134）

| 結 果 | 發現有幫助的相對百分比 | 發現有幫助的調整後百分比+ |
|---|---|---|
| 自我肯定 | 89 | 94 |
| 呼吸 | 89 | 94 |
| 自尊心 | 86 | 93 |
| 感受愉悅的能力 | 86 | 92 |
| 愛的能力 | 83 | 89 |
| 生理健康 | 79 | 74 |
| 排解沮喪的能力 | 79 | 84 |
| 緩解慢性肌肉緊張 | 77 | 83 |
| 能量水平 | 77 | 83 |
| 性關係中性與感情的融合 | 68 | 73 |
| 高潮時不自主的律動 | 63 | 67 |
| 尋找伴侶 | 45 | 49 |
| 睡眠問題 | 33 | 38 |
| 更年期* | 17 | 18 |
| 月經 | 16 | 17 |
| 與嬰兒的互動* | 7 | 7 |
| 克服不良習慣 | | |
| 暴飲暴食 | 23 | 30 |
| 吸菸 | 12 | 17 |
| 享受哺乳* | 5 | 6 |
| 選擇餵哺嬰兒的方式* | 5 | 6 |

註：* 大部分的受訪者回答「沒有這種情況」

+ 減去未回答的受訪者的百分比

表二 生物能量分析對性反應的治療效果

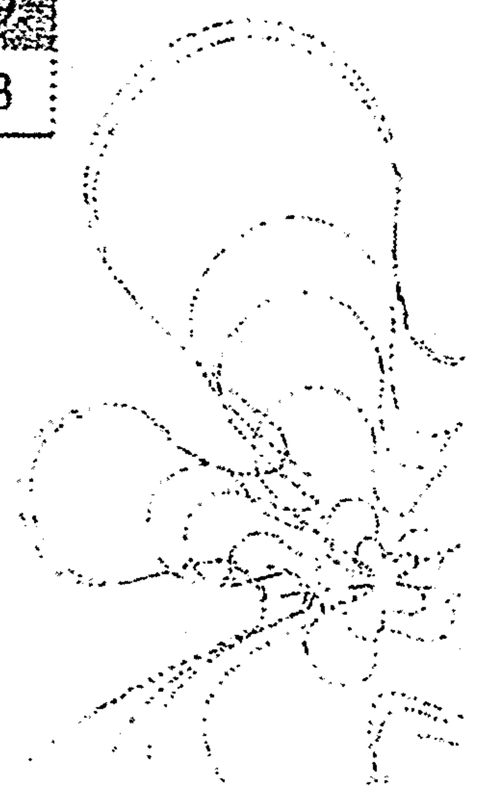
| 結　果 | 治療前 | | 治療後 | | 百分比變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 是 | 否 | 是 | 否 | |
| 生物能量分析後性高點是否產生變化？ | | | 81 | 19 | 81 |
| 如果是，如何變化： | | | | | |
| 產生更多身體反應 | | | 59 | | |
| 呼吸更深 | | | 62 | | |
| 骨盆可自由移動 | | | 54 | | |
| 骨盆會有更多的非自主性律動 | | | 43 | | |
| 性幻想變少 | | | 23 | | |
| 幸福感增加 | | | 45 | | |
| 以陰道為中心的感覺更深 | | | 41 | | |
| 你是否曾經有過性高潮？（相對於性高點而言） | 51 | 49 | 80 | 20 | 29 |
| 你是否曾經感到能量進著陰道進到陰道深處？ | 44 | 56 | 66 | 34 | 22 |
| 你曾感到液體的流動嗎？ | 36 | 64 | 76 | 24 | 40 |

註：百分比經過調整，未回答問題的個案已被刪除。

表三 女性對陰蒂的看法

| 結　果 | 治療前 | | 治療後 | |
|---|---|---|---|---|
| | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 你曾經透過下列方式達到性高點嗎？ | | | | |
| 未特別刺激陰蒂的性交 | 60 | 40 | 73 | 27 |
| 性交時伴侶刺激陰蒂 | 78 | 22 | 81 | 19 |
| 性交時自己刺激陰蒂 | 42 | 58 | 51 | 49 |
| 只刺激陰蒂未性交 | 83 | 17 | 87 | 13 |

註：百分比經過調整，未回答問題的個案已被刪除。



表四 對生物分析治療的看法

| 治療敘述 | 非常不同意 | 不同意 | 沒意見 | 同意 | 非常同意 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男人是女人通往外界的橋梁 | 62 | 24 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 86+ |
| 性交時無論直接或間接刺激陰蒂對成熟女性來說並不重要 | 51 | 36 | 2.4 | 10.3 | 5.3 | 87+ |
| 陰蒂高潮屬於陰道表面的感覺，像細微的甜美愉悅，卻沒有滿足感 | 43 | 35 | 5 | 10.0 | 1.5 | 78+ |
| 觸乳頭的刺激不是引發性興奮的主因 | 17 | 53 | 4 | 17.0 | 2.0 | 70+ |
| 男性若可配合女性延後到達高點的時間比較有幫助 | 6 | 6 | 10 | 58.0 | 19.0 | 77++ |
| 許多女性需要直接或間接陰蒂刺激以達到性高點 | 2 | 1 | 3 | 62.0 | 26.0 | 88++ |
| 為了雙方著想，需要時，男性應該幫助女性直接或間接刺激陰蒂 | — | 2 | 4 | 56.0 | 30.0 | 86++ |

註：百分比經過調整，未回答問題的個案已被刪除。

* 依亞歷山大．洛文在《愛與高潮》一書內容規畫的問題。

+ 非常不同意與不同意的總合。

++ 非常同意與同意的總合。

# 女性性行為問卷（進行中）

（目前處理樣本數＝131）

愛麗絲・拉達斯



這是一份探索性的問卷，我們想藉此了解專業人員的想法。我們無意用這份問卷找出專業人員的平均數或是變數。除非另有說明，否則粗體數字都是代表百分比。百分比加總後不等於百分之百時，代表有些受訪者自行增加了選項（註：有＊此一符號的問題，數字代表回答人數，非百分比）。

注意：如果你是女性，請自己回答所有的問題。有些問題與性伴侶有關。如果你是男性，請試著為你的女性伴侶回答。除了特別註明的題目之外，請勾選適當的敘述。

## ◎性別

□男性：19　□女性：81

## ◎性傾向

□異性戀：95　□同性戀：2

□雙性戀：4

回答人數：130人

回答人數：131人

**如果你能區別性高點和高潮，你認為不同之處為何？（單選）**

| | 高點 | 高潮 | 回答人數 |
|---|---|---|---|
| ㊀呼吸較深 | 14 | 57 | 7人 |
| ㊁全心投入 | 43 | 50 | 54人 |
| ㊂全身出現不自主的收縮 | 10 | 80 | 59人 |
| ㊃不自主發出聲音 | 3 | 92 | 63人 |
| ㊄不自主的收縮主要集中在骨盆部位 | 10 | 90 | 61人 |
| ㊅其他（請說明） | 12 | 87 | 60人 |

**陰道有任何感覺神經的末梢神經嗎？**

㊀有：56　㊁沒有：16　㊂不知道：28　回答人數：127人

**陰道內有一個或一個以上特別敏感的部位嗎？（可複選）**

㊀有：78　㊁沒有：12　㊂不知道：10　回答人數：101人

㊃一個：31　㊄兩個：40　㊅兩個以上：29　回答人數：55人

**性交時會刺激到性伴侶陰道的敏感部位嗎？**

圓會：71
圓不會：14
回答人數：21人

**性交時會刺激到你陰道裡的敏感部位嗎？**

圓會：46
回不會：6
□有時會：47
回答人數：93人

**哪一種姿勢最容易刺激到性敏感點？（可複選）**

□前方進入：67
□女性雙膝跪姿：24
□肛交：5
□背後進入——女性趴著：29
□背後進入——女性側躺：19
□其他（請說明）：10
回答人數：95人

**可以用手刺激到陰道內的敏感部位嗎？**

圓可以：58
□不可以：22
□不知道：20
回答人數：95人

**你認為有女性射精嗎？**

□有：32
□沒有：28
■不知道：39
回答人數：127人



● 你有女性射精的經驗嗎？

圓有：32

回沒有：73

回答人數：111人

● 你會射精嗎？

圓會：12

圓不確定：39

圓不會：37

回有時：12

回答人數：98人

● 你曾擔心在性興奮時尿失禁嗎？

圓是：42

回不是：57

回答人數：125人

● 你的性伴侶曾擔心在性興奮時尿失禁嗎？

圓是：16

回不是：18

回答人數：81人

● 你曾認為自己會在性高潮時尿失禁嗎？

圓是：31

回不是：69

回答人數：127人

**你曾認為性伴侶會在性高潮時尿失禁嗎？**

■是：11

□不是：88

回答人數：103人

**你認為自己曾因害怕尿失禁而故意不達到高潮嗎？**

■是：17

□不是：81

回答人數：121人

**若做愛時尿失禁，你有什麼感覺？**

□滿足：32

□羞愧：27

□其他（請說明）：39

回答人數：44人

**若你的性伴侶做愛時尿失禁，你會有什麼感覺？**

□滿足：32

□羞愧：3

□噁心：9

回答人數：34人

**身為女性若無特別的陰蒂刺激，你會達到性高點嗎？**

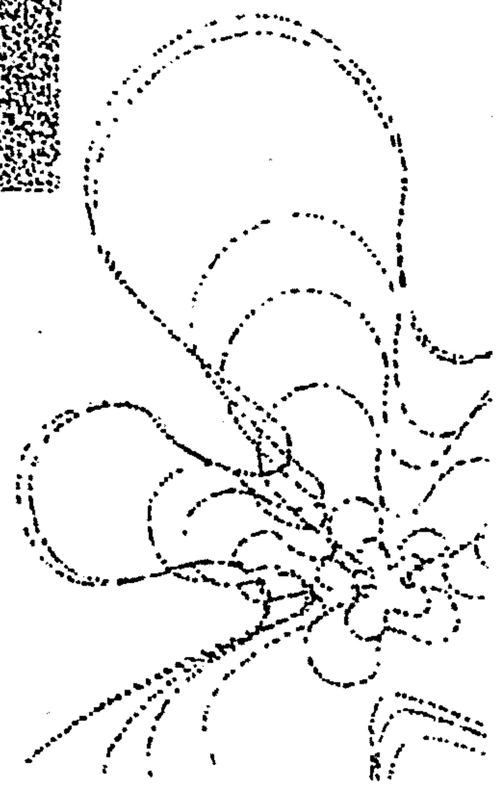
■會：40

註：40% + 35% = 75%

□不會：25

□有時會：35

回答人數：104人



● 身為男性，目前最重要的性伴侶，在沒有陰蒂刺激的情形下，會達到性高點嗎？

圖會：63　圖不會：29　圖有時會：4　回答人數：24人

● 你能區分陰蒂和陰道高潮嗎？

圖能：55　回不能：35　回不知道：10　回答人數：129人

● 你或你的性伴侶曾有過下列情形嗎？

回陰蒂高點：12　回陰道高點：8　回兩者都有：78　回答人數：107人

● 你或你的性伴侶若曾經歷過兩種性高點，較偏好哪一種？

回陰蒂：4　回陰道：37　回兩種都喜歡：58　回答人數：97人

● 你或你的性伴侶經歷過一種以上的性高點嗎？

圖是：26　回不是：32　回不知道：42　回答人數：107人

● 你和你的性伴侶所經歷的性高點是一起刺激陰蒂和陰道而產生的嗎？

圖是：84　回不是：7　回不知道：9　回答人數：121人

## 上一題的答案若為「是」，你或你的性伴侶喜歡哪一種？

■陰蒂：6

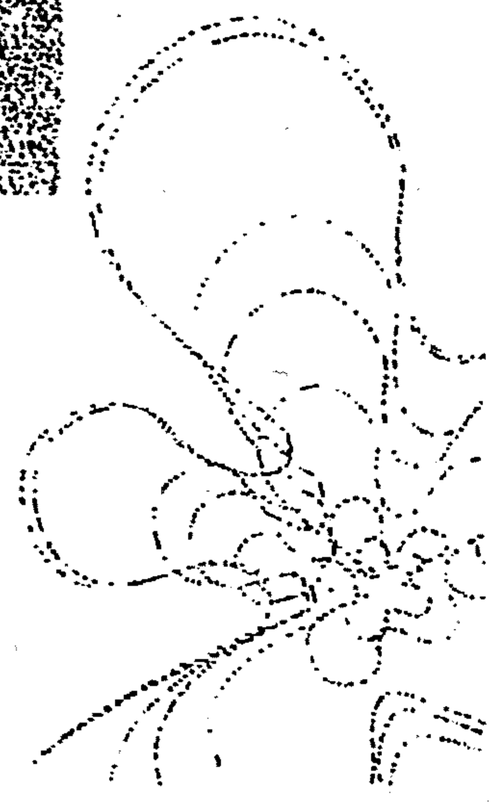
□陰道：22

□兩者融合：34

□三種都喜歡：35

回答人數：106人

註：34% + 35% = 69%



## 刺激陰蒂後，你或你的性伴侶會產生哪種情形？

□性高點：33

□不同時間產生高點和高潮：41

□都沒有：1

回答人數：111人

■全身性高潮：20

## 插入陰道時，你或你的性伴侶會產生哪種情形？

■性高點：8

□不同時間產生高點和高潮：36

□都沒有：23

回答人數：116人

□全身性高潮：30

## 一起刺激陰蒂和陰道插入時，你或你的性伴侶會產生哪種情形？

□性高點：10

□不同時間產生高點和高潮：43

□都沒有：9

回答人數：117人

□全身性高潮：34

● 你或你的性伴侶偏好下列哪種情形？

圖陰蒂刺激：7　回陰道刺激：17　圖都不喜歡：4　回都喜歡：70　回答人數：122人

● 你或你的性伴侶偏好下列哪種情形？

回性高點：6　回全身性高潮：49　□不同時間產生高點和高潮：41　回答人數：108人

● 你或你的性伴侶正在使用，或過去曾用過子宮帽嗎？

圖是：63　圖否：37　回答人數：123人

● 上題答案若為「是」，子宮帽是否會改變性交時的高潮經驗？

圖是：20　圖否：25　□有時候：21　回不知道：34　回答人數：87人

● 續上題，子宮帽如何改變性交時的高潮經驗？（可複選）＊

圖不易達到高潮　11
回完全無法達到高潮　6
圖高潮反應不夠強烈　20
回不會射精　0

**你或你的性伴侶是否曾經歷「內在」或陰道高潮，卻沒有全身性的高潮反應嗎？**

回答人數：109人

- 是：30
- 否：18
- 不知道：50



**如果你或你的性伴侶在陰道內有一個特別敏感的點，什麼是刺激到它的關鍵？（可複選）**

回答人數：50人

- 男性陰莖的長短：32
- 男性陰莖的粗細：25
- 陰莖勃起的角度：33
- 我是否使用子宮帽：11
- 用手指刺激：36
- 性交時的姿勢：77
- 性伴侶進入的深度：56
- 性伴侶移動骨盆的能力：55
- 我移動骨盆的能力：61

**如果陰莖長短是關鍵，怎樣的陰莖比較容易刺激到敏感點？**

回答人數：50人

- 短陰莖：0
- 長度中等的陰莖：32
- 長陰莖：44
- 不知道：20

## 如果陰莖粗細是關鍵，怎樣的陰莖比較容易刺激到敏感點？

- 細陰莖：2
- 中等的陰莖：30
- 粗陰莖：43
- 不知道：2

回答人數：44人

## 如果子宮帽是關鍵，怎樣才會比較容易刺激到敏感點？

- 使用子宮帽：0
- 不用子宮帽：96

回答人數：24人

## 如果手指刺激是關鍵，怎麼做容易刺激到敏感點？

- 用手指刺激：51
- 陰莖刺激：40
- 其他（請說明）：2

回答人數：47人

## 如果姿勢是關鍵，哪種姿勢比較容易刺激到敏感點？（可複選）*

| | |
|---|---|
| 女性在男性之上 | 18 |
| 男性在女性之上，兩人面對面 | 16 |
| 男性在上位，女性趴著 | 52 |
| 男性在上位，並採跪姿 | 49 |

※對這份問卷有其他意見或建議，請以文字敘述。

## 結論

本問卷提到的觀點，如陰道中的敏感點、女性射精、不同型態的高潮，過去一向遭反對或被忽略，但專業人員充實的問卷內容，反應出這些現象的確存在。因此這項研究的發現，驗證了培瑞和惠普在實驗室裡的研究結果，也強化我們對高潮連續反應的認知。



# 致謝

我們首先要感謝的是數千位民眾透過信件、訪談和問卷中與我們分享經驗，對本書貢獻良多，實在讓我們不知如何表達內心的感謝之情。

我們也要感謝本書編輯芭比．馬克，她對「過去美好時光」充滿懷舊的夢幻，從一開始她就全心投入，徹底了解性學領域。以編輯的創意，吃苦耐勞的精神，幫我們逐字逐句細心整理。

謝謝我們優秀的經紀人——海德．藍之，為我們找到芭比，指引我們走出出版事業這個迷宮。

感謝「沉默」的伙伴，哈洛．拉達斯，謝謝他對科學史和科學研究的遠見，有效解決衝突的能力，精明的生意頭腦。此外，他對寫作細節、研究和商業方面的關注，更為我們帶來莫大的幫助。

沒有芭比、海德和哈洛，本書無法付梓。

我們也要感謝艾柏塔和喬治．史邁勒、喬瑟芬．辛格、芭芭拉．薛佛，審

閱初稿，提出極有價值的指正。感謝投入寶貴時間的吉姆·惠普、引薦海德的喬治·巴克，樂於助人的優秀打字員佩特·史帝文生。同時一併感謝杭特學院圖書館的瑪格達·高慈曼與協助處理文書事務工作的凱薩琳·唐納文。

我們站在前人的肩膀上往前看，其中不乏知名學者，也有少數為人知或不為人知，我們在這裡感謝他們的啟發，學者名單如下：佛洛伊德、狄更生、哈維洛克·艾利斯、威爾漢姆·賴奇、恩斯特·葛瑞芬柏格、金賽、阿諾·凱格爾、馬斯特與強生、亞歷山大·洛文、艾德華·布萊契、約瑟芬與艾文辛格、隆德斯賽維利、J.W.班奈特、艾德溫·貝爾茲、法蘭克·亞迪耶哥、和海倫·羅賓生。

愛麗絲·拉達斯向丈夫哈洛，和女兒蘿賓與潘蜜拉致謝，感謝他們用愛與耐心，長期支持全心投入研究的妻子和母親。

比佛利·惠普感謝丈夫吉姆，孩子艾倫與蘇珊的愛、支持和鼓勵。她也感謝同事法蘭克·亞迪耶哥和麥可·培瑞提供專業意見、支持與鼓勵。

約翰·培瑞感謝卡洛琳·培瑞一開始對陰道肌動描計器研發的支持。培瑞也在這感謝麥德琳·丹尼爾注意到他的研究，讓他有機會向外推廣在新罕布什爾交叉點中心（Crossroads Center in New Hampshire）與英格蘭生物回饋學會（Biofeedback Society of New England）的研究成果。

性健康05

# G點：重新探索女性性高潮

The G Spot: And Other Discoveries about Human Sexuality


作　　者／愛麗絲・卡恩・拉達斯（Alice Kahn Ladas）
　　比佛利・惠普（Beverly Whipple）
　　約翰・戴伯特・培瑞（John D. Perry）
譯　　者／許傑明
責任編輯／潘玉女

行銷企畫／洪沛澤
行銷副理／王維君
業務經理／羅越華
副總編輯／潘玉女
總 編 輯／林小鈴
發 行 人／何飛鵬
出　　版／原水文化
　　台北市民生東路二段141號8樓
　　電話：（02）2500-7008　傳真：（02）2502-7676
　　E-mail：H2O@cite.com.tw　部落格：http://citeh2o.pixnet.net/blog/
發　　行／英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
　　台北市中山區民生東路二段141號11樓
　　書虫客服服務專線：02-25007718；25007719
　　24小時傳真專線：02-25001990；25001991
　　服務時間：週一至週五上午09:30～12:00；下午13:30～17:00
　　讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw
劃撥帳號／19863813；戶名：書虫股份有限公司
香港發行／城邦（香港）出版集團有限公司
　　香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓
　　電話：(852)2508-6231　傳真：(852)2578-9337
　　電郵：hkcite@biznetvigator.com
馬新發行／城邦（馬新）出版集團
　　41, Jalan Radin Anum, Bandar Baru Sri Petaling,
　　57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
　　電話：(603) 90578822　傳真：(603) 90576622
　　電郵：cite@cite.com.my

美術設計／江儀玲
內頁排版／紫翎電腦排版工作室
製版印刷／卡樂彩色製版印刷有限公司
初　　版／2015年3月19日
定　　價／300元

I S B N　978-986-5853-64-8



城邦讀書花園
www.cite.com.tw

Copyright© 2005 by Alice Kahn Ladas and Beverly Whipple. All rights reserved.

有著作權・翻印必究（缺頁或破損請寄回更換）

國家圖書館出版品預行編目資料

G點：重新探索女性性高潮 / 愛麗絲．卡恩．拉達斯（Alice Kahn Ladas），比佛利．惠普（Beverly Whipple），約翰．戴伯特．培瑞（John D. Perry）合著；許傑明譯. . -- 初版 . -- 臺北市：原水文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行, 2015.03

面；　公分 . -- （性健康系列；05）

譯自：The G spot : and other discoveries about human sexuality

ISBN 978-986-5853-64-8（平裝）

1. 性知識

429.1　　104003597